KHIDI
한국보건산업진흥원

Open Dialogue

지역사회 네트워크 미팅
교육훈련 및 실행지침

종사자 훈련도구

세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한
치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 훈련 도구

아주대학교병원 Ajou University Hospital
이음병원
한국오픈다이얼로그학회

Open Dialogue

지역사회 네트워크 미팅
교육훈련 및 실행지침

종사자 훈련도구

세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한
치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 훈련 도구

연구 책임자의 글

치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 5종을 소개하며

아주대학교병원과 이음병원 연구팀은 '세계보건기구 퀄리티타라이츠에 기반한 치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 개발' 사업의 결과물을 기쁜 마음으로 소개합니다.

2012년부터 세계보건기구(WHO)는 정신건강 서비스를 사람중심, 권리기반, 회복 지향적으로 변화시키기 위해 퀄리티타라이츠(QualityRights) 프로젝트를 진행해 왔습니다. 또한 대한민국 정부는 제 2차 정신건강복지 기본계획을 통해 정신장애 당사자의 권익 증진과 인권 강화에 힘써왔습니다. 특히 이후의 정신건강복지법 개정과 정신건강정책 혁신안을 통해 비강압치료, 절차조력, 동료지원 등 인권과 회복 기반의 서비스 조항이 추가되었고 최근에는 급성기치료환경 개선을 위한 논의가 이어지는 등, 현재는 새로운 돌봄의 구체적 적용을 위한 준비가 필요한 시점입니다.

그 일환으로 한국보건산업진흥원이 '세계보건기구 퀄리티타라이츠에 기반한 치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술 개발' 연구과제를 제안하여 본 연구팀이 지난 3년 동안 수행하였습니다. 이를 위해 정신건강 분야의 다학제 전문가들과 다분야 이해관계자들이 협력하여 한국의 문화와 의료환경에 맞도록 고안된 결과물을 개발했습니다. 구체적으로, WHO가 적극 권장하는 위기대응 서비스인 오픈 다이얼로그를 지역사회와 병원에서 실천하기 위한 각각의 훈련지침, 또한 당사자, 가족, 종사자가 함께 참여하여 회복을 논의하고 퇴원 계획을 수립하는 '퀄리티타라이츠 회복 퇴원 계획', 정신 응급 환자에게 강압적 처치가 아닌 대안적 방식의 돌봄을 제공할 수 있는 '고조완화기법', 그리고 산 경험을 지닌 동료지원가가 당사자의 법적 역량 발휘를 도울 수 있는 '동료지원 지원의사결정' 훈련도구를 동시에 개발하여 시험 운영이 이루어졌습니다.

저희 연구팀은 개발과 시험운영에 그치지 않고 2024년 11월 공청회를 개최하여 워크숍과 발제, 밀도 있는 토론을 통하여 전국에서 참석하신 당사자, 보호자, 그리고 전문가들의 다양한 목소리를 경청하였고 이를 반영한 수정보완 작업을 완료하였습니다. 그리고 이들 훈련도구의 도입과 실천을 위한 가이드라인을 첨부하였습니다. 한편 연구개발이 진행되는 3년 동안 국내의 정신건강 서비스 환경은 이전보다 훨씬 인권/회복 중심의 지역사회 서비스, 그리고 서비스 제공자와 이용자간의 협업을 통한 거버넌스를 강화하는 방향으로 급속도의 변화가 이루어지고 있습니다. 그러므로 이번 결과물이 이러한 시대적 요구에 부응하는 서비스 혁신을 위한 유용한 수단이 되리라 기대합니다.

연구 개발의 모든 과정을 지원하고 참여해 주신 전국의 당사자와 가족, 전문가 여러분, 보건복지부, 보건산업진흥원, 중앙정신건강복지사업지원단, 세계보건기구(WHO)를 비롯한 해외 전문가들께 깊은 감사를 드립니다. 이들 인권중심 중재기술 5종이 널리 보급되어 정신건강 분야의 모든 분이 영감과 희망을 얻고, 그것이 동력이 되어 사회 포용과 통합을 지향하는 정신건강 증진으로 나아가기 위한 가치 있는 마중물이 되기를 바라며 기쁜 마음으로 여러분께 전달드립니다.

주관연구기관 책임자 **아주대학교 노재성**
공동연구기관 책임자 **이음병원 정성권**
연구 코디네이터 **다원정신건강의학과 김성수**

WHO 퀄리티라이츠의 인문학적 의의

질병상황과 인간다움

인간이 질병을 경험한다는 것에는 적어도 세가지의 차원이 있고 영어로는 이것을 1) disease 2) illness 3) sickness 의 세가지 용어로 표현한다. Disease 는 의학적, 특히 병리학적 관점에서 질병을 보는 분류적 차원이다. Illness 는 병을 경험하는 환자의 주관성을 중심으로 개인이 겪는 아픔과 불편함을 말하는 차원이다. Sickness는 사회적, 문화적 측면에서 바라보는 질병인데 아픈 사람이 사회적으로 질병에 관하여 특정한 역할을 부여 받게 되는 차원을 의미한다.

인간이 아프다는 것은 주관적인 경험인 동시에 본질적으로 관계의 문제이고 사회적인 사건이며 이를 표현하거나 이해하기 위해서는 보다 복잡하고 다면적인 시각이 필요하다. 특히 질병 상황은 사람들이 살면서 겪게 되는 비일상적인 상황이다. 일상을 살아나가고 있는 사람이 어쩌다 아파서 의사를 만난다고 하는 것은 어느 누구도 겪고 싶지 않은 부정적인 비일상의 상황인 것이다. 이렇게 복잡한 차원의 비일상적인 질병 상황은 필연적으로 사람이 일상적으로 누리고 있었던 인간다움(humanness)의 위기 상황이기도 하다. 아픈 사람은 질병을 겪고 치료에 임하는 모든 과정에서 육체적인 고통 뿐 아니라 인간으로서의 존엄성과 가치에 대한 위기를 함께 느끼게 된다. 그러나 역설적으로 이러한 위기상황이야말로 인간다움을 가진다는 것이 얼마나 중요한 일이고 인간다움을 지켜나간다는 것이 얼마나 쉽지 않은 것인지를 잘 보여주는 기회가 된다. 특히 정신 건강에 심각한 위기를 맞이하게 되었을 때 모든 사람은 인간다움에 대한 중대한 도전에 직면하게 된다. 이런 도전에 응답하기 위해서 인간은 인간 사이의 관계를 통해 인간다움을 확인할 뿐 아니라 이를 지키기 위해서 더 많은 노력을 기울인다.

WHO 가 제시한 QualityRights를 이해하는 여러가지 관점이 있을 수 있다. 정신 질병에 대한 치료 과정에서 나타나는 인권 존중의 문제로 볼 수도 있고, 정신 건강을 회복 중심에서 바라보는 새로운 관점이 될 수도 있다. 그러나 그 가운데서 간과되어서는 안되는 중요한 한가지가 있다. 결국 QR 이라는 것은 질병을 겪는 인간이 비일상적 위기 상황에서도 인간다움을 지키고 인간으로 살아가는 방법에 대한 하나의 제안이라는 사실이다. 인간은 살아있을 때도, 아플 때도, 혹은 죽은 다음에도 인간다움을 잃지 않아야 한다. 만약에 그렇다면, QR은 단지 의사, 당사자, 가족들에게만 의미 있는 것은 아니다. 비일상적 질병상황의 가장 취약한 인간에게 인간다움이 지켜질 수 있다면 일상을 누리는 건강한 인간들의 인간다움 또한 언제나 존중받고 유지될 수 있다는 의미이기 때문이다.

물론 QR 은 정책적 제안이다. 그러나 이것은 법이나 규정의 차원에서만 이해되어서는 안된다. 동아시아적 관점에서 윤리는 인간이라는 종이 가지고 있는 보편적인 원칙, 즉 우리가 인간으로 살아가는 방법, 인간답게 살아가는 방법인 것이지 윤리의 최저선인 법으로 환원될 수 있는 것은 아니기 때문이다. QR을 인간이 질병상황에서 인간다움을 유지하면서 그 상황을 극복하는 방법에 대한 새로운 제안으로 본다면 이는 윤리적 차원의 문제이며 의료 제도나 치료 방법에서 흔히 회자되는 “효과성이나 비용절감 혹은 적용 가능성”보다 더 우선적이어야 한다는 것이다. 우리가 인간답게 일상을 살기 위해서는 심지어 비일상의 위기상황에서 조차 아무리 효과가 없고, 비용이 많이 들고, 적용이 어려워도 반드시 해야 하는 일들이 있다.

하나의 오해는 바로잡을 필요가 있다. QR의 목적은 당사자나 가족들의 건강이 위험해지는 질병 상황에서 어떠한 개입도 하지 말자는 뜻이 아니다. 인간답게 아플 수 있는 권리는 인간의 주체성을 바탕으로 하는 선택의 문제를 존중하자는 것이지 역설적으로 치료적인 개입을 모두 제한하는 방식으로 작동해서는 안된다는 점이다. 그래서, 만약 QR에 원칙이 있다면 그것은 질병상황에서 " 개인의 자유에 대한 최소한의 개입"이어야 한다. 다시 말해서, 당사자나 치료진이나 가족들 모두 최선을 다해 서로의 인간다움을 존중하면서 적절하게 혹은 최소한으로 개입하고 당사자가 결국 일상으로 돌아가도록 돕자는 것이 핵심이다.

QR을 한국적인 상황에 적용하고 보급하기 위한 이 연구는 다음과 같은 다섯가지 방향에서 전개 되었다.

1. 지역기반 네트워크 미팅
2. 병원기반 네트워크 미팅
3. 고조완화기법 : 안정화 치료
4. 동료지원 지원의사결정 서비스
5. 회복/퇴원 계획수립(퀄리티라이츠 리커버리 프로그램)

각각의 연구는 의학이 질병 중심에서 건강중심으로 바뀌고 의학의 비일상화를 극복하는 의학의 일상화라는 패러다임의 전환을 바탕으로 진행되었다. 다시 말해서, 질병이라는 특수상황을 극복하려는 노력은 특수상황을 제거하는 것이 아니라 일상을 회복하는 데서 가능할 수 있다는 사고적 전환을 의미한다.

인간다움이라는 관점에서 볼 때, Open Dialogue 는 인간의 고통(suffering)에 대한 가장 인간적인 대답인 대화를 중심으로 비일상적 상황을 극복하려는 노력이다. 고조완화 기법 혹은 안정화 치료는 인간의 원초적 본능인 폭력성(violence)조차도 가장 인간적인 방식으로 개입할 수 있다는 가능성을 보여주는 시도이다. 동료지원을 통한 절차조력은 고통 속에 있는 인간들이 서로의 연대(solidarity)를 확인하는 과정을 강조하며 결국 인간다움이 공동체를 통해 지지되고 실현될 수 있다는 점을 보여준다. 회복중심의 퇴원계획을 만들어 나가면서 치료진과 비일상 상황에 있는 당사자, 가족들 모두가 인간다움은 결국 일상에서 실현된다는 것을 인정하고 함께 만드는 노력의 방향을 설정할 수 있게 된다.

이런 연구를 통해서 우리는 QR 에 대한 연구가 단순히 정신건강과 치료의 의학적 차원을 넘어서서 보다 중요한 의미가 있음을 알게 되었다. 왜냐하면 인간다움의 문제는 인간학의 문제이고 공동체의 문제이고 문화의 문제이기 때문이다. 그렇다면 OD 를 통한 대화적 방법론은 사회전반의 문제에 이르기까지 여러가지 측면에서 다양하게 이해되고 적용되고 활용될 수 있을 것이고, 같은 생각을 가지고 같은 상황에 있는 사람들 뿐 아니라 전혀 다른 처지에 있는 사람들과도 인간다움을 바탕으로, 같은 목적을 위해 연대하고 협력하는 것이 가능해질 것이다.

아주대학교 의과대학 인문사회의학 교수 **김신권**

치료친화적 환경 조성을 위한

인권중심 중재기술 도입 가이드라인

훈련 도입에 대한 실용적 제언

본 가이드라인에 대하여

본 지침서를 포함하는 총 5종의 인권기반 중재기술 훈련도구/지침은 실제 정신건강 서비스 현장에 효과적으로 도입 및 실천되기 위한 목적으로 개발되었습니다 그러므로 기술을 교육하고 실천하고자 하는 기관이나 단체를 위한 실무적 가이드라인의 필요성이 존재합니다.

또한 정신건강서비스가 공적 자원을 기반으로 진행되므로 거시적 수준의 정책 또는 사업 지침과 맞물려 진행될 필요가 있다는 면에서, 이러한 교육훈련이 어떻게 정부 정책과 연동하며 그 구현을 촉진할 수 있는지에 대한 당위성이 제시되어야 합니다. 또한, 이 훈련도구의 핵심 기반이 인권/회복 기반의 정신건강 서비스 변혁을 지향하는 WHO 퀄리티라이츠이므로, 첫 실천단계부터 그 기본 철학에 따른 방향 설정이 필요합니다. 그리고 5종의 도구가 정신의료, 지역정신보건, 당사자/가족 운동 등 다양한 현장에서 적재적소에 효율적으로 도입되기 위해서는 각 훈련도구들의 단계적 도입 전략과 활용 방안이 마련될 필요가 있습니다. 나아가 이 교육훈련이 서비스 현장에서 지속적으로 작동하기 위해 필요한 자원과 정책이 무엇인지에 대한 제안도 필요합니다.

이 가이드라인은 위의 필요성에 부응하기 위하여 저희 연구 결과물의 시험 운영 경험, 연구 논문을 통해 획득된 지식, 워크숍과 공청회를 통하여 많은 이해관계자 분들로부터 얻은 피드백, 중앙/지방 정부의 정책 수립과 실천에 관여한 경험 등을 바탕으로 하여, 실제 현장에서 이 도구를 도입하고자 하시는 분들께 유용한 참고자료가 되는 것을 목표로 작성되었습니다.

1. 국가 정신건강정책과의 연동

2021년 보건복지부는 제2차 정신건강복지 기본계획을 발표하였습니다.

제 2차 정신건강복지 기본계획과의 연동

제 2차 정신건강복지 기본계획

보건복지부



비전	마음이 건강한 사회, 함께 사는 나라
정책 목표	Ⅰ. 코로나19 심리방역을 통한 대국민 회복탄력성 증진 Ⅱ. 전 국민이 언제든 필요한 정신건강서비스를 이용할 수 있는 환경조성 Ⅲ. 정신질환자의 중증도와 경과에 따른 맞춤형 치료환경 제공 Ⅳ. 정신질환자가 차별 경험 없이 지역사회 내 자립할 수 있도록 지원 Ⅴ. 약물중독, 이용장애 등에 대한 선제적 관리체계 마련 Ⅵ. 자살 충동, 자살 수단, 재시도 등 자살로부터 안전한 사회 구현

정책목표	전 략
전 국민 정신건강증진	1. 적극적 정신건강증진 분위기 조성 2. 대상자별 예방 접근성 제고 3. 트라우마 극복을 위한 대응역량 강화
정신의료 서비스 / 인프라 선진화	1. 정신질환 조기인지 및 개입 강화 2. 지역 기반 정신 응급 대응체계 구축 3. 치료 친화적 환경 조성 4. 집중 치료 및 지속 지원 등 치료 효과성 제고
지역사회 기반 정신질환자의 사회통합	1. 지역사회 기반 재활 프로그램 및 인프라 개선 2. 지역사회 내 자립 지원 3. 정신질환자 권익 신장 및 안권 강화
중독 및 디지털기기 이용장애 대응 강화	1. 알코올 중독자 치료 및 재활서비스 강화 2. 마약 등 약물중독 관리체계 구축 3. 디지털기기 등 이용장애 대응 강화
자살로부터 안전한 사회구현	1. 자살 고위험군 발굴과 위험요인 관리 2. 고위험군 지원 및 사후관리 3. 서비스 지원체계 개선
정신건강정책 발전을 위한 기반 구축	1. 정책 추진 거버넌스 강화 2. 정신건강관리 전문인력 양성 3. 공공자원 역량 강화 4. 통계 생산체계 정비 및 고도화 5. 정신건강분야 전략적 R&D 투자 강화

이 기본 계획에서는 정신질환자의 권익/인권 강화와 그에 따라 지역기반의 정신응급 대응체계를 구축하고, 치료친화적 환경을 조성하며 필요한 집중치료와 지속 지원을 제공할 것을 명시했습니다. 이러한 정책 방향은 보다 세부적인 실천계획으로 분류되는데, 본 연구개발에 기반하는 WHO 퀄리티라이츠 훈련도구와 모범사례에서 제시된 컨텐츠들은 각각의 실천이 효과적으로 이루어지기 위한 구체적 내용으로 이루어져 있습니다.

보건복지부 정책 및 적용 가능한 WHO QualityRights 컨텐츠

		2-2. 지역기반 정신응급체계 구축	2-3. 치료 친화적 환경조성	2-4. 집중치료 및 지속 지원 등 치료효과성 제고	3-3. 권익신장 및 인권 강화
보건복지부	2021~2025 정신건강복지 기본 계획	• 정신응급의료기관 확보	• 환자 · 의료진 안전	• 초발 및 급성기 환자 집중 지원 • 완치회복률 제고	• 정신질환자 권익보호 • 자기결정권 강화
		• 정신응급의료기관 지정 수가 시범사업('22)* • 기관별 특화, 정신응급환자 진료지침 제정('22)	• 정신의료기관 시설기준 강화('21. 3. 5. 시행) • 중증도 분류기준 마련 - 급성기 병동 - 회복기 병동 - 만성 재활병동 - 병동별 운영지침('22)	• 급성기치료 보상체계 시범 사업('22)* - 폐쇄병동 집중관리료 - 퇴원 전 사례관리 - 다학제 사례관리팀 - 집중사례관리	• 국공립정신병원 중심 - 동료 · 가족 지원가활동 우선 제공('22)
WHO	QualityRights 훈련도구		• 비강압치료 훈련모듈	• 회복치료 모듈	• 지적의사결정 (자기결정권) 모듈 • 동료지원 모듈
	지역정신 건강서비스 지침 모범사례	• 정신건강위기대응 모범사례 - 쉼터(Crisis center) - 오픈 다이얼로그	• 병원기반 서비스 모범 사례 - 비강압 / 오픈 다이얼로그 / 동료지원 적용 - 단기 집중치료 - 지역사회연결		• 동료지원 모범 사례

보건복지부 정책의 방향성 + WHO QR의 방향성

↓

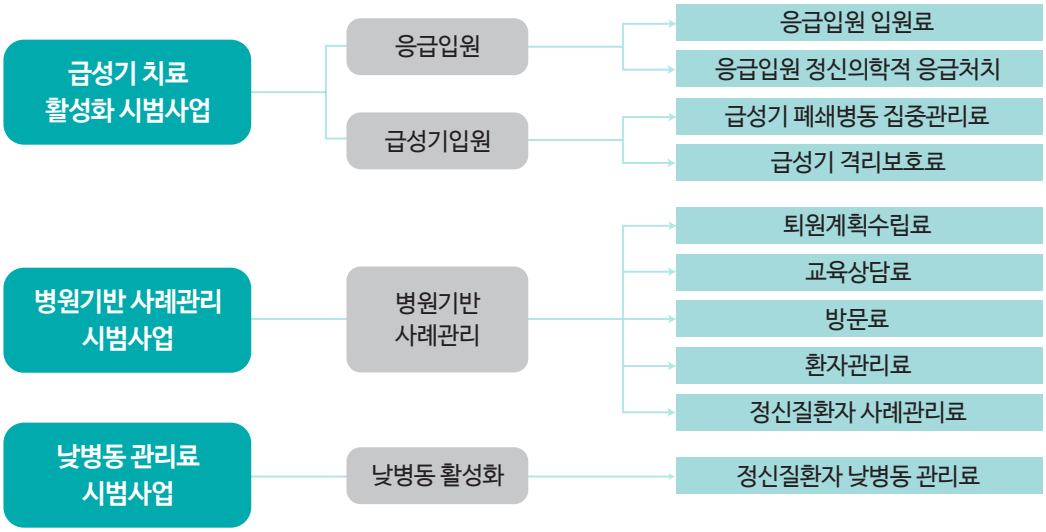
1) 오픈 다이얼로그
2) 비강압치료
3) 회복치료
4) 동료지원
5) 지원의사결정

본 연구개발의 결과물은 이러한 컨텐츠들을 시험 운영 등을 통한 번안 및 보완 과정을 거쳐 한국 서비스 환경에서 실용적으로 적용될 수 있도록 개발된 것으로서 정책이 현장에서 바로 구현될 수 있도록 하는 도구로서의 가치를 지닙니다.

또한 2023년의 정신건강복지법 일부 개정안에 절차조력과 동료지원 등의 항목이 포함되어 전국적 시행을 앞두고 있고, 같은 해에 발표된 정신건강정책 혁신방안에 비강압적 치료 도입이 명시되어 있는 점 등은 본 훈련도구의 신속한 보급이 필요하다는 당위성을 뒷받침합니다.

다른 한 편, 위의 정책과 병행하여 정신의료기관의 급성기 치료역량과 지역사회 연계를 강화하기 위한 정신질환자 지속치료 지원 시범사업이 진행되어 오면서 그 중 일부를 본 사업으로 확대하는 것에 대한 검토가 이루어지고 있습니다. 또한 급성기 병동 서비스를 어떻게 강화할 것인가에 대한 논의도 진행되고 있습니다.

급성기치료 활성화 / 병원기반 사례관리 정책을 위한 효과적 컨텐츠
: 구체적 치료행위(오픈 다이얼로그/비강압치료/회복 프로그램)**로 기능 가능**



정신질환자 중증도 분류기준 및 중증도별 병동 표준운영지침 마련 연구

	행위 관련 수가
표준운영병동	• 주당 정신치료 및 작업 및 오락 요법 회수 현실화
급성기 병동	• '급성기 정신질환 개인면담료(현재의 개인 정신치료 대체)', '급성기 입원 초기 평가료', '급성기 정신질환 간호 관리료' 등 정신과의사, 간호사 등의 인적 투입에 대한 보상 수가 신설 • 소그룹 대상으로 운영되는 전문화 집단 프로그램 및 새로 개발되는 비약물적 중재 프로그램에 대한 현실적인 신규 수가 개발 및 도입 • 지역사회 연계 서비스 수가 개발 (정신건강복지센터 의뢰 회송료, 재활시설 연개료, 퇴원사리관리료 등)

이 모든 변화는 급성기 정신의료 서비스의 질을 강화하는 방향으로 나아가고 있습니다.그러므로 이러한 정책이 실제로 임상을 개선시키며 지속 가능하도록 하기 위한 가장 효과적으로 실천가능한 서비스 행위들을 본 연구의 결과물이 제안하고 있습니다.

그러므로 정신의료기관, 정신건강복지센터 등의 정신건강증진시설에서 종사자 교육을 기획할 때에 위에 기술된 내용을 바탕으로 사업계획의 필요성을 강조하는 것이 도움이 될 것으로 판단됩니다.

2. 도입의 두 가지 핵심 지침

"여러 서비스는 동시에 서로 연동하여 실천되어야 한다"

본 5종의 도구 도입에 있어 가장 강조하고자 하는 첫 지침은 '여러 서비스가 동시에 이루어지고 서로 연동하여 실천되어야 한다'는 점입니다. 오픈 다이얼로그, 비강압(안정화)치료, 퀄리티라이츠 회복퇴원계획, 그리고 동료지원가에 의한 절차 조력은 각각 독립된 별도의 서비스가 아니라, 각 항목 하나 하나가 모두 당사자의 회복을 위해 필수적인 요소들입니다. 그리고 심리사회적 위기 상황에서 이 모든 것들이 동시에 서로 연동하면서 제공되어야 제 기능을 할 수 있습니다.

위기 당사자와 그를 돕는 가족과 종사자들이 개별 사례에서 필요한 요소를 도출하고 협력하기 위해서는 오픈 다이얼로그를 통한 연대 형성이 필수적입니다. 그러나 정신응급상황에서 안전 확보의 목적으로 강압적인 조치가 손쉽게 선택된다면 그러한 연대는 순식간에 와해될 것입니다. 그러므로 비강압치료를 지향하는 정중한 급성기입원 치료가 병행되어야 합니다. 또한 의학적 치료와 심리사회적 회복을 포함하는 모든 치료계획 수립과 실천이 일상적 진료와 지역사회 서비스에서 지속되도록 하는 퀄리티라이츠 회복퇴원계획 프로그램이 구체적인 실천 과정을 뒷받침합니다. 또한 회복의 산 경험을 가진 동료지원가들이 법적 역량 발휘와 회복 과정을 조력함으로써 공동체와의 연결이 완성되게 됩니다.

"여럿이 함께 익히고 협력한다"

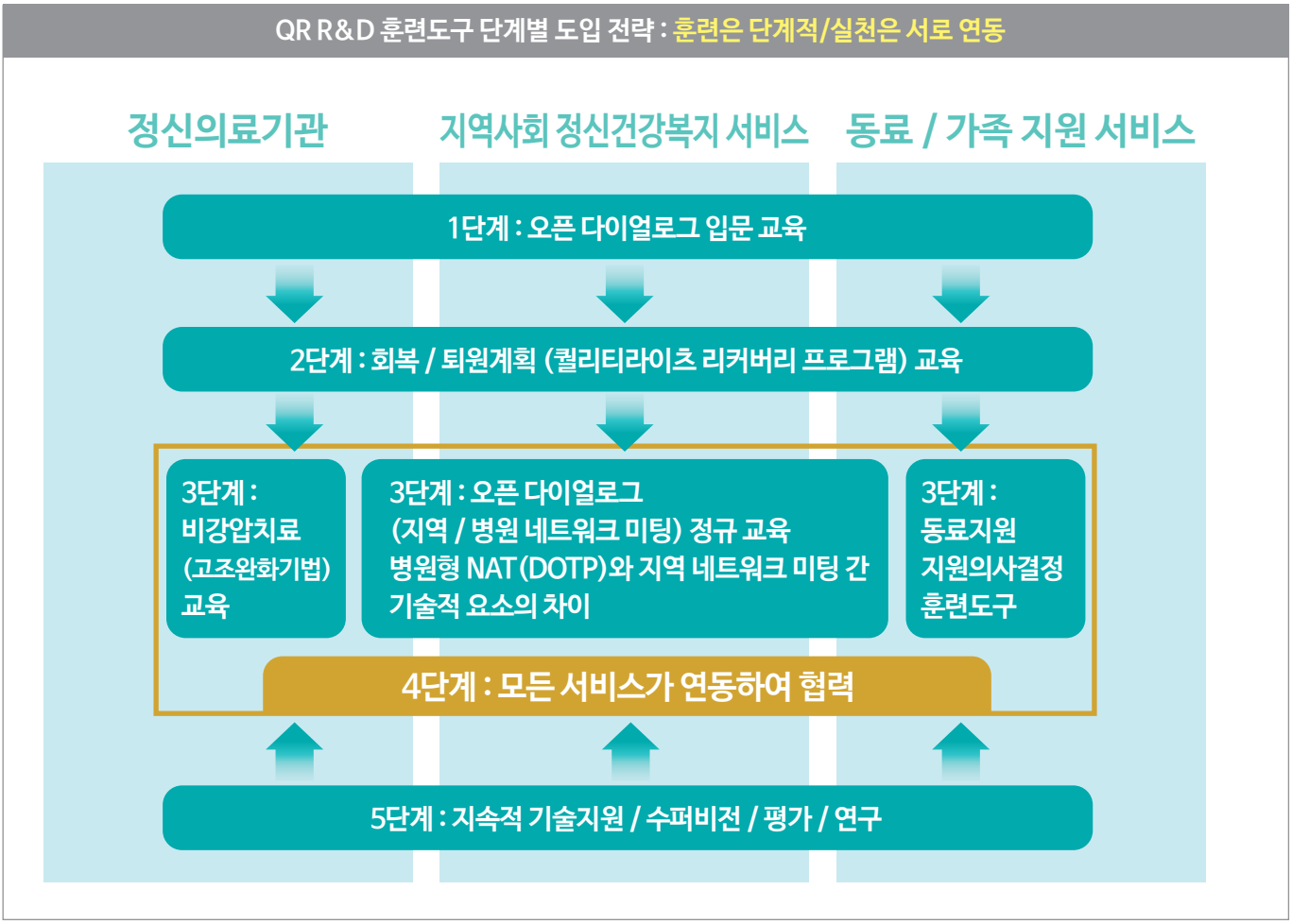
강조되어야 하는 또 하나의 지침은 '여럿이 함께 익히고 협력하여 실천한다'는 것입니다. WHO는 퀄리티라이츠 개발의 첫 단계부터 정신건강서비스 시스템 안에 있는 당사자와 가족, 정신건강 전문가와 공직자, 시민사회 등 관련한 모든 이해관계자들이 함께 하는 공동의 학습 과정을 권장해왔습니다. 또한 본 연구개발 과정을 통해서도 이러한 형태의 혼합 집단이 참여하는 교육훈련이 대단히 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.

교육훈련 참여자의 입장에서 이러한 혼합 집단은 다양한 관점을 통한 폭넓은 이해를 가능하게 하는 경험적 학습을 제공하며, 자연스럽게 사람들 간의 연대가 형성되는 것으로 보고되었습니다. 그리고 이것은 이후의 다학제, 다분야 협력을 위한 귀한 자원으로 기능하게 됩니다. 심리사회적 위기를 겪으며 정신건강 서비스를 이용하는 당사자와 가족의 입장에서도 서비스 제공자들 간의 이러한 협력은 그 자체로 대단히 지지적인 네트워크로 작용할 수 있습니다.

예를 들어, 병원에서 안정화(비강압) 치료를 도입할 때에 이른바 보호사 등의 안전인력만을 따로 분리하여 교육하지 않고, 의사와 간호사, 사회복지사들의 다학제 팀과 함께 훈련이 이루어지는 것이 바람직합니다. 그렇게 함으로써 치료진간의 협력이 강화되고 치료 조직 안의 모든 직역 구성원들이 자신들의 업무에 대한 자부심을 가지고 동기 부여될 수 있습니다. 또한 여럿이 함께 하는 교육훈련에는 해당 조직의 최고 또는 고위관리자가 참석할 것을 권장합니다. 이러한 새로운 인권/회복 기반의 서비스가 실천되기 위해서는 임상을 뒷받침하는 행정적 지원이 필요하며 권위적이지 않은 조직내 협력 문화가 필수적이므로 관리자의 참여가 오픈 다이얼로그와 퀄리티라이츠 교육 훈련 모두에서 강조되고 있습니다.

3. 교육훈련 도입의 단계

정신의료기관, 지역사회 정신건강복지 서비스, 동료/가족지원 서비스의 세 분야에 걸쳐 본 도구가 도입되기 위한 세부 단계의 모식을 아래 그림에 요약했습니다.



1단계 : 오픈 다이얼로그 입문교육

모든 범주에 걸쳐 오픈 다이얼로그 입문 교육이 본 연구 5종 훈련도구의 첫 단계로 이루어지는 것이 바람직합니다. 오픈 다이얼로그 입문 교육은 참석자로 하여금 관습적 정신건강 서비스에서의 위계를 벗어나 서로 평등하고 창조적으로 토론하고 협력하는 기초를 제공하는 탁월한 경험적 학습입니다. 입문교육은 1-3일의 전일 교육이 적당하며 기관과 자원의 상황에 따라 융통성 있게 조정 가능하지만 최소 2일 이상 소요되는 것이 효과적입니다. 한 교육의 참석자는 25명 이내가 바람직하며 최소 2인의 교육자가 함께 진행하는 것이 바람직합니다.

2단계 : 회복/퇴원 계획(퀄리티라이츠 리커버리 프로그램)

2단계 훈련은 회복/퇴원계획(퀄리티라이츠 리커버리 프로그램) 교육을 모든 범주의 서비스에서 제공하는 것이 바람직합니다.

이 교육은 참여자들로 하여금 정신건강 서비스에서의 회복(Recovery) 관점 적용과 인권의 중요성을 이해하고 종사자들과 서비스 이용자들이 협력하여 구체적 목표를 설정하여 추진하기 위한 유용한 구조와 토론 주제를 포함합니다. 또한 이 컨텐츠는 병원과 지역사회 사례관리, 동료지원 과정에서 곧바로 사용할 수 있는 실천 도구로 적용될 수 있으며, 정신사회재활 프로그램으로서 임상적 도입이 용이하다는 장점을 가지고 있습니다. 그러므로 2단계로서 모든 범주에서 적용할 것을 권합니다. 이 훈련은 최소 30시간 이상, 바람직하게는 54시간의 교육이 약 15주에 걸쳐 진행되는 것을 권장합니다. 피교육생 참석 인원은 16-25명(4-5명 씩의 분임조)으로, 주강사 1명, 보조강사 1-2명이 진행하는 것이 바람직합니다.

3단계 : 현장에 맞춘 교육훈련

3단계의 교육은 위에 언급된 정신의료기관, 지역사회 정신건강복지 서비스, 동료/가족지원의 세 현장에서 각각 다른 내용으로 진행되도록 고안되었습니다.

-고조완화기법(안정화치료)

정신의료기관을 위한 비강압적 안정화 치료 교육으로서 기관 내의 모든 직역 종사자가 함께 참여하는 것이 바람직합니다. 1회 참석인원은 30명 이내가 바람직하며 약 3일간의 교육을 필요로 합니다. 1명의 주교육자와 2명 정도의 보조교육자가 함께 진행하게 됩니다.

-오픈 다이얼로그(지역/병원 네트워크 미팅) 정규훈련

이 교육은 정신의료기관, 지역정신보건복지 서비스, 동료/가족 지원 서비스 모든 분야에서 적용될 수 있습니다.
국제적으로 오픈 다이얼로그 실천을 위한 정규교육은 20일간의 전일교육이 필요한 것으로 합의되어 있습니다. 장기간의 교육을 위한 자원이 제한적인 관계로 정규 교육은 2-3일부터 5일 간의 교육단위(Block)으로 나누어 진행될 수 있습니다. 그리고 각 교육단위를 단계 또는 주제에 따라 분리하여 진행할 수 있으나 총 교육 기간은 단축시키지 않고 장기간에 걸쳐 나누어 하는 방식을 통해서라도 달성하는 것을 목표로 하는 것이 바람직합니다. 피교육인 인원은 20명 이내로 최소 2인 이상의 훈련자가 진행하는 것이 바람직하고 효율적입니다.

정신의료기관의 경우 한국의 입원 병상 특성에 맞추어 오픈 다이얼로그를 응용한 병원형 필요맞춤치료(DOTP) 훈련도구를 권장하며, 그 성공적인 도입을 위해서는 해당 의료기관의 치료 문화가 중요한 변수가 될 수 있습니다. 치료공동체에 기반한 다학제 접근이 정착되어 있는 기관의 경우 더 훈련과 실천을 받아들이기가 더 용이하지만 그렇지 않은 경우에는 치료공동체의 기본 원리와 다학제 문화 발전을 위한 프로그램이 추가될 필요가 있으므로 그에 맞추어 훈련 기간이 유연하게 설정되는 것이 바람직합니다.

병원형 필요맞춤치료(DOTP) 기초 훈련은 총 16시간을 2일에 걸쳐 진행되는 워크숍이 실제 이 서비스를 시행중인 강사진에 의해 진행되며, 지속적인 수퍼비전이 사례 중심으로 이루어지는 것이 필요합니다. 또한 이 훈련은 오픈 다이얼로그 정규 훈련과 연동되어 진행되어야 하며 관련한 심화 훈련이 이어질 수 있습니다. 지역사회 정신건강복지 서비스와 동료/가족지원 서비스에서 오픈 다이얼로그를 적용하는 경우는 종사자와 동료/가족지원가가 함께 참여하는 것이 권장되므로 교육 단계부터 실천에 이르는 모든 과정에서 다같이 하도록 진행되는 것이 바람직합니다.

-동료지원 지원의사결정

이 훈련도구는 현재까지 시범사업 형태로 진행되어왔고 향후 전국 도입을 앞두고 있는 절차조력 서비스에 참여하는 동료지원가를 위해 고안된 도구입니다. 절차조력인 양성 과정과 보수교육의 일부로서 대단히 유용하게 적용될 것을 기대합니다. 총 21시간의 교육을 약 2주에 걸쳐 진행하는 것을 권장합니다. 피교육 인원은 약 20명이 4-5명씩 조를 이루어 1명의 주교육자와 1-2명의 보조 교육자에 의해 진행됩니다.

4단계 : 모든 서비스의 협력적 연동

3단계 훈련을 통한 서비스가 효과적으로 운영되기 위해서는 각 도구들이 서로 협력적으로 연동되어야 합니다. 그리고 병원과 지역사회, 동료가족지원 서비스 간의 협력 역시 대단히 중요합니다. WHO퀄리티라이츠의 핵심가치는 정신건강분야의 모든 이들 간의 협력이 서비스 이용자 중심으로 이루어지는 것이기 때문입니다. 그것을 위해 훈련 시행 기관에서는 기관내에서의 다학제 협력에 추가하여 기관간의 다분야 협력 체계도 마련하는 것을 권장합니다.

5단계 : 지속적 기술지원, 수퍼비전, 평가, 연구

모든 교육훈련 이후에는 각 기관에서 실천해 가는 과정을 기술적으로 조력하기 위한 수퍼비전이 지속되는 것이 바람직하며 교육훈련을 시행한 훈련자에 의해 이루어지는 것을 권장합니다. 더불어 도입 및 실천 과정에 대한 평가 및 연구를 통해 서비스를 보완해 가는 것이 필요합니다.

4. 교육훈련의 플랫폼과 실행기관

-교육훈련 플랫폼과 방식

교육훈련은 정신보건복지 분야의 공공 교육 플랫폼과 예산에 의해 진행되는 것이 바람직합니다. 구체적으로 소집 교육과 기관내 교육의 두 가지 방식이 가능합니다. 소집교육은 여러 기관에서 온 참석자들을 한 곳에 소집하여 일정기간 이루어지는 형태입니다. 현재 국내 정신건강복지 시스템에는 다양한 공적 소집 교육 플랫폼이 존재합니다. 대표적으로 한국보건복지인재원에 의해 진행되는 다양한 교육, 공공병원에 의해 진행되는 정신건강전문요원 보수교육, 국가인권위원회에 의해 진행되는 인권교육 등이 있습니다. 본 훈련도구가 이러한 기관들의 교육 컨텐츠로 선정되어 진행된다면, 기존의 교육 시설과 예산을 활용하여 널리 보급될 수 있다는 이점을 얻게 됩니다.

본 훈련도구의 서비스를 실천하기를 원하는 정신의료기관, 지역정신건강복지 서비스 기관, 당사자 가족 단체 등에서 강사진을 초청하여 기관 내의 종사자들을 대상으로 시행하는 기관내 교육(in-house training) 역시 가능한 방법이 될 수 있습니다. 위 두 경우 모두 교육훈련 계획 단계부터 위에 제시한 단계와 구조에 따른 도입을 할 것을 권장합니다. 또한 본 훈련도구의 모든 교육은 단순한 지식 전달이 아닌, 참석자들 간의 상호작용과 소통을 통한 경험적 학습이므로, 온라인이 아닌 대면 교육으로 진행되는 것이 바람직합니다.

-교육훈련 실행 기관

모든 교육은 본 연구개발에 참여했으며 실제로 그 내용을 전문적으로 장기간 실천해 온 기관에서 시행하는 것이 바람직합니다. 그러므로 각각의 훈련도구를 교육할 수 있는 기관의 리스트와 문의를 위한 연락처를 아래에 명시했습니다.

훈련도구	교육기관	문의처
지역기반 네트워크 미팅 (오픈 다이얼로그)	한국 오픈 다이얼로그 학회	mindtrek@hanmail.net
병원기반 네트워크 미팅 (필요맞춤치료; DOTP)	이음병원	eumhospital@naver.com
퀄리티라이츠 리커버리 회복/퇴원계획	아주대학교병원	brainist.cho@gmail.com
고조완화기법(안정화치료)	천주의성요한병원	nearlord1209@gmail.com
동료지원 지원의사결정	사회적협동조합 우리다움 절차조력사업단	hayosa@naver.com

또한 추후에 이 교육훈련을 시행할 수 있는 훈련자를 전국적으로 양성할 필요가 있습니다. 그러므로 장기적으로는 각 훈련도구에 대한 훈련자 양성과정이 개발되어야 합니다.

5. 지속적 보급을 위해 필요한 조치

본 훈련도구가 전국적으로 보급되어 지속가능한 서비스로서 시스템에 기여하기 위해서는 몇 가지 제도적 뒷받침이 필요합니다. 구체적으로 지침 개정, 시범운영기관 또는 지역 확산, 서비스 수가 및 보상 개발 등을 예로 들 수 있습니다.

-지침개정

현행 정신건강증진시설 인권교육 지침이 글로벌 정신건강서비스 인권 기준에 맞추어 전면적으로 개정되어야 공공 교육 기관에서 그에 맞추어 WHO 퀄리티라이츠와 관련한 본격적인 교육 계획을 수립할 근거가 마련됩니다. 또한 지역정신건강복지 서비스의 가이드가 되는 정신건강사업안내에 종사자들의 교육훈련과 다학제/다부문 협력을 권장하는 지침이 포함되는 것이 실질적인 사업 추진의 근거가 될 수 있습니다. 또한 정신의료기관에서도 관련한 서비스를 위한 교육훈련에 대한 보상이 마련된 지침 개정이 필요합니다.

-시범운영 기관 / 지역

본 훈련도구가 지향하는 서비스는 상당한 인적, 물적 자원 투입과 정신의료기관과 지역정신건강복지 기관, 당사자/가족간의 다부문 협력을 필요로 합니다. 그러므로 전국적 보급 이전에, 새로운 서비스를 본격적으로 실천할 수 있는 시범 기관 또는 지역을 선정하여 자원을 지원하는 것이 현실적인 방법이 될 수 있습니다. 예를 들어 본 연구개발사업에서는 경기도 수원시가 시험운영 지역으로 선정되어 아주대학교병원, 이음병원, 수원시행복정신건강복지센터, 수원시성인정신건강복지센터, 수원시자살예방센터, 당사자단체 마음사랑, 경기도절차조력사업지원단, 수원시정신건강가족학교 등이 참여하는 다부문 협력이 병원과 지역 서비스 전체에서 집중적으로 이루어졌고, 그 효과가 드러났습니다.

-서비스 수가 및 보상 개발

본 연구개발의 결과물로 실천될 서비스가 지속가능하기 위해서 각각의 서비스에 대한 수가가 마련되어야 합니다. 그리고 이들 서비스는 보다 넓은 정책 실천 안에 포함되는 것이 바람직합니다. 현재 진행중인 정신질환자 지속치료지원사업에 포함된 급성기치료 활성화, 병원기반 사례관리, 낮병원 시범 사업 등에 요구되는 치료 행위들에 본 훈련도구에 바탕한 각각의 서비스가 포함되고 적정한 수가가 책정될 필요가 있습니다. 또한 지역정신건강복지 서비스 기관 역시 평가 및 운영 지침에 새로운 인권/회복 기반 서비스와 다부문 협력에 대한 보상이 마련되어야 합니다. 이러한 정책적 조치가 향후 지속적인 보급을 위한 기초가 될 것입니다.

맺음말

본 훈련도구의 도입을 위해 세계보건기구(WHO)가 선택한 세부 전략이 좋은 참고가 됩니다. WHO는 우선 평가도구와 훈련도구를 제일 먼저 개발하고, 이어서 실제 모범사례들을 소개한 가이던스, 법령 개정 지침, 정책 실천 가이던스의 세밀한 단계를 거쳐 이 프로젝트를 진행해왔습니다. 그 중 특히 훈련도구를 첫 단계로 도입한 것은 그것이 서비스 변혁을 위한 변화의 첫 단추이기 때문입니다. 그런 면에서 이번 훈련도구 개발이 큰 의미를 가집니다.

또한 WHO가 그간 가장 강조해 온 것은 이 프로젝트에 참여한 모든 이들이 '변화가 가능하다는 것을 믿게 되었다'는 것입니다. 모든 이해관계자들이 다함께 '이전과는 다른' 방식으로 협업하게 되었을 때 '실제로 다른 결과'가 구현되었다는 것을, WHO는 지난 십여 년 동안 증명해오고 있습니다. 본 연구개발에서의 경험 역시 동일합니다.

정책의 변화는 현장의 변화를 촉진합니다. 그리고 현장의 변화는 최종적으로 심리사회적 약자와 가족들의 삶과 공동체를 변화시키게 됩니다. 본 연구 결과물이 이러한 변화를 통해 우리 사회가 통합과 포용으로 나아기는 데에 작은 마중물이 되기를 기대합니다.

발 간 사

이 지침서는 WHO 퀄리티라이츠에 기반한 인권중심 중재기술 패키지의 일환으로서 오픈 다이얼로그를 지역사회 정신건강서비스에 적용하기 위한 훈련 및 실행의 방향과 원칙을 제시하는 것을 목적으로 합니다.

오픈 다이얼로그는 단일 치료 기술 또는 집단 프로그램이라기 보다는 정신건강 서비스를 이용자 중심으로 조직화하며 제공 과정에서의 협업을 강화하는 철학 또는 문화라고 할 수 있습니다. 그러므로 텍스트를 통해 익힐 수 있는 실행 기술이 아니며, 경험적 학습을 통해서만 교육과 적용이 가능합니다. 또한 이러한 교육 안에서 훈련자와 피훈련자 집단간의 밀도 있는 상호 작용을 통해서만이 실제 현장에서 발휘되는 팀워크와 유연성 등의 역량이 획득될 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 오픈 다이얼로그는 문헌 강독이나 강의를 통해서는 핵심 원칙을 효과적으로 전달하기 어렵고 오해로 인한 혼란이나 저항을 초래할 수도 있다고 합니다(Lorenz-Artz, Bierbooms, and Bongers 2023).

그래서 오픈 다이얼로그는 매뉴얼화(Manualization)가 불가능한 정신건강 돌봄이라고 불리기도 합니다. 그럼에도 불구하고 오픈 다이얼로그의 훈련과 실행에는 장기간의 발달 과정과 국제적 논의를 통해 합의된 공통적인 구조가 존재합니다. 그래서 그 구조(structure)를 적용하여 서비스 안에서 확립하는 것이 훈련과 실천을 위한 기초라고 할 수 있습니다.

이 지침서는 오픈 다이얼로그의 기본 개념과 실체를 이해하도록 돕고 지역과 병원 서비스 안에서 적용할 수 있도록 하기 위한 뼈대를 설명하는, 일종의 안내서로 기능하는 것을 목표로 합니다.

그러므로 이 지침서는 우선 정신건강 서비스로서의 오픈 다이얼로그가 어떤 과정을 통해 개발되었는지에 대한 맥락과 현대 정신건강 서비스에서 가지는 의의, 실제 운영에서의 핵심 작동 원리와 요소, 기존 서비스에 어떤 방식으로 도입되고 실천되어야 하는 지에 대한 개괄을 제시합니다. 독자들께서는 이 지침서를 읽어 나가시는 동안 오픈 다이얼로그가 현장에서 어떻게 운용이 되며 서비스 제공자들이 동료 및 당사자, 가족과 협력해 나가는 과정과 문화를 이해하실 수 있을 것으로 기대합니다.

또한 한국에서의 개발 및 실천 과정과 그에 대한 연구를 바탕으로 실용적인 도입과 실천을 위해 필요한 점들을 제안하려 시도하였습니다. 지역사회의 정신건강 서비스 조직 그리고 의료기관에 적용하려 할 때에 우선적으로 고려되고 마련되어야 할 것에 대한 제안이 포함되어 있습니다. 이 제안은 해외의 사례들에 대한 상세한 고찰, 많은 국제 전문가들과 나눈 토론과 자문, 그리고 한국 시험운영에 참여한 연구진의 생생한 경험과 논의를 바탕으로 만들어진 것입니다.

이 지침서가 전국의 정신건강 돌봄 현장에 오픈 다이얼로그가 도입되기 위한 유용한 마중물로 기능하기를 기대합니다. 그래서 회복과 인권 기반의 정신건강서비스를 지향하는 분들이 사람들 간의 연결과 연대의 가치 아래에서 함께 성찰하며 협업해 나가실 수 있기를 희망합니다.

한국오픈다이얼로그학회 공동대표 **김성수**

01 | 오픈 다이얼로그(Open Dialogue)란? 20

02 | 오픈 다이얼로그의 발달 과정 23

03 | 가족 중재로서의 오픈 다이얼로그 28

04 | 오픈 다이얼로그의 7대 핵심 원리 29

05 | 오픈 다이얼로그의 12가지 핵심 실행 요소 36

06 | 오픈 다이얼로그 미팅의 기본 구조 42

07 | 정신증에 대한 이해와 접근 46

08 | 오픈 다이얼로그 교육훈련 49

09 | 오픈 다이얼로그를 지탱하는 4개의 기둥 53

10 | 한국에서의 오픈 다이얼로그 실천 55

11 | 오픈 다이얼로그 국내 보급 및 확산 방안 58

12 | 감사의 말씀 68

13 | 참고 문헌 69

14 | 부록1 : WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입 73

15 | 부록2 : 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가? 109

01 오픈 다이얼로그(Open Dialogue)란?

오픈 다이얼로그(OD)는 핀란드 서부 라플란드 지역에서 개발된 정신 건강 관리 시스템이다. OD의 두 가지 필수 요소는 위기나 도움이 필요할 때 사람들과 함께하기 위한 치료적이고 철학적 접근 방식이며, OD는 또한 사람들의 필요에 응답할 수 있는 가능성을 극대화하는 정신 건강 서비스를 조직하는 방식으로 정의된다(Putman and Martindale 2021).

또한 OD는 정신 건강 위기를 겪고 있는 개인 및 가족과 심리치료 및 대화 방식으로 진행되는 구체적인 기법으로 볼 수도 있는데, 관계의 중심성과 가족 및 네트워크 참여를 통한 연결성 증진에 초점을 맞춘 개별 정신 역동 치료와 체계적인 가족 치료의 측면을 통합한다(WHO 2021).

이해를 돕기 위하여 오픈 다이얼로그는 좁은 의미와 넓은 의미의 정의로 설명이 가능하다.

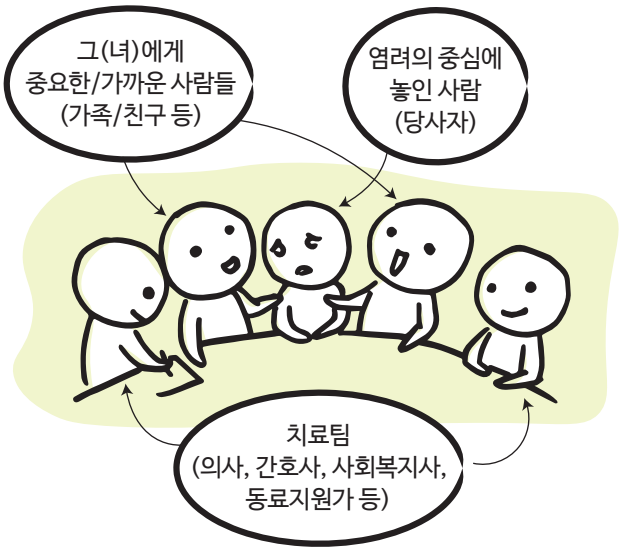
1) 좁은 의미의 오픈 다이얼로그

당사자와 가까운 이들(가족), 치료진 여럿이 다함께 모여서 나누는 대화

: 오픈 다이얼로그 고유의 기술, 팀워크, 철학이 필요

· 당사자에게 편한 장소 : 대개 가정방문

· 충분한 시간을 들여 경청과 질문을 통한 공간 (다양한 생각을 표현할)을 만드는 작업



위 그림처럼 누군가 심리사회적 위기를 경험할 때 그를 돕기 위해 그의 주변에 있는 사람들과 조력자들이 최대한 신속하게 함께 모여서 나누는 대화가 협의의 오픈 다이얼로그라고 할 수 있다.

이 대화 속에서 오픈 다이얼로그 고유의 태도, 팀워크, 다양한 기술들이 작동하게 되는데, 치료팀이 겸허한 마음으로 인내심을 가지고 충분한 시간을 들여 경청과 질문을 통해 당사자와 가족이 스스로의 속마음을 발언할 수 있는 공간을 만드는 작업을 해 나가는 과정으로 요약할 수 있다.

2) 넓은 의미의 오픈 다이얼로그

오픈 다이얼로그 : 치료 기법이자 서비스 구성 / 운영 원리 - 달리 일하기

당사자와 네트워크(가족/지인 등), 종사자가 함께하는 집단 모임

서비스 조직 내/외의 제공자들이(네트워크와) 서로 수평적으로 협렵하는 접근/문화 특유의 솜씨와 팀워크 필요

당사자 중심으로 병원과 지역 등 다양한 서비스들의 협업/연동 방식을 재조정하는 새로운 시스템

위 그림 하단에 설명되었듯, 병원과 지역사회의 다양한 서비스들이 당사자와 가족의 '필요에 맞추어(Need-adapted)' 협업 연동할 수 있도록 하는 서비스 시스템 전체의 조직화가 광의의 오픈 다이얼로그라고 할 수 있다.

좁은 의미/넓은 의미의 오픈 다이얼로그가 가능하도록 하기 위해서, 현장에서는 오픈 다이얼로그 특유의 솜씨와 팀워크가 필요하고 그 상위 수준에서는 서비스 조직 내/외의 사람들이 서로 수평적으로 협력하는 문화 및 제도가 필요하다.

서비스를 이용하는 입장에서 경험되는 오픈 다이얼로그에서의 일반적인 대응은, 내담자들이 서비스와 최초로 접촉 후 최대한 빨리 지역 사회 안에서 '네트워크[2]모임'이 열리는 것이다. 위기를 겪는 당사자와 그들의 사회적 관계망에 속한 중요한 구성원들이 두 명 이상의 전문가팀과 더불어 그 모임에 참석하게 된다(Putman and Martindale 2021).

3) 관행적 정신건강 서비스와의 차이

오늘날 정신 건강 서비스의 일선에서는 약물치료를 정신증 치료의 중심으로 삼고 있으며, 약물치료는 변화의 주요 원인으로 여겨진다. 서비스 이용자의 대인관계 및 치료진과의 관계 양식이 영향력을 발휘한다는 점, 거의 모든 사례에 당사자의 주요 인생 사건이 결부되어 있다는 사실은 상대적으로 덜 다루어지게 된다. 또한 다양한 치료 방식과 자원이 존재함에도 불구하고 대개 약물치료가 중심을 이룬다(Razzaque 2019).

우리에게는 증상과 약이 전부였다. 이것이 내가 속한 지역사회 리커버리 팀 전체가 작동하는 방식이었다. 관리자, 의사, 간호사, 사회복지사가 모두 마찬 가지였다. 우리 모두는 중심에 위치한 치료 자원의 중력에 이끌려 그 주위를 맴도는 행성들 같았다. 그리고 그 중심의 치료 자원은 약물이었다.

-러셀 라자크의 '대화정신의학' 번안인용

오픈 다이얼로그 치료진이 함께 일하는 방식은 관습적 치료와는 전혀 다르다. 정말 중요한 것은 사람들 사이의 관계라는 점을 모두가 자각한다. 치료진이 무엇을 하는지, 어떻게 말하는지, 어떻게 질문하는지, 누구를 방에 초대하는지, 심지어 방 바깥에서 내담자들에 관하여 어떻게 말하는지가 가장 중시되는 공동 작업이 진행된다. 그것이 변화의 핵심 인자라고 믿는다.

4) 오픈 다이얼로그의 세 가지 측면

오픈 다이얼로그는 사람들이 만나는 공간(네트워크 모임) 에서의 대화적 실행인 동시에 한 개인과 가족을 둘러싼 돌봄 시스템이 작동하는 서비스 제공 체계이기도 하다. 또한 미시적 실천과 거시적 시스템을 아우르는 세계관 또는 철학이 존재한다. 그에 따라 아래와 같은 도식(Valtanen and Kurtti 2017)으로 오픈 다이얼로그의 세 측면을 설명할 수 있다.

대화적 실행	서비스 제공 체계	대화적 실행
- 협업	-필요맞춤 통합 치료 팀워크	- 다른 이들을 경청하고, 참여하며 대응하기
- 불확실성에 대한 용인	- 즉각적인 조력	- 현실을 공동 창조
- 목적으로서의 대화	- 가족과 네트워크 강조	- 시스템/조직 전반에 성찰 (rreflection) 작업을 고취
- 모든 목소리에 귀 기울이기	- 유연성	- 관계적/맥락적인 정체성
- 반영적인 대화(reflection)		
- 개방적인 의사 결정		

02 오픈 다이얼로그의 발달 과정

1) 초기 발달

OD는 단일한 치료법으로서 개발되었다기 보다는 다양한 심리사회적 치료 전통이 장시간에 걸쳐 수렴한 결과물로 보는 것이 타당하다.

1970년대와 1980년대에 유럽에서는 치료공동체(therapeutic community) 접근이 확산되었고 동시에 정신건강 서비스에서 가족과 협업하는 것에 대한 관심이 증가했는데, 그것은 핀란드에도 영향을 미치게 된다. 그 일환으로 핀란드 투르쿠 지방의 정신과 의사 이료 알라넨(Yrj Alanen)은 입원 병동에서 조현병 환자에 대한 새로운 접근을 시도했다.

그는 정신증의 발생에서 가족 역동 및 의사소통의 역할에 특히 관심이 있었고, 치료 작업에 가족을 참여시킬 것과 이 참여를 촉진하기 위한 기법들을 개발했다. 정신치료공동체(Psychotherapeutic community)로 명명된 이 접근에서는 치료팀이 함께 당사자와 가족을 만나 그들의 욕구를 파악하며 서비스 이용자 중심의 서비스 배치/제공. 심리적 이해를 추구하려 시도했고, 이런 방식을 '필요맞춤치료(Need Adapted Treatment)'로 명명되었다(Alanen 1997). 이 접근은 조현병 환자의 환각과 편집증적 발언을 주의 깊게 경청하면 유의미한 이야기를 찾을 수 있다는 신념에 따라 아래와 같은 치료 문화를 발달시켰다.

병원의 정신과 의사, 간호사, 직원들은 환자의 말에 귀 기울여야 했다.

"환자의 가족을 만나는 사람이라면 누구나 그들이 삶에서 어려움을 겪음을 이해할 수 있다."

치료는 '사례별'로 이루어져야 한다.

어떤 초발 환자는 입원이 필요하지만 어떤 환자는 그렇지 않을 수 있다.

어떤 환자는 정신과 약물로 치료 이득을 얻을 것이고, 어떤 환자는 그렇지 않을 수 있다.

그 과정에서 NAT는 협력적인 유형의 집단 가족치료를 핵심에 놓게 되는데 이 세팅에서는 정신과 의사, 심리학자, 간호사 등 가족치료 훈련을 받은 2인 또는 3인으로 구성된 '정신증팀'이 구성되어 환자와 가족을 만나게 된다. 그 과정의 몇 가지 기본 원칙이 아래와 같이 제시되었다.

① 치료 활동은 각각의 사례에서 유연하고 개인화된 방식으로 계획되고 수행된다.
② 정신치료적 태도가 평가와 치료를 지배한다.
③ 서로 다른 치료법들은 서로를 보완해야 한다. 다양한 치료법들 앞에서 양자택일 식의 태도를 취하면 안 된다.
④ 치료는 연속적 과정의 특성이 유지되어야 한다.
⑤ 개별 서비스 이용자에 대한 치료의 효과에 대한 후속 조사가 이루어져야 한다.

위의 필요맞춤치료 원칙은 1981년부터 1987년까지 진행된 핀란드 국가 조현병 프로젝트의 핵심 원리로 적용되었다. 이 프로젝트를 통한 필요맞춤 치료의 시행 결과, 1983년부터 1984년까지 치료에 연계된 초발 조현병 환자를 대상으로 한 추적 연구에서 5년 후에 61%의 환자가 무증상을 보였고 장애가 지속된 환자는 18%에 불과하다는 고무적인 성과가 도출되었다.

2) 핀란드 라플란드에서의 오픈 다이얼로그 발달

오픈 다이얼로그 접근법은 본질적으로 필요맞춤치료(NAT)의 (확장된) 한 형태라고 할 수 있다.

서부 라플란드는 역사적으로 조현병 진단율이 핀란드 내에서 가장 높은 지역으로서, 1980년대 후반에 5년에 걸쳐 조사한 평균 발병 빈도는 연간 인구 10만 명당 신규 조현병 피진단자는 30.3명에 달했다(Aaltonen, et al 2011). 지역의 정신건강서비스 담당 병원으로서 장기간 만성 환자 병동을 운영해 온 케로푸다스(Keropudas) 병원은 1979년에 급성기 환자 치료 기능으로 전환하게 되면서 국가 조현병 프로젝트에 맞춘 새로운 접근을 시도하게 된다.

병원 치료진들은 필요 맞춤 치료(NAT), 시스템 가족치료, 노르웨이의 톰 안데르센이 시도한 기법, 미하일 바흐친의 철학 등등 다양한 이론과 기술을 익히면서 조현병 환자에 대한 다른 방식의 치료를 시도했다(Putman and Martindale 2021). 이러한 과정은 약 20년에 걸쳐 진행되었으며 아래와 같은 몇 가지 중요한 단계를 거쳤다.

1. 1984년 경부터 입원 환자에 대한 열린 가족 네트워크 모임(open family network meeting)이 정착된다. 이 모임은 '치료 모임'이라고 이름 붙여졌다. 이 모임을 통해 환자들을 퇴원시켜 지역 사회에서 돌보는 결정이 내려질 수 있었다. 이 과정에서 종사자들이 환자나 가족이 없는 자리에서 그들에 관하여 논의해 온 관행을 없애는 변화가 이루어졌다. 그리고 치료진은 우선 가족이 원하는 바를 경청한 다음에 무엇이 필요한지를 가족과 함께 결정하는 것을 가장 우선시하게 된다.

2. 1986년 후반 들어 네트워크 모임은 입원 결정이 이루어지기 전에 병원에서 열리는 것으로 바뀐다. 입원 이후 모임을 가졌던 기간 동안 삼 분의 일 이상이 입원이 불필요했던 결과에 따라, 외래에서의 첫 네트워크 모임(이른바 '입원 모임')에서 종사자와 당사자, 가족이 입원 필요성을 함께 논의하는 쪽으로 시스템 수정이 이루어졌다. 또한 입원하지 않을 경우를 대비하여 일종의 '사례 전담팀'이 활동하는 '위기 클리닉(crisis clinic)'이 설치되면서 가정 방문이 추진되었다. 그 결과로 입원율이 30퍼센트 감소하는 결과를 보였다.

3. 1990년부터는 서부 라플란드의 모든 정신건강 외래진료소가 위기 개입을 위한 기동 팀을 운영하기 시작한다. 전 지역의 정신의학 시스템 전체에 정착되는 1995년 경부터 이러한 접근에 대해 오픈 다이얼로그(Open Dialogue)라고 명명하게 된다. 각각의 팀은 서비스 이용자와 가족의 필요에 맞춰 다르게 조직되고, 이 사례 전담팀들은 위기 시에 서비스 이용자/가족과 협업할 뿐만 아니라 치료 과정 전체를 책임진다.

10여년에 걸친 시도와 오류를 통해 발전해오는 동안 오픈 다이얼로그 팀들은 자기네 작업 방식의 이 측면들 각각이 어떻게 변화를 유발하는지 알아내는 주기적 개량 과정에 열중했다. 그 결과로 그들이 밝혀낸 것은 당사자에 대한 돌봄에 더 많은 사람들을 참여시키고 그의 가족과 사회적 환경을 포함하고 육성하는 작업이 장기적 성과에 지대한 영향을 미친다는 것이었다. 그리고 그 작업이 모든 것을 아우르는 서비스 모형으로 구현해 낸 것이 오픈 다이얼로그이다(Razzaque 2019).

3) 라플란드에서의 오픈 다이얼로그 운영 성과

라플란드의 오픈 다이얼로그 연구중 가장 잘 알려진 것은 19년에 걸친 등록 기반 코호트 연구로, 장기적인 결과를 핀란드 전역의 대규모 대조 집단과 비교했다. 이 코호트의 구성원들은 정신병 발병 후 처음으로 정신건강 서비스를 받았으며, 약 19년 동안 추적 관찰을 받았다.

오픈 다이얼로그 코호트는 대조군에 비해 병원 치료 기간, 장애 보조금, 신경 이완제3의 필요성이 현저히 낮았다. 중요한 점은 대조군의 거의 모든 환자(97.3%)가 치료 중 어느 순간 신경이완제를 투여 받은 반면, 오픈 다이얼로그 코호트의 46%는 신경이완제를 사용하지 않고도 치료를 완료했다는 점이다. 또한 오픈 다이얼로그 서비스를 받은 사람들은 기존 치료법에 비해 더 나은 취업 결과를 보인 것으로 보고되었다.

이러한 결과를 전국적으로 비교한 또 다른 코호트 연구에서 5년간 추적 관찰한 결과, 라플란드 사업 지역(catchment area)이 핀란드에서 가장 병원 치료 기간과 장애 연금 수령률이 낮았다는 사실이 발견되었다. 질적 연구에 따르면 일반적으로 오픈 다이얼로그는 서비스 이용자와 그 가족, 관련 전문가 모두에게 만족스러웠던 것으로 나타났다. 또한 위에서 언급한 19년간의 추적 연구에 따르면, 핀란드 전체 코호트에서 50%의 입원이 비자발적 입원이었던 반면, 라플란드 서부에서는 26%에 불과한 것으로 나타났다. 이는 오픈 다이얼로그가 비자발적 치료 차원에서 상당한 영향을 미쳤음을 시사한다(WHO 2021).

라플란드 지역의 조현병 발병률은 1990년대 초에 이르러 5년간 평균 발병 빈도가 연간 10만 명당 17.1명으로 감소하고 있었다. 같은 기간에 단기 정신증 에피소드(brief psychotic episode)의 발병은 인구 10만 명당 1.2명에서 6.7명으로 증가했는데, 이러한 변화는 초기 정신증에 대한 지역사회 기반의 적극적 개입을 통해 조현병으로의 이행을 줄인 것으로 설명되었다. 1994년이 되자, 조현병 진단 빈도는 연간 인구 10만 명당 7명으로 감소했다(Aaltonen et al., 2011).

4) 국제적 보급

위의 고무적인 성과에 힘입어 OD는 전 세계 35개국 이상에 소개되었으며 24개국에서 100개 이상의 기관이 운영되고 있다(Raffaella Pocobello 2023). 관련한 연구도 활발한데, 영국의 경우 국가보건 시스템(NHS) 안에서 40억원 이상의 예산을 투입하여 3년여의 기간 동안 300명 이상의 종사자와 동료지원가를 OD 실행자로 훈련하여 600명 대상의 대규모 무작위맹검연구(RCT)를 시행하는 오데시 시험(ODDESSI trial)이 진행되었다(Razzaque 2021). 이탈리아의 경우에도 여덟개 광역 정신보건부에서 햐향식 도입이 시도되었으며, 전 세계의 오픈 다이얼로그 실천 현황을 평가하는 'International HOPEnDialogue project'가 진행중이다(Putman and Martindale 2021).

한편 세계보건기구(WHO)는 유엔(UN) 장애인권리협약(CRPD)에 기반하여 정신건강 시스템과 서비스, 실천이 인권적 가치를 반영하도록 설계된 다중 구성요소 프레임워크인 QualityRights 프로젝트를 개발하여 보급중이다(Funk and Bold 2020). 그 일환으로 WHO는 지역사회기반 정신건강 서비스에 대한 지침에서 전 세계에서 25가지의 모범 서비스를 선정하였는데 그 중 OD는 정신건강 위기 대응 범주의 모범 사례로 등재되었다(WHO 2021).

주목할 만한 점은, 위기 대응의 모범사례 범주에 포함된 오픈 다이얼로그 이외의 서비스들이 모두 일정부분 OD와 유사한 대화적 요소들을 포함하고 있다는 것과 병원 서비스의 모범사례에서도 OD 도입이 시도되고 있다는 점이다.

모범위기 대응 서비스들의 공통요소 : 오픈 다이얼로그

WHO 선정 정신건강 위기 서비스 (Mental health crisis services) 모범사례

- 강압의 사용에 의존하지 않고 효과적인 보살핌과 지원을 제공하며 법적 능력 및 기타 인권존중
- 다분야 팀의 지원, 가정/요양센터의 보살핌과 지원
- 단기적인 휴식을 위할 수 있도록 설계된 커뮤니티 기반의 임시 숙소(쉼터/Respite/Crisis House)
- 동료 지원 및 안전한 공간/편안한 환경 제공에 중점
- 의사소통과 대화, 사전동의, 동료참여, 유연성 있는 지원, 법적능력 존중, 욕구에 따른 양질의 치료/지원

Afiya House	Massachusetts, USA	· 동료지원가가 운영하는 위기쉼터/심각한 정신적 고통을 겪고 있는 18세 이상 대상자 최대 7박까지 가능, 자유로운 출입 · 동료지원 및 대화적 접근
Link House	Bristol, United Kingdom	· 정신건강 위기를 겪고 있는 여성을 위한 주거 위기센터 · 정신병, 자살 충동, 알코올 및 약물 사용, 전담지원요원 · 반영적 실천, 트라우마 기반 접근, 회복계획수립
Open Dialogue Crisis Service (오픈 다이얼로그)	Lapland, Finland	· 정신질환을 겪는 개인 및 가족과 협력하기 위한 특별한 위기대응집단상담 · 2019년 코호트 연구결과 기존 치료보다 유의미한 효과 보임 (입원기간/약물사용률/장애율, 초발 정신증 85% 회복률) · 뉴욕 Parachute project(위기대응 시스템), 영국, 네덜란드 위기대응 시스템에 도입 · 약 24개국 보급, 영국, 아일랜드, 독일, 미국, 노르위이 등에서는 병원기반으로도 실천
Tupu Ake	South Auckland New Zealand	· 맞춤형, 회복 중심 및 강점 기반 계획 · 동료지원가에 의한 단기 체류 및 일일 지원 프로그램 · 지역내 다른 서비스와 협력, 자기결정 존중

모범 병원 서비스의 핵심 요소 : 비강압치료, 오픈 다이얼로그, 지역서비스 연결 유지 동료지원, 지원의사결정 포함

WHO 선정 병원기반 정신건강 위기 서비스 (Hospital-based mental health services) 모범사례

- 최소한의 입원기간 및 입원 기간 동안 지지 네트워크에 연결되어 있도록 구성
- 병원 환경을 넘어 지역사회 서비스에 연결하여 삶과 지역사회 복귀를 촉진
- 강압적 관행의 사용을 중단하기 위한 절차 마련

BET Unit, Blackstad Hospital, Vestre Viken Hospital Trust	Viken, Norway	· 정신병원인 Blackstad Hospital 내 독립 BET 유닛 · 주 7일 24시간 이용 가능, 개방병상 6 · 한 달 평균 6~10명의 치료 및 지원 · Basal Exposure Therapy (BET) : 자살 예방의 강압/통제의 대안
2 Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH	Heidenheim, Germany	· 3개의 성인 입원 병동과 낮병원, 79병상, 평균 입원기간 21일 · 집단/개인 심리치료, 동료 지원, 사회적 지원, 춤/동작 및 작업치료, 가정 방문 · 오픈 다이얼로그 · 지원 의사결정 : 강제 입원 감소 · 강압적 개입 비율 2.1% (주 평균 6.7%) · 비강압치료기법으로써의 고조완화(De-escalation), 대응팀
Soteria	Berne, Switzerland	· 전문 공립 정신병원 소속 · 10개의 침실, 7~9주, 최대 3개월, 매년 평균 60명 · 동료지원

위의 사례들이 시사하듯, 오픈 다이얼로그는 단일 프로그램만이 아니라 다양한 서비스 세팅이 순조롭고 효과적으로 운영될 수 있도록 하는 협업 문화 내지 철학의 핵심 요소로 기능할 수 있다.

03 가족 중재로서의 오픈 다이얼로그

조현병에 대한 심리사회적 중재 기술 중 가장 근거 기반이 강한 접근은 가족 중재로 알려져 있다. 그에 따라 아래 그림처럼 여러 국가의 조현병 치료 가이드라인에서 가족 중재를 최우선으로 권장하고 있다.

오픈 다이얼로그의 필요성 : 가족 중재의 과학적 근거가 가장 강력
OD는 조현병에 대한 가장 진화된 방식의 심리사회적 가족중재

국제적 지침에서 권고하는 근거기반 정신사회적 중재

Table 1. Psychosocial intervention suggested by guidelines

Nation	Canada	Australia	Denmark	UK	Scotland	USA
Year published	2017[7, 8]	2016[2]	2015[9]	2014[10]	2013[11]	2009[12]
가족 중재	+++	+++	+++	+++	+++	+++
인지행동치료	+++	+++	++	+++	+++	+++
지원 고용	+++	+++		+++		+++
조기 중재 서비스	+++	+++		+++	+++	++
신체건강을 위한 생활습관 개선		+++		+++	+++	+++
물질 남용에 대한 치료	+++	++	++	++	+	+++
집중적 지역사회 치료	++	+++	+++		++	+++
인지 교정	++	+++	++		++	++
사회기술훈련	++	++	++		++	+++
동료 지원	+	++		+		++

+ : Consensus-based recommendation
++ : Intermediate evidence-based recommendation,
+++ : Strong evidence-based recommendation

김성완 조현병 환자를 위한 정신사회적 중재, 신경정신의학 2018;57:235-243.

위와 같은 가족 중재의 효과에 대한 강력한 증거(Kim 2018)에도 불구하고, 실제로 가족 치료를 받는 사람은 대다수 국가에서 매우 드물다. 왜냐하면 가족 치료는 완전히 분리된 별도의 전문분야로 간주되기 때문이다. 일상적인 정신건강 돌봄에서 가족 치료는 치료 전체의 기반이 아닌 부수적 선택지였다. 또한 가족 치료는 서비스 전체에 배어 있는 포괄적인 문화가 아니었고, 제공되더라도 위기가 지나간 이후에나 이루어지곤 했다. 여러 근거가 존재했음에도 불구하고 관습적 서비스가 가족 중재보다는 개인을 대상을 하는 것에 집중해온 주된 이유 중 하나는 가족 및 네트워크와의 협업에 동반되는 감정적 강렬함 때문이었다. 인간으로서 우리는 자연스럽게 저항이 가장 적은 경로, 즉 아픔이 가장 적은 경로를 선택하게 되므로 따라서 네트워크나 집단 작업에 따르는 복잡함을 우회하여 개인을 주목하여 그 병리를 밝히고 치료하는 것을 기본 방향으로 삼아온 셈이다(Razzaque 2019).

오픈 다이얼로그가 이루어 낸 가장 큰 혁신은 가족 중재를 위기 대응의 최전선에 투입한 것이다. 곧 위기 개입 시점에 곧바로 가족 개입이 시작되는 것이며, 치료팀은 첫날부터 가족, 시스템, 네트워크를 염두에 둔 공동작업을 시작한다. –러셀 라자크

04 오픈 다이얼로그의 7대 핵심 원리

오픈 다이얼로그의 핵심 원리와 실행 요소 파트에서 본 지침서는 '정신증을 위한 오픈 다이얼로그(Putman and Martindale 2021)'를 주요 참고문헌으로서 상당 부분을 정리하여 인용하였음을 밝힌다.

핀란드 라플란드에서 위와 같은 장기간의 발전과정이 이루어진 뒤, 오픈 다이얼로그 실천가들은 논의를 거쳐 이 접근의 핵심을 이루는 일곱가지 원리를 도출하였다(Seikkula et al. 2003). 이 원리에는,

① 즉각적인 도움(immediate help)
② 사회적 네트워크 관점 (social network perspective)
③ 유연성과 기동성(flexibility and mobility)
④ 책임성(responsibility)
⑤ 심리적 연속성 (psychological continuity)
⑥ 불확실성에 대한 용인(tolerance of uncertainty)
⑦ 대화주의(dialogism)가 포함된다.

처음 다섯 가지 원칙은 서비스 구조와 관련되며, 마지막 두 가지는 실천의 형태와 관련된다. 이러한 원칙은 각각 독립적인 것이 아니라 상호 연관되어 있으며 서로 긴밀히 의존하고 있다(Seikkula et al. 2003). 따라서 OD를 효과적으로 실행하기 위해서는 실질적인 기술과 팀워크가 서비스 시스템의 조정 방식과 필수적으로 연계되어야 한다.

▌오픈 다이얼로그의 7대 핵심 원리

- 서부라플란드에서 10년 넘게 발전한 서비스를 분석하고 기존의 전통적 정신의학 시스템과 비교함으로써, 그 새로운 형태의 지역사회 돌봄 서비스가 **최적으로 작동하는 상황을 대표하는 주요 원리 일곱 개**가 식별(Aaltonen et al., 2011)

① 즉각적 도움
② 사회적 네트워크 관점
③ 유연성과 기동성
④ 책임성
⑤ 심리적 연속성
→ **서비스 구조**

⑥ 불확실성에 대한 용인
⑦ 대화주의
→ **실행**

- **처음 다섯 개의 원리는 서비스의 구조에 관한 것이고, 마지막 두 개는 실행에 관한 것이다. 그러므로 현실에서는 이 모든 원리들이 서로 맞물리고 의존한다.**
- 6, 7번 원리와 관련된 추가적 핵심 요소(Key elements)들이 있다.

1) 7대 핵심 원리 개요

오픈 다이얼로그의 7가지 핵심 원리는 오픈 다이얼로그 서비스가 조직되고 실천되기 위한 핵심 요소들이다. 그러나 현재 시점에서 7가지 원리가 완벽히 적용되어 작동되는 정신건강 시스템은 핀란드 라플란드 지역에만 존재한다. 그 외에 오픈 다이얼로그를 새롭게 도입하는 국가들에서는 7가지 기본 원리 중 가능한 것들부터 우선적으로 적용하는 방식으로 시도되고 있다.

아래에 각각의 7개 핵심 원리에 대해 설명한다.

제1원리 : 즉각적 도움

누군가가 정신건강 위기에 처하여 처음으로 서비스와 접촉하면, 응대하는 직원의 주도로 (당사자/가족이 더 나중에 모이자고 요청하지 않는 한) 24시간 안에 모임이 열리게 된다. 서비스와의 최초 접촉은 의사, 다른 기관의 전문가, 염려의 중심에 놓인 인물4(당사자), 또는 그의 가족 등의 다양한 경로로 개시될 수 있다.

서비스 제공자의 기본 태도는, 사람들이 도움을 요청할 때는 항상 정당한 이유가 있으며 따라서 그들의 우려를 진지하게 받아들여야 한다는 것이다. 사람들이 느끼는 지원의 필요성은 항상 긴급하며, 제때 효과적인 방식으로 접촉이 이루어지면, 위기가 악화될 가능성과 입원의 필요성이 낮아진다.

중요한 사항은, 염려의 중심에 놓인 인물과 접촉하여 그의 경험에 관하여 대화할 수 있는 기회는 위기 기간 중 상당히 짧은 시간 동안만 열린다는 점이다. 그 기회를 놓치면, 다음 기회가 올 때까지 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있다.

첫 접촉의 대화에서는, 현재 상황과 관련자들의 우려를 이해하고 위험이 얼마나 심각하고 얼마나 신속한 대응이 필요한지 파악하는 데 시간을 들인다. 가족/네트워크가 참여하는 모임을 자택 또는 외래진료실 등에서 가지기로 결정되면, 누가 누구를 그 모임에 초대할지에 관하여 논의한다.

제2원리 : 사회적 네트워크 관점

염려의 중심에 놓인 인물의 사회적 네트워크에 속한 핵심 구성원들이 네트워크 모임에 초대된다. 그들은 가족, 친구나 동료, 이미 이 사안에 연루된 기타 전문가/기관일 수 있다. 정신증을 겪는 사람들에 대한 우리의 대응에 사회적 네트워크를 참여시키는 것은, 정신증 경험자가 자신의 인적 관계망으로부터 소외될 가능성을 줄이는 장점이 있다.

'정신증'이라는 꼬리표가 붙는 경험은 가족사의 맥락을 살피며 고찰할 때에 더 잘 이해될 수 있다. 이 과정에서 서비스 제공자들은 가족/네트워크가 자기네 이슈들을 함께 다루도록 조력하는 일에 초점을 맞추게 된다.

오픈 다이얼로그에서 강조하는 것은 가족의 '병리(pathology)'가 아니라 가족/네트워크 안에 존재하는 자원들이다. 네트워크 구성원들은 현재의 위기와 역사적으로 중요한 사항들을 조망하는 관점을 공유할 수 있으며, 다양한 형태의 추가적 지지를 제공할 수 있다. 이러한 공간에서 네트워크가 충분히 안전한 느낌 하에 모임에서 그것들을 다룰 수 있는 것이 바람직하다. 이 기존에 말할 수 없었던 이슈들에 관하여 말할 수 있는 가능성을 언급한다.

만약 가족/네트워크 내부에 학대나 폭력의 과거력이 존재한다면, 오픈 다이얼로그 팀이 조를 나누어 각각 다른 네트워크 구성원들의 소집단과 만날 수 있다. 이는 취약한 구성원들을 보호하기 위해서이다. 이후 전체 과정의 나중 단계에 모두 함께 만나는 것이 가능하고 바람직할 수 있다.

또한 염려의 중심에 놓인 인물이 참여하기를 원하지 않더라도 모임을 마련할 수 있다. 왜냐하면 오픈 다이얼로그 팀은 가족들의 불안에 직접 반응하는 것이기 때문이다. 즉, 서비스 이용자는 사실상 그들 모두이다.

제3원리 : 유연성과 기동성

이 원리에서 유연성이란 구체적으로 필요에 맞춘 반응을 뜻한다. 즉 다양한 형태의 대응을 제공하는 것, 그리하여 제공되는 서비스가 이용자들의 다양하며 변화하는 필요에 적합하게 만드는 것을 뜻한다. 네트워크 모임이 진행되는 중에도 언제든 개인 심리치료나 재활 치료, 그리고 직업적이거나 교육적 지원, 일상을 돕기 위한 실용적 조력이 제공될 수 있다.

무엇이 필요한지에 대한 판단은 모임 중에 네트워크가 공동으로 내린다. 이를테면, 다음 모임을 언제로 잡을지, 모임에서 무엇을 다룰 지를 공동으로 결정한다. 이는 네트워크의 현재 필요에 최대한 부응하기 위해서다.

기동성의 일차적인 의미는 가족의 현재 상황에 가장 적합한 세팅에서 네트워크 모임을 연다는 것이다. 서부 라플란드의 경우에 그 장소는 가족의 자택인 경우가 가장 많고, 때로 외래진료소, 학교, 직장, 병원(입원이 필수적인 경우에)에서도 모임이 이루어진다.

자택에서 모임을 여는 것은 여러 장점을 지닌다. 위기 상황에서 병원을 찾아가는 일 자체가 가족에게 난감한 일일 수도 있고, 염려의 중심에 놓인 인물이 이동을 거절하고 오픈 다이얼로그 과정에 참여하기를 아예 거부할 수도 있다. 이런 경우 모임이 가족의 자택에서 열리게 된다면 더 많은 사람을 참여시킬 기회가 생긴다.

또 다른 장점은 가족의 자연스러운 거처에서 함께 대화하면 가족의 삶을 더 풍부하게 느낄 수 있다는 것이다. 모임은 덜 딱딱하게 느껴질 수 있고 전문가 역시 통상적 업무 공간에 있을 때보다 겸허한 태도를 띠게 되는 경향이 있다.

제4원리 : 책임성

오픈 다이얼로그 팀원이 위기에 처한 가족으로부터 전화를 받으면, 전화를 받은 팀원이 첫 모임을 조직하는 책임을 가지게 된다. 대개 경험 많은 정신건강전문가가 그 역할을 맡게 되므로, 서비스와의 소통 첫 단계부터 가족은 능숙한 정신건강 전문가와 접촉하여 초기 지원을 받을 수 있다. 대응 팀이 꾸려지고 나면, 과정 전체에 대한 책임을 팀원들이 공유한다. 조력 과정을 어떻게 진행할지 결정하기 위해 외부 전문가(약물 치료 등에 관한권위자 등)가 초대될 수도 있다.

이 책임성이라는 개념은 오픈 다이얼로그의 핵심에 위치하는데, 시의 적절한 대응에 기초를 두고 가족의 필요와 소통에 중점을 둔다.

제5원리 : 심리적 연속성

가족/네트워크를 위한 팀이 꾸려지고 나면, 더 이상 조력이 필요 없게 될 때까지 동일한 팀이 가족/네트워크와의 협업을 이어간다. 서비스가 종료된 이후에 다시 가족/네트워크에게 추가적인 도움이 필요해지는 경우에도 동일한 팀이 대응에 나선다.

물론 오픈 다이얼로그 접근은 사회적 네트워크 내부의 자원들을 강화하여 서비스에 대한 의존을 줄이도록 설계되어 있지만, 그럼에도 불구하고 이러한 연속성은 중요하다. 실행자들이 오픈 다이얼로그 과정에서 동원하는 기술들이 어떻든 간에, 이 작업의 핵심은 '인간관계'이기 때문이다.

또 다른 중요한 특징 하나는 염려의 중심에 놓인 인물이 지역사회 안에 있건 병원에 있건 상관없이 동일한 팀이 네트워크와 협업한다는 점이다. 즉, 지역사회에서 일하는 전문가들이 병원에서 열리는 네트워크 모임에 참석할 수 있고, 병원의 전문가들이 지역사회에서 열리는 네트워크 모임에 참석할 수도 있다.

동일한 팀원들이 지속되는 것과 마찬가지로, 사회적 네트워크의 구성원들도 과정 내내 참여할 것을 초청받는다.

제6원리 : 불확실성에 대한 용인

오픈 다이얼로그에서는 모든 각각의 위기가 독특하며 따라서 작업 수행 중에 많은 불확실성을 용인할 필요가 있음이 인정된다.

실제로 위험과 감정이 고조된 위기 시점에, 무슨 일이 일어났고 현재 어떤 상황이 전개되며 무엇이 필요한지에 대한 확실한 결론이 요구되는 경우가 일반적이기 때문이다. 네트워크 구성원들은 역시 신속히 어떤 조치가 이루어지고 해결되기를 기대할 수 있다. 이러한 상황에서 불확실성을 감당하는 것이 어려운 일이기 때문에 '용인(容忍)'이라는 단어가 이 핵심 원리의 성격으로 채택되었다.

오픈 다이얼로그 팀은 적극적으로 모임에 참여하는데, 그 방식은 지시나 설명 보다는 경청에 주안점을 둔 특별한 기술과 태도로 이루어진다. 그 과정 안에서 사람들이 오픈 다이얼로그 과정을 신뢰하면서 충분한 안전감을 느끼도록 도움을 받는다. 실행자들은 서서히 대화를 진행하며 모든 이들이 각자의 경험과 현재 상황을 이해하는 방식을 발언할 수 있도록 돕는다. 섣부르게 답변을 하거나 결론을 내려 하지 않고 집단적 대화로부터 자연스럽게 이해가 생성되기를 도모한다.

위기의 초기 모임에서는 여전히 많은 것이 불확실하고 그에 따라 불안이 높을 수 있으며, 그 경우 팀이 그 상황을 받아들이며 당사자와 네트워크가 다음 모임까지 어떻게 감당을 하며 위험을 다룰 수 있을지에 관해서도 함께 숙고한다.

이 원리의 핵심을 이루는 것이 팀워크이다. 보통 두세 명의 촉진자로 이루어진 팀이 네트워크 모임을 진행하게 되는데, 이러한 공동 촉진을 통해 실행자들이 불확실성을 용인하고 성급한 결정을 피하는 데 도움이 된다. 함께 작업함으로써 팀원들은 모임에서 듣고 보는 것에 대한 스스로의 반응과 숙고를 통해 더 많은 것을 알아챌 수 있다. 즉각적인 답을 제시하기 보다는, 모든 팀원들이 당사자와 가족의 고통과 소통을 신중하게 경청하고 진지하게 받아들이는 과정을 통해 네트워크 구성원들은 무언가 중요한 작업이 이루어지고 있다는 경험을 하게 된다.

이 모든 과정에서 '안전(safety)'이 담보되는 것 역시 중요한 요소이다. 서부 라플란드 시스템에도 자타해 위험 등의 응급상황이 염려되는 경우 비자의 입원이 진행되는 절차가 존재한다. 응급 상황에서는 무리하게 오픈 다이얼로그를 진행하기 보다는 비자의입원이 진행되지만, 그 절차 이전에 경청에 기반한 정중한 개입이 이루어지게 되므로 강압적 절차로 인한 후유증을 방지할 수 있다.

제7원리 : 대화주의

대화는 오픈 다이얼로그의 과정인 동시에 목표가 된다. 위기 시에 네트워크 구성원들은 현재 상황에 관한 강한 느낌들과 견해들을 품는데, 그것들이 대화 속에서 표현될 필요가 있다. 그들의 근심이 신중하게 경청 받고 진지하게 응답 받으며 네트워크 구성원들이 점점 더 많이 자기를 표현할 수 있도록 공간이 제공되면, 대화의 기회도 점점 증가하게 된다.

여기에서 결정적으로 중요한 것이 팀워크다. 위기 시에 두 명 이상의 촉진자가 모임에 참석하여 서로 대화하고 각자의 차이를 존중하면서 서로의 말을 신중하게 경청하는 방식으로 대화를 촉진한다.

2) 대화주의와 관련된 개념들

반응적 경청 (Responsive listening)

대화적 실행 과정에서 그들은 참여자들의 상호작용, 대화가 다루는 주제들, 사용하는 언어, 제기되는 실질적 요구들을 따라가게 된다. 증상들을 평가하고 진단을 내리는 데에 초점을 두기 보다는, 네트워크가 겪는 난관에 대해 그들이 이해하는 방식과 무엇이 좋은 결과라고 보는 지에 관한 그들의 의견을 탐색해 나가려 시도한다.

오픈 다이얼로그 실행자들은 경청에 열중하며, 언어적 또는 비언어적 소통에 대한 반응을 통해 네트워크 구성원들이 존중받는다고 느끼고 충분히 안심하면서 자기 경험을 공유할 수 있도록 기여해 나간다. 치료진의 이러한 반응적 경청의 결과로 네트워크 구성원들은 자기 경험의 더 내밀한 부분을 개방할 수 있다.

행위자성 (Agency)

치료진보다 네트워크 구성원들이 더 대화에 많이 기여할수록 경과가 양호해진다.

오픈 다이얼로그에서는 네트워크 구성원들이 자신들의 주제를 주도적으로 함께 다루어 나갈 수 있도록 도움으로서 그들 자신의 '행위자성(agency)'이 증가하도록 돕는다. 네트워크 구성원들이 이런 식으로 자신들의 이슈를 스스로 다루도록 치료팀은 자연스럽게 공간을 제공한다.

'함께(withness)'와 '관하여(aboutness)'

치료진은 전문가의 위치를 고수하며 임상적 응시를 하는('관하여' 생각하는) 대신, 일상 언어를 사용하면서 네트워크와 참여한다('함께' 생각한다). '함께' 생각하기의 태도를 가짐으로써 전문가는 작업에 '자기 자신'을 더 많이 투입하게 된다. 그 과정에서 치료진은 스스로의 감정적 반응을 중요하게 살피게 된다.

진정성과 창조성

오픈 다이얼로그에서 실행자들은 네트워크 구성원들이 상호관계 속에서 자신의 목소리를 발견하고 자신의 의견을 최대한 진정성 있게 밝히도록, 즉 자신의 진실을 말하도록 독려한다. 아울러 오픈 다이얼로그 과정에는 창조성이 내재한다. 사람들 사이의 공간에서 새로운 이해가 발생하며, 기존에 언어화되지 않았던 경험을 표현할 수 있는 어휘들이 발견될 수 있다.

3) 그 외의 중요 원리들

평등, 민주주의, 존중

오픈 다이얼로그에는 모든 참여자의 살아있는 경험에 대한 깊은 존중이 내재한다. 모임에서는 합의를 추구하기 보다는 다양한 관점들과 목소리들을 나란히 놓고 생산적으로 소통하려 애쓴다. 네트워크 모임에서 모든 목소리가 평등하게 취급되며, 치료팀은 자신들의 견해를 다른 참가자들에게 강요하려 하지 않는다.

투명성(과 반영하기)

오픈 다이얼로그 중에 치료팀은 네트워크 구성원들이 없는 자리에서 네트워크에 관하여 대화하지 않는다. 이는 네트워크에 대한 존중 때문만이 아니라, 대화가 네트워크 모임 안에서 이루어지고 전문가들이 어려운 사안들을 다른 곳으로 가져가지 않고 모임 안에서 솜씨 있고 존중 어리게 다룰 때에 오픈 다이얼로그의 과정이 더 강화되기 때문이다.

네트워크 모임 안에 반영5의 절차를 두는 것은 투명성을 확보하는 한 방식이다. 팀원들은 모임당 최소 한 번, 각자가 조금 전까지의 모임에서 경험한 생각, 느낌 또는 연상을 서로에게 묻고 대답하게 된다. 반영은 대화 도중에 팀원들이 반영을 위해 서로에게 도움을 청하는 방식으로 자연스럽게 시작할 수도 있고, 더 격식을 갖춰 반영을 공유하는 것에 대한 허락을 가족에게서 얻고 시작할 수도 있다.

반영할 때 팀원들은 서로의 생각, 느낌, 연상을 사색적인(단정하지 않는) 방식으로, 일상 언어를 사용하여 공유한다. 반영 시간은 네트워크가 그저 경청하기만 할 기회가 되기도 한다. 팀원 각각이 차례로 반영한 다음, 네트워크 구성원들은 들은 반영 중 어느 것에든지 반응해달라는 요청을 받는다.

과정을 지향하는 실행

두 가지 이유에 따라 오픈 다이얼로그 실행자들은 '과정을 신뢰한다'는 말을 즐겨 한다.

첫째로 오픈 다이얼로그 작업은 목표 보다는 과정을 지향한다. 특히 중요한 것은 충분한 시간을 들여 네트워크 모임들에 참석하여 주제를 함께 다양한 방식으로 다루려 노력하는 경험이다.

둘째로 사회적 네트워크와 치료팀 모두가 7대 원리를 지향하며 네트워크 모임에 열심히 참여하다보면, 대개 가장 중요한 주제를 다룰 수 있고 긍정적 성과가 나올 가능성이 높다. 일반화하기는 어렵지만, 일반적으로 독백적 소통에서 대화적 소통으로의 변화하는 동안 위기가 극복되는 경우가 많다.

05 오픈 다이얼로그의 12가지 핵심 실행 요소

오픈 다이얼로그 7대 핵심 원리 중 마지막 2가지인 '불확실성에 대한 관용' 과 '대화주의'는 네트워크 미팅 안에서 촉진자들이 당사자, 가족과 공동작업을 하는 과정에서 취하는 기술과 태도에 관한 것이다. 이러한 오픈 다이얼로그 고유의 실행 기법에서 드러나는 핵심적 방법론이 연구를 통해 제안되어 있으며, 오픈 다이얼로그 훈련과 실행 수퍼비전, 평가 지침으로 이용되는 충실도 척도의 기반을 이룬다(Olson, Seikkula, and Ziedonis 2014).

| 오픈 다이얼로그의 12가지 실행요소

① 두 명의(또는 더 많은) 치료자가 네트워크 모임에 참석할 것
② 가족과 네트워크가 참여할 것
③ 개방형 질문들을 사용할 것
④ 내담자의 발언에 반응할 것
⑤ 현재 순간을 강조할 것
⑥ 여러 관점들을 끌어낼 것
⑦ 대화에서 관계에 초점을 맞출 것
⑧ 문제 담론이나 행동에 객관적으로 반응하고 의미에 주의를 기울일 것
⑨ 내담자의 증상이 아니라 내담자 자신의 말과 이야기를 중시할 것
⑩ 치료 모임 안에서 전문가들 사이의 대화(반영)를 할 것
⑪ 투명할 것
⑫ 불확실성을 용인할 것

① 두 명(이상)의 치료자가 네트워크 모임에 참석할 것

치료진은 팀으로 작업할 때 더 보고 더 들을 수 있으며 위기상황에서 더욱 도움이 된다. 그리고 그들 사이의 반영 작업을 통해 대화가 촉진되며 종사자들이 서로 경청함으로써 가족/네트워크 멤버들도 서로 경청할 가능성을 높일 수 있다. 또한 여러 동료들과 함께 함으로써 안정감이 증가될 수 있는데, 실제로 심한 위기상황에서는 3명 이상으로 이루어진 팀이 필요하기도 하다. 이러한 방식은 종사자 한 명이 이직을 하게 되더라도 팀의 연속성이 유지될 수 있는 장점을 가지기도 한다.

특히 중요한 것은 팀워크인데, 치료진 간에 믿음이 필요하며 이것은 네트워크 미팅을 위한 기본적인 준비이다. 구체적으로, 팀원들 간의 관점 차이가 존재하며 그것을 인정하는 팀워크는 도움이 된다. 하지만 지나친 차이나 갈등은 도움이 되지 않으므로 기본 가치를 공유하는 팀이 좋다.

② 가족과 네트워크가 참여할 것

위기 당사자, 가족 및 관련된 개인들을 처음부터 치료 미팅에 초대한다. 당사자와 가족을 지지하기 위해 당사자의 사회 관계망 중 다른 핵심 인물을 초청할 수도 있다. 이러한 사회 관계망은 자원, 즉 자연적인 지지체계로 간주되는데, 공무원, 동료, 고용주, 이웃, 친구 등이 포함될 수 있다.

모두 함께 모일 수 없다면 팀은 가족 구성원들과 사회 관계망 멤버들을 분리해서 따로 만날 수도 있다. 예를 들어 가정폭력의 존재하나 언어적 비난이 심한 경우에는 누군가 모임을 안전하지 못하게 느낄 수 있다. 이런 경우는 별도의 모임을 마련하는 것도 가능하다.

③ 개방형 질문들을 사용할 것

첫 질문은 가능한 열린 질문으로 시작한다. 그래야 가족이나 네트워크 멤버들이 그들과 가장 연관된 이슈를 먼저 말할 수 있게 된다. 초기 치료 미팅에서는 모든 참가자에게 두 가지 중요한 질문을 꾸준히 제시한다.

- "오늘 우리와 함께하게 된 연유는 어떠하신지요?"
- "오늘 이 시간을 어떻게 활용하고 싶으신가요?"

두 번째 질문은 이후의 모든 모임에서도 반복된다. 이렇게 함으로써 참가한 모든 이의 생각을 공평하게 다루고 참가자들 스스로 어떤 문제를 다룰 것인지를 결정할 수 있게 된다. 대화가 진행되면서 다른 참가자들이 나누어진 내용에 응답할 기회가 주어지며, 전체 네트워크 미팅은 개방형 질문을 통해 이끌어진다.

첫 모임에서의 질문 예시:

- 모임을 갖게 된 배경은?
- 누가 먼저 모임을 생각했나?
- 모임에 가장 강하게 동의한 사람과 약하게 동의한 사람은 누구인지?
- 이 모임을 어떻게 이용하고 싶으신지?
- 어떤 방식으로 시작하는 게 좋을까? 누가 시작할 건가?
- 모든 사람들이 질문들에 답할 기회를 가져야 한다.

④ 내담자의 발언에 반응할 것

당사자와 가족의 발언에는 언어적 표현, 비언어적 신체 반응, 침묵 등이 포함된다. 촉진자들은 아래의 세 가지 접근법을 사용하여 이들에게 반응하게 된다.

· 첫째, 당사자가 사용한 말을 활용한다.

· 둘째, 사려 깊고 공감적인 경청을 사용한다.

· 셋째, 침묵을 포함한 비언어적 반응을 지속적으로 파악한다.

이를 통해 평온하고 수용적인 분위기가 조성되어 중요한 이야기가 드러나게 되며, 그것들을 털어놓을 안전감과 자신감이 촉진된다.

기술적 요소 :

· 네트워크 멤버의 단어를 사용
- 사용한 단어를 그대로 반복
- 더 많이 듣고, 더 많이 이해할 수 있기 위한 질문에 그 단어들을 포함

· 반응적으로 경청하며 참여
- '초심자의 마음'으로 전제 없이 경청
- 관계망 멤버들이 중요한 개인사를 공유할 수 있는 분위기를 조성

· 침묵을 포함한 비언어적 소통에 동조(attunement)

⑤ 현재 순간을 강조할 것

대화 중에는 누군가 말을 하는 동안에도 흥미, 두려움, 기쁨 및 슬픔과 같은 다양한 반응이 계속해서 나타난다. 치료팀은 대화의 주제나 내용에만 집중하면서 동시에 순간 순간마다 일어나는 일에 주의를 기울인다. 치료팀은 참가자들이 그 순간에 일어나는 중요한 감정적 변화를 편안하게 토론할 수 있는 공간을 만들고 응답하여 개인들이 자신을 확신하며 표현할 수 있도록 돕는다.

기술적 요소 :

· 사건의 보고보다는 즉각적인 반응을 우선시한다.

· 솟아나는 감정을 허용하며, 해석하려 하지 않는다.

05 오픈 다이얼로그의 12가지 핵심 실행 요소

⑥ 다양한 관점들을 끌어낼 것

대화에서는 합의가 아니라 여러 관점과 목소리의 병치와 창의적 교류를 추구한다. 대화의 목표는 의견의 합의를 찾는 것이 아니라 다양한 목소리 간의 창의적인 교류를 촉진하는 것이다. 그러므로 대화 중 그 누구도 잘못 말했구나 라는 느낌을 받아서는 안 된다. 즉 네트워크 멤버들 각자가 다양한 방식으로 자신의 관점과 경험에 대해 이야기하도록 격려 받는다.

그것을 위하여 치료팀은 다음 두 가지 형태의 폴리포니(Polyphony)[6]를 촉진하는 방식으로 참여한다.

- 외적 폴리포니 (공간에 모인 개인들 사이의 다양한 목소리):
  모든 참석자의 목소리가 들리고 존중되는 환경을 조성하면서 이를 방해하는 행동에 개입한다.
- 내적 폴리포니 (한 개인의 마음 속에서의 다양한 목소리):
  각 개인이 자신의 마음 속의 다양한 생각과 경험을 탐색하고, 모순을 다룰 수 있도록 돕는다.

⑦ 대화에서 관계에 초점을 맞출 것

개인 간의 관계의 역학은 문제나 증상 주변의 상황 및 대화 설정에서 발생하는 일에 강력한 영향을 미친다. 그러므로 오픈 다이얼로그에서는 대인 관계와 관련된 다양한 질문 기법을 사용하여 관계와 관련된 문제를 주의 깊게 다룬다.

때로 네트워크 멤버가 전문가에게 비판적/분노 감정을 표출하는 것은 병적인 것이 아니라, 그들의 실제 관계 또는 전문가와의 특정 상호 작용에 대한 반응으로 이해해야 한다. 체계적 가족 치료에서 유래한 '순환적 질문" 등의 기법이 사용.

⑧ 문제 담론이나 행동에 객관적으로 반응하고 의미에 주의를 기울일 것

어떤 행동이 일견 문제가 있는 것처럼 보이더라도, 그것을 '질병'의 결과물이 아니라 힘겨운 상황에 대한 '자연스러운 반응'으로 인식하려 한다. 그래서 문제나 증상을 병적으로 인식하는 대신, 그것이 개인에게 어떤 의미를 가지는지를 탐색한다. 이는 '누가 건강하고 누가 아픈가'와 '무엇이 옳고 무엇이 틀린가'와 같은 구분을 넘어서는 새로운 이해를 촉진한다. 그러나 위법적 행동이나 자타해 위험에 대해서는 관련된 법과 절차를 우선적으로 적용하여 개입하는것이 네트워크 모임에 앞서는대원칙이다.

기술적 요소 :

- '긍정적 함축(positive connotation)'과 '시스템적 관점 바꾸기(systemic reframing[8])' 같은 치료적 형태의 반응들을 사용하여 '사람들의 모든 행동은 기능을 가진다'는 것을 이해

⑨ 내담자의 증상이 아니라 내담자 자신의 말과 이야기를 중시할 것

오픈 다이얼로그에서는 증상에 집중하는 대신 사람들의 경험, 생각 및 감정에 귀를 기울인다. 삶에서 일어난 일들에 중점을 두고 네트워크 멤버들이 증상 보고 보다는 자신의 경험, 생각, 감정을 공유하도록 북돋운다.

심각한 '증상'은 일상적인 언어로 표현/발언되기 어려운 트라우마/딜레마로 이해된다. 이처럼 큰 두려움이나 고통이 동반된 중요한 주제는 말보다는 증상으로 주로 표현될 수 있는데 관련한 한 단어만 발언 되더라도 치료팀은 그 단어를 소중히 경청하며 새로운 다른 말이 발언될 때까지 기다린다. 이처럼 한 사람의 경험을 함께 이해할 수 있도록 노력하는 것을 목표로 한다. 종사자는 누군가의 고통에 관한 이야기에 접근할 수 있는 단어에 집중하며, 대화 과정에서 아직 적합한 단어/언어가 부재한 경험에 관한 새로운 단어와 공통 언어를 발견할 수 있게 되기도 한다.

⑩ 치료 모임 안에서 치료팀 사이의 대화(반영)를 나눌 것

네트워크 모임 도중 치료팀끼리 참가자들의 이야기를 듣는 동안 마음이 움직인 것, 떠오른 이미지, 아이디어 등을 논의하며 성찰하는 시간을 가지며 이것을 '반영(reflection)' 작업이라고 한다. 모임 때마다 이 과정이 행해지며 네트워크 멤버들의 허락을 얻어 그들이 보는 앞에서 이루어지는데, 대개 네트워크 구성원들은 치료팀의 생각을 듣는 것을 흥미로워한다.

기술적 요소 :

- 치료팀 멤버들이 참가자들을 바라보지 않고 서로 마주 바라본 상태로 이루어진다.
  이것은 참가자 들에게 "말하는 시간"과 "듣는 시간"을 분리할 수 있는 기회를 제공한다.
  말하기 시간에서는 다른 개인들과 대화 (외적 폴리포니)를 나눌 수 있으며, 듣기 시간 (반영 시간)에서는
  치료팀이 나누는 말에 대답해야 할 압박 없이 자신의 내부 목소리와 대화를 나눌 수 있다(내적 폴리포니).
- 반영 시간은 또한 치료진이 자신의 내적 폴리포니에 접근하는 시간으로도 기능한다.
  반영 후에는 참가자들이 토론에 대해 어떻게 느꼈는지 듣는 과정이 이루어진다.
- 반영에는 또한 미래의 치료 계획에 대한 논의가 포함되기도 하는데 이러한 방식은 오픈다이얼로그의 또 다른 실행 요소인
  '투명성'을 담보하는 데에 기여한다.

⑪ 투명할 것

치료팀은 당사자가 없는 자리에서 당사자에 대한 중요한 논의를 하지 않는다는 '투명성(Transparency)' 원칙을 추구한다. 입원, 약물, 다른 형태의 서비스 제공에 대한 모든 논의는 모든 사람과 함께 이루어지며, 결정은 가능한 한 공동으로 이루어지도록 노력한다. 반영 과정을 가지는 것 역시 투명성을 지키려는 노력의 일환이다.

⑫ 불확실성을 용인할 것

이 요소는 오픈 다이얼로그의 7대 핵심 원리 중 하나이기도 하다. 이 실행 요소는 모든 위기 상황은 고유하며 특별한 것이라는 관점에서 비롯된다. 그러므로 상황에 대한 섣부른 해석 성급한 결론이나 결정은 피하고 신중하게 공동 작업을 도모한다.

기술적 요소 :

· 공동 작업이 충분히 안전하다고 느껴질 때에 구성원들은 불확실성을 더 견딜 수 있다.

· 사람들이 충분히 경청 받을때에 안전하다는 느낌을 더 가진다.

06 오픈 다이얼로그 미팅의 기본 구조

위의 핵심 요소들을 사용하여 오픈 다이얼로그를 촉진하는 과정에서 치료진들이 항상 염두에 두어야 하는 태도와 기본적 개입의 예시를 아래에 요약하였다.

모임의 시작

오픈 다이얼로그에서 첫 모임을 시작할 때의 표준적인 질문은 아래와 같다.

- "이 모임이 열리기까지 어떤 일들이 있었나요?"
- "당신은 무엇 때문에 우리 서비스에 연락하시고 오늘 이 모임에 참석하시게 되었나요?"

위 예시는 촉진자가 던질 수 있는 가장 중립적이며 유도하지 않는 질문이다. 모임의 의도는 네트워크 멤버들이 어디로든 대화를 자기네가 끌고 가고 싶은 곳으로 이끌도록 돕는 것이다(Razzaque 2019).

두 번째 모임부터는 모임의 시작에서 대개 아래와 같은 표준 질문으로 대화가 시작되게 된다.

- "여러분은 오늘의 대화를 어떻게 이용하고 싶으신지요?"

이 질문에 관한 각자의 의견을 청취하면서 자연스럽게 대화가 이어지게 된다.

06 오픈 다이얼로그 미팅의 기본 구조

아래에 네트워크 모임의 도입과 진행 단계의 원칙과 적용 가능한 개입의 예시가 제시되어 있다.

오픈 다이얼로그를 어떻게 진행하는가 – 모임의 시작과 진행

- 대화의 목적은 "변화", "치유", 또는 "결정"을 내리는 것이 아님
- 대화를 계속하고 확장하며 깊게 진행하는 것을 목표로
- "논쟁", "설득", "설명"은 대화를 방해하는 것 뿐이라는 것을 이해해야
- 당사자의 주관성, 그들이 살고 있는 세계를 모두와 공유하는 상상을 소중히 여기기
- "옳음"이나 "객관적 사실"에 대한 개념을 일시적으로 미뤄두기
- 대화가 안락하고 안전한 장소가 되도록 하는 것이 중요

오픈 다이얼로그 진행 과정에서의 개입 예시 – 대화의 시작과 촉진

"저는 정신과 의사/간호사/사회복지사/동료지원가 ○○입니다"

촉진자들은 서로에게 "님"이라는 공손한 존칭을 사용

"오늘 어떤 이유로 여기 오셨나요?", "이 시간에 대한 기대는 무엇인가요?"로 시작

–"오늘 이곳에 오려는 생각이 어떻게 들었나요?"와 "오늘 무엇에 대해 이야기하고 싶으신가요?"

"만약 지금 ○○가 여기에 있다면, 그들은 무엇을 말할 것 같아요?"

"가족 내에서 이 문제에 대한 결정은 어떻게 이루어지나요?"

"이 문제에 대해 여러분 모두가 어떤 행동 또는 토론을 진행했나요?"

"아버지가 (구체적인 맥락을 삽입) 할때 어떻게 느꼈을 것으로 생각하나요?"

"만약 문제가 해결된다면, 어떤 일이 일어날 것으로 예상하십니까?"

"이전에 비슷한 상황이 발생한 적이 있나요? 그때는 어떻게 다뤄졌나요?"

"말과 행동이 다른 가족 구성원에게 미치는 영향은 무엇이라고 생각하십니까?"

Valtanen & Kurtti 2017; Open Dialogue Japan 매뉴얼 일부 번안

모임의 진행과 반영작업

반영의 첫 목적은 촉진자들이 경청하고 있음을 실제로 보여주는 것이다. 촉진자들은 네트워크의 말을 최대한 많이 사용하고 그 말이 촉진자들에게 어떻게 느껴졌는지 이야기한다. 심지어 신체 반응도 언급할 수 있는데, 어느 신체 부위에서 촉진자가 반응을 느꼈는지, 그 반응이 어떤 기분을 안겨주었는지 이야기한다. 이 과정에서 네트워크는 그들의 말이 얼마나 깊이 경청 받고 있는지를 이해하기 시작한다(Razzaque 2019).

네트워크 모임 중의 이러한 반영 절차는 기술적으로는, 모임 중간에 촉진자들이 잠시 대화를 멈출 것을 요청하고 잠시 촉진자들 간의 대화를 나눌 것을 네트워크 구성원들에게 정중하게 허락을 얻고 시작할 수도 있고, 대화 중간에 자연스럽게 시작이 될 수도 있다. 반영의 기본 태도와 예시가 아래에 요약되어 있다.

| 오픈 다이얼로그를 어떻게 진행하는가-반영

대화 중의 반영 (Reflection)

- 톰 안데르센과 그의 동료들이 개발

-오픈 다이얼로그에서의 기본 기술 중 중요한 요소

-당사자와 가족의 대화를 듣고 전문가들이 그들 앞에서 의견을 교환

· 대화에 다양한 차이"를 도입.
새로운 아이디어를 내며 참여 멤버의 내부 대화를 활성화하고 이해관계자들이 결정을 내리는 공간"을 만들어내는 작업

· 촉진자의 신호로 시작
타이밍과 빈도는 자유롭게 결정: 중요한 주제에 다가갈 때, 감정이 고조될 때 등

· "잠시 여러분들 앞에서 우리들 끼리 대화를 나누어 볼까 합니다. 잠시 들어주시겠어요?"
"보이지 않는 장벽"을 상상. 당사자 및 가족 구성원과 눈길을 주고받지 않음.

· 당사자가 보는 앞에서 치료 팀이 서로 대화에 참여

· 가능한 한 과거 주제에 대해 파고들거나 대화와 무관한 지식을 논의하지 않도록

· "우리는 이 방법을 시도해 볼 수 있습니다"와 같은 구체적인 제안과 조언도 선택지로 거론
그러나 "반영"을 단순히 조언을 제공하는 시간으로만 보지 않는 것이 중요

· 듣기와 대화를 촉진하는 태도를 육성하고 대화를 활성화하기 위한

· 근본적으로 초점은 개인이 "고민하는" 것에 맞추어야 하며 "증상"이나 "진단"이 아님
"거기 없는 사람들의 목소리로 고민하는 사람" vs "환각을 호소 하는 정신분열증 환자"

· 부정적인 평가를 자제하고 대신 그들의 노력과 어려움에 대한 공감과 이해를 강조

· 반영 후에는 개인이나 가족의 인상에 대해 문의

Valtanen & Kurtti 2017; Open Dialogue Japan 매뉴얼 일부 번안

모임의 마무리와 다음 약속 정하기

네트워크 모임의 후반부는 마무리 작업에 할애된다. 그 과정의 대화에서는 아래와 같은 주제가 다루어질 수 있다.

· 우리가 중요한 이야기를 모두 나누었는가?

· 어느 분이든 더 하고 싶은 말씀이 있는가?

· 다른 상황이나 모임에서 더 다루고 싶은 주제가 있나요?

모임에서 결정한 내용이 있을 시, 그것에 대해 요약할 수 있다. 또한 상황이 여전히 불확실해 보일 경우, 이것에 대해 인정하는 것도 자연스럽다. 그 과정에서 위험에 대한 평가와 대비가 이루어질 수 있다. 필요한 경우 안전을 확보하기 위한 계획을 정하고 연락 방식을 정한다.

· 다음 모임 때까지 충분히 안전하다고 느끼십니까?

모임 종료 시점의 질문들 :

· 모임을 또 가지길 원하세요?

· 그렇다면, 언제 모임을 갖고 싶으실까요?

· 더 생각해 보시고 나중에 전화주시겠습니까?

· 다른 초대할 사람이 있을까요?

07 정신증[9]에 대한 이해와 접근

오픈 다이얼로그의 정신증에 대한 태도는, 전통적 의학 모델보다는 리커버리(Recovery) 모델의 핵심과 일맥상통한다.

"대화가 정신증을 치유한다. 왜냐하면 대화는 인간성의 기초이며 정신증 행동은 정상적인 삶의 일부이기 때문이다"

–야코 세이쿨라

오픈 다이얼로그에서 정신증 행동은 다른 질환을 다룰 때처럼 명확한 범주적 현상들의 집합으로 간주되지 않는다. 대신에 그 행동은, 너무나 '버거운' 경험들, 그래서 그것들에 관한 논리적인 발언이 구성되기 불가능했던 경험들을 감당하기 위한 능동적 노력의 결과로 간주된다(Seikkula 2021).

오픈 다이얼로그에서 환각이나 망상을 말로 표현하는 작업은 힘겨웠던 과거 경험에 관한 이야기를 발언함으로써 재구성하는 작업의 시작이라고 할 수 있다. 이전에는 견딜 수 없고 생각할 수조차 불가능했던 것이 더 견딜만하게 변화하는 것이다. 또한, 정신증을 경험하는 인물이 자신의 반응들을 더 충분히 이해하고 그것들이 현재 및 과거의 경험들과 어떻게 연결되어 있는지를 깨닫도록 돕는 것이다.

오픈 다이얼로그 팀의 역할은 정신증을 경험하는 인물과 네트워크가 모임의 내용을 이끌도록 돕는 것이다. 치료의 출발점은 가족의 언어, 즉 가족이 문제를 그들 자신의 언어로 어떻게 명명하거나 이해하는 지로부터 시작한다. 치료 팀은 정신증을 경험하는 인물과 그 가족의 고유한 필요에 적합하게 팀의 언어를 조정한다.

누군가의 환각이나 망상에 관한 이야기를 처음 들을 때는, 그 내용을 따라가고 이해하기가 불가능 한 것처럼 느껴질 수 있다. 그러나 환각이나 망상을 여러 목소리들 중 하나로 받아들이는 것이 중요하며, 대화를 시작할 때는 이의를 제기하지 않는 것이 좋다. 대신 정신증을 겪는 당사자에게 자신의 경험에 관하여 더 많이 말해 달라고 요청한다.

대화의 목표는 원천 경험(들)을 정확히 알아내는 것이 아니라 다양한 이슈들에 관한 토론을 북돋는 것이며, 그런 토론이 치유의 길을 열어줄 수 있다. 실행자들에게 중요한 태도는 위기에 처한 사람들이 하는 모든 말을 – 특히 '정신증적' 발언을 – 무의미하거나 불가해하다고 간주하지 말고 더없이 진지하게 받아들이는 것이다.

예컨대 한 팀원이 이렇게 물을 수 있을 것이다.

"당신이 이웃의 생각을 조종할 수 있다고 말씀하신 것 같은데 제가 제대로 들은 건가요? 그 얘기를 더 자세히 해 주실 수 있을까요?"

이어서 다른 네트워크 구성원들에게는 이렇게 요청할 수 있을 것이다.

"다른 분들은 어떻게 생각하시나요?"
"여러분은 00씨가 하신 말씀을 어떻게 이해하시나요?"

이런 질문의 목적은 논의되는 안건에 관하여 '정신증적인' 목소리(들)를 비롯한 다양한 목소리가 나오는 것을 허용하는 것이다. 팀이 다양하며 때로 모순되는 목소리조차 허용하는 성찰적인 분위기를 조성하는 데 성공하면, 네트워크는 복원과 회복의 이야기를 구성할 기회를 얻는다.

정신증을 경험하는 이들과의 대화를 위한 몇 가지 간단한 지침

가. 시종일관 관계에 집중하기

주요 과제는 모든 참석자를 동등하게 존중하고 포용하는 대화를 육성하는 것이다. 실행자들은 네트워크 구성원들이 자신의 삶에 관한 정보와 견해를 공유하도록 북돋는 한편, 또한 그들의 말을 계속 경청하고 숙고해야 한다.

위기 시에 모임은 정신증을 경험하는 인물의 말을 세심히 경청하는 것을 출발점으로 삼을 때가 많다. 또한 동시에, 때때로 정신증적 발언을 포함할 수 있는 이야기를 들으면서 다른 가족 구성원들이 어떻게 반응하는지도 면밀히 살펴야 한다. 그런 발언을 어떻게 생각하느냐고 그들에게 물을 때 최선의 방법은, 정신증 경험이 '진짜' 경험인지의 여부에 관한 논쟁에 빠져들지 말고, 발언자의 감정적 경험에 초점을 맞추는 것이다. 이런 식으로 치료 팀은 가족 구성원 간의 연결을 강화하고 고립을 줄일 수 있다. 실행자들은 정신증을 경험하는 인물을 비롯한 모든 가족 구성원의 경험을 진심으로 존중함으로써 네트워크 멤버들이 서로를 진지하게 받아들이는 태도를 강화할 수 있다.

나. 정신증 경험을 무조건적으로 존중하기

대화적 실행의 기본 요소 중 하나는 발언자의 말을 진지하게 받아들임으로써 발언자가 자신의 말을 더 깊이 자각하고 이해하게 만드는 것이다. 네트워크 모임에서 누군가가 정신증적인 방식으로 발언하기 시작한다면, 이는 바로 그 순간에 그가 자신의 삶에서 가장 힘겨웠던/트라우마적이었던 경험을 언급하기 시작하는 것일 가능성이 있다.

치료팀은 당사자의 발언을 온전히 수용함으로써 그가 자신의 환각이나 망상에 관하여 더 많이 말하도록 격려한다. 급성 위기에서, 정신증을 경험하는 인물의 대다수는 자신이 환청으로 듣는 목소리가 자신과 타인들이 공유하는 현실 속에 실재한다고 생각한다.

"잠깐만요, 당신의 남편이 당신을 죽이러 오고 있다는 생각이 든다고 말씀하신 것 같은데, 제가 제대로 들었나요? 우리가 그 생각을 이해할 수 있게 도와주실 수 있을까요? 언제부터 그런 생각을 하시기 시작했죠? 그런 생각이 항상 드나요, 가끔만 드나요?"

라고 물음으로써 그 인물이 자신의 경험을 더 많이 공유하도록 격려하는 것이 특히 중요하다. 이 질문들은 이례적인 경험을 병리적이거나 수용 불가능한 경험으로 치부하지 않고 일상적인 대화에 포함시키는 방법의 예이다.

치료팀이 협업하는 사람이 급성 위기에 처해 있건 더 나중의 치료 단계에 있건 상관없이 보편적으로, 우리는 '조현병/정신증 환자'와 대화하는 것이 아니라 인간과 대화한다는 태도를 취하는 것이 필수적이다.

우리가 병든 사람과 대화한다는 태도를 취하면, 우리는 상대의 경험에서 병리적 측면들을 탐색하는 일에 섣불리 초점을 맞추게 될 수 있다. 반면에 대화적 실행의 목표는 염려의 중심에 놓인 인물과 그의 가족 구성원들이 지닌 긍정적 자원을 끌어내는 것이다.

다. 발화된 이야기의 정서적 측면과 느낌에 중점을 두기

정신증을 경험하는 인물은 전문가 팀과 가족 모두를 겁먹게 할 만한 극단적인 이야기를 들려줄 가능성이 있다. 또한 강한 편집증적 믿음 체계는 전문가들을 난감한 상황에 봉착하게 할 가능성이 있다. 편집증적 생각을 가진 인물은 팀원들에게 자신과 믿음을 공유하느냐고 요구하면서 동의를 강요할 수도 있다.

경험/믿음이 진짜인지의 여부에 관한 논쟁에 빠지면, 그 인물의 삶과 그 믿음이 가지는 역할에 관하여 대화적으로 성찰할 길을 열기 어려워진다. 따라서 기본적인 대화 원리 하나는 당사자가 들려주는 경험의 감정적 측면들에 집중하는 것이다.

이를테면 이렇게 말할 수 있을 것이다.

"당신이 정말로 심한 괴로움을 느끼고 있는 것 같아요."

또는 이렇게 말할 수 있을 것이다.

"정말로 당신에게 위협적인 상황인 것 같네요. 당신이 위협당하는 것 같을 때 어떤 느낌이 드는지 말해주실 수 있을까요?"

08 오픈 다이얼로그 교육훈련

오픈 다이얼로그는 위기 당사자와 가족을 만나 대화하는 팀 기술인 동시에 서비스 전체를 조직화하는 방식이기도 하다. 이 기술과 조직화를 이루려면 정신건강 서비스 내의 많은 종사자들에게 오픈 다이얼로그 교육훈련이 제공되어야 한다.

핀란드 라플란드에서 오픈 다이얼로그가 탁월한 성과를 이룬 것의 핵심 요인은 양질의 교육훈련이었다는 것이 정설이다. 이후 세계적으로 오픈 다이얼로그가 보급되어 오는 과정에서 오픈 다이얼로그의 실행자격, 교육훈련 등에 대한 국제적인 합의가 만들어지는 중이다.

오픈 다이얼로그를 실천할 수 있는 자격 요건은 확장되고 있다

오픈 다이얼로그에는 정신과 의사, 심리학자, 간호사, 사회복지사 등의 정신건강 전문가들이 함께 촉진자 팀으로 협업해 왔으며, 최근 들어 동료지원가와 가족지원가 그리고 연구진으로 인문학자나 인류학자도 참여하는 쪽으로 확장되고 있다. 그러므로 오픈 다이얼로그를 실행할 수 있는 자격 요건은 상대적으로 덜 엄격하며 열려 있는 편이라고 할 수 있다.

오픈 다이얼로그 역량을 갖추기 위한 훈련 요건은 까다롭다.

정신증(Psychosis)등의 심리사회적 위기를 경험하는 당사자와 가족을 만나 다양한 형태의 불안과 갈등 상황을 감당하고 당사자와 가족을 안심시키고 조력할 수 있는 촉진자 팀의 역량과 팀워크가 대단히 중요하다. 그래서 오픈 다이얼로그를 수행할 수 있는 역량을 갖추기 위한 수련(training)의 구조와 내용에 대해 국제적 합의 존재하는데, 그 과정은 적지 않은 기간과 노력이 요구된다.

오픈 다이얼로그 훈련 프로그램의 단계

국가마다 맥락은 다르지만, OD 초기 도입의 첫 단계는 전문가가 OD 실천에 필요한 기술을 습득할 수 있도록 돕는 교육 프로그램의 도입이다.

장기간의 개량을 거쳐 현재 국제적으로 합의된, 오픈 다이얼로그 실행을 위한 최소한의 공식 교육은 16-20일로 이루어진 기초 훈련(Foundation training)이다(Putman and Martindale 2021). 영국의 국가보건서비스의 오데시(ODDESSI)시험(Razzaque 2021), 이탈리아 공공정신건강 종사자들에게 오픈 다이얼로그를 훈련한 사례(R. Pocobello and el Sehity 2017), 그리고 뉴욕의 파라슈트(Parachute) 프로젝트(Hopper et al. 2020) 등에서 모두 기초 훈련을 실시하는 방식으로 첫 도입을 시작한 것이 그 예이다.

한편, 본격적인 기초훈련 도입에 앞서 짧은 입문 워크숍이나 단기 교육을 실시하는 사례도 많은데, 이는 사회적 합의와 정책적 지원이 충분하지 않은 상황에서, 제한된 시간과 자원을 활용하여 OD를 현실적으로 도입하고 확산하기 위한 방안으로 볼 수 있다(Cho et al. 2024).

아래 그림에 OD 훈련의 단계와 구조가 요약되어 있다.

I 수련 (Training): 어떻게 배우고 익히는가? -오픈 다이얼로그를 할 수 있는 자격요건은 까다롭지 않다.
-오픈 다이얼로그 역량을 갖추기 위한 훈련 요건은 까다롭다.

오픈 다이얼로그 교육/자격 형태

입문레벨	**입문교육 (Introductory workshop)** : 7대 원리, 12가지 요소, 역사	1 ~ 4일	공식 수련이 아님 이 훈련만으로는 실행이 어려움
레벨 1	**기초훈련 (Foundation training)** : 이론, 기법 연습, 롤플레이, 원가족작업	16 ~ 20일 : 1년	오픈 다이얼로그 실행자로서의 공인 자격
레벨 2	**본격훈련 (Full training)** : 가족치료사 자격, 실제 사례 수퍼비전, 논문	3 ~ 4년	
레벨 3	**훈련자/지도자 양성과정** **(Trainer/supervisor training)** : 300시간 이상 임상/교육 경험, 비디오 수퍼비전, 실제 수퍼비전/교육 시행, 심화 이론, 수습 훈련자 경험	2년	입문교육, 기초훈련, 본격훈련을 할 수 있는, 즉 실행자를 양성할 수 있는 국제 공인 훈련자/지도자

그림 설명 :

입문 워크숍(Introductory workshop)은 전문가들이나 동료/가족 지원가들에게 오픈 다이얼로그를 소개하고 기본 개념과 작동 원리를 이해시키고자 하는 목적의 교육이며, 실천 역량을 갖추도록 하는 정규 교육은 아니다. 대개 최소 6시간 이상의 전일 교육부터 3-4일 가량의 교육의 범위 안에서 이루어진다.

레벨 1에 해당하는 기초훈련이 오픈 다이얼로그를 시행할 역량을 갖추기 위한 기본 훈련이다. 약 1년에 걸쳐 20일 가량의 전일 훈련이 이루어진다.

핀란드와 유럽에서는 정신건강전문가가 보다 밀도 있는 훈련을 경험하고 정신건강시스템 내에서의 가족치료사 자격증을 획득할 수 있도록 별도로 3년 기간의 본격 훈련 (Full training) 과정이 운영되고 있다.

위의 과정을 지도할 수 있는 훈련자 양성 과정이 별도로 존재하며 현재 전 세계에 약 150명의 국제공인 훈련자가 활동 중이다.

오픈 다이얼로그 훈련의 특성

촉진자로서 오픈 다이얼로그 네트워크 미팅을 진행하기 위해서는 상당한 솜씨가 필요하다 :

가족/네트워크가 위기 중에도 충분한 안전감을 느끼도록 도와야 하고, 기존에 불가능했을 수도 있는 방식으로 그들이 서로에게 열린 태도를 갖도록 지지해야 하고, 가족/네트워크와의 협업에서 치료진이 느낀 바에 관하여 당사자들 앞에서 개방적이고 투명한 태도로 반영을 공유해야 하고 그 안에서 새로운 의미들이 등장할 수 있는 대화적 틀을 구성하고 유지해야 하고, 위기 시의 강렬한 감정을 견뎌낼 능력, 현재 순간에서의 요구들에 대응할 능력이 요구된다(Putman and Martindale 2021).

이러한 역량을 갖추는 과정은 정교하게 디자인된 경험적 학습(Experiential learning)을 통해 이루어지게 되는데, 이러한 학습은 충분한 임상 및 이론 지식과 경험을 지닌 공인 훈련자가 지도하게 된다. 그러므로 오픈 다이얼로그 훈련은 문서로 매뉴얼화(Manualization)하는 것이 불가능한 것으로 간주된다.

관련하여 영국 오픈 다이얼로그 도입을 이끌어온 정신과의사 러셀 라자크는 아래와 같이 비유했다.

책은 공식적인 오픈 다이얼로그 훈련의 대체물이 아니다. 어떤 책도 그 훈련을 대체할 수 없다. 오픈 다이얼로그에서의 훈련은 뼛속까지 경험적인 노력이다. 교실에서 배운 것만으로 수영을 터득할 수 없는 것과 마찬가지로, 책에서 배운 것만으로 오픈 다이얼로그 실행을 터득할 수는 없다(Razzaque 2019).

오픈 다이얼로그 훈련은 매뉴얼화가 어렵지만 무작위로 이루어지는 것은 아니다. 장기간의 발전과정을 거쳐 개발된 훈련의 구조(structure)가 존재하며 이 구조는 몇 가지 요소들로 이루어져 있다. 이 구조 안에서 훈련 참여자들은 신중하며 동시에 유연하게 대응하는 능력을 발전시켜 나간다. 그래서 오픈 다이얼로그 훈련의 구조는 '자유에 종사하는 구조'로 비유되기도 한다.

기초훈련(foundation training) 개요 :

최초로 OD를 도입하는 시스템에서는 이 기초훈련을 제일 먼저 시도하는 것이 바람직하다. 약 16~20일 정도이지만 최근에는 20일이 권장된다. 기초 훈련에서는 실행이 매우 강조된다. OD의 7대 원리와 핵심 실행 요소, 발전사 및 운영 양상, 중요한 이론들에 대한 소개와 토론이 이루어지며 그 외 대부분의 시간은 아래와 같은 주제에 대한 다양한 연습(exercise)과 역할극(roleplay)의 공동작업을 통한 경험적 학습으로 이루어진다.

· 서비스 이용자/가족과의 첫 접촉에 관한 주제들

· 대화적 실행의 요소들, 특히 모임을 여는 방식, 반영으로 이행하는 방식, 모임을 마무리하는 방식

· 다양한 대응 기법 연습: 긍정적 함의(positive connotation), 메타 소통(meta--communication),
순환적 질문(circular questioning), 네트워크 구성원의 말에 '반응하기/복창하기' '침묵을 다루기' 등

· 더 구체적인 작업 시나리오들, 예컨대 위기 시의 개입, 정신증을 경험하는 사람들과의 협업, 폭력을 경험했고(했거나)
비밀을 가진 가족과의 협업, 아동과의 협업, 위기 계획(crisis planning) 등

· 참가자 자신의 사회적 네트워크와 원가족을 관계지도(relational map) 또는 심리학적 가계도(genogram) 등을 통해 탐색하는 작업

· 자신의 직업적 활동이나 그 너머의 삶에 관한 개인적 경험들에 대한 성찰

09 오픈 다이얼로그를 지탱하는 4개의 기둥

정신건강 서비스 시스템에 오픈 다이얼로그가 성공적으로 도입되어 지속적으로 작동하기 위해서는 여러 차원의 요소가 필요하다. 핀란드 오픈 다이얼로그 개발과 세계적 확산에 기여해 온 야코 세이쿨라(Jaakko Seikkula)는 이 요소들을 '오픈 다이얼로그의 네 기둥(pillars)'라고 표현하였다.

위 네 가지 요소 중 훈련/수련에 관해서는 앞서서 설명하였다.

오픈 다이얼로그를 지탱하는 4개의 기둥 – 야코 세이쿨라, 2023

수련/훈련(Training)

- 오픈 다이얼로그 실행자가 되기 위해서는 OD특유의 솜씨와 팀워크를 익히기 위한 공식 수련을 거쳐야 한다.
- 요구되는 공식 수련 과정에 대한 국제적 합의: 최소한 기초훈련(foundation training) 수료가 필요
- 실행자가 되기 위한 자격은 넓게 개방되어 있으나, 공식 수련에는 길고 고된 과정이 요구됨
- **오픈 다이얼로그에서의 훈련은 뼛속까지 경험적인 노력이다. 어떤 책도 그 훈련을 대체할 수 없다.**
  교실에서 배운 것만으로 수영을 터득할 수 없는 것과 마찬가지로, 책에서 배운 것만으로 오픈 다이얼로그 실행을 터득할 수는 없다.
  – 러셀 라자크

수퍼비전(Supervison)

- 오픈 다이얼로그 도입과 유지를 위해서는 지속적인 훈련자의 수퍼비전/자체 인터비전이 필요
- 실행자(팀)에 대한 지지와 조력이 필수적

연구(Research)

- 모든 오픈 다이얼로그 실천에는 그 효과성 검증과 방법론 개발을 위한 연구가 동반되어야

동료지원가(Peer supporter) 참여

- 오픈 다이얼로그 실천에는 '산 경험을 가진 사람들(당사자)'이 함께 해야

수퍼비전(supervision)

오픈 다이얼로그의 도입과 유지를 위해서는 경험 있는 훈련자에 의한 지속적인 수퍼비전이 필수적이다. 수퍼비전의 주요 초점은 치료진의 주관적인 경험과 질문에 놓인다. 수퍼비전은 오픈 다이얼로그를 위한 또 하나의 집단 과정이며 참여자들은 서로의 작업과 성찰로부터, 또 수퍼바이저(훈련자)의 촉진으로부터 배움의 기회를 얻게 된다.

09 오픈 다이얼로그를 지탱하는 4개의 기둥

전문 훈련자를 초빙하기 어려운 경우에는 오픈 다이얼로그 고유의 방식에 따르는 인터비전(Intervision)이 권장된다. 지식과 경험 수준의 위계를 어느 정도 전제하는 수퍼비전(Supervision)과는 달리, 오픈 다이얼로그에서의 인터비전(Intervision)은 참가자들이 서로 동등한 위치에서 조력하는 것을 지향한다. 인터비전은 한 팀을 이루는 촉진자들의 대화와 반영이 이루어진 뒤 동료 팀원들의 반영을 통한 지지와 조력이 이어지는 방식으로 진행되는, 또 하나의 대화적 작업이다.

연구(Research)

치료적 개입 조치들의 사용에 관한 결정은, 당사자가 개인이든 건강 돌봄 시스템 전체이든 상관없이, 근거에 기반을 두어야 한다(Rawlins 2008). 또한 국가에 따라 OD 서비스의 발전 방식이 상당히 다양한 양상을 보이므로 그에 따라 훈련과 서비스 발전에 관한 더 많은 기준들이 개발될 필요가 있으며 그 기초가 되는 연구가 필수적이다.

한편 현재 OD는 잠재적으로 새로운 정신건강 서비스 제공을 위한 패러다임으로서 초기 단계에 있다. 그러므로 OD에 관한 연구들은 전통적인 생물의학적 연구의 방법론을 뛰어 넘어 정성적 연구 질적 연구 등 다양한 방법론으로 발전할 필요가 있으며 최근에는 인류학적 방법론을 적극 적용하는 등 인문학적 영역으로 연구가 확장되고 있다(Mosse et al. 2023).

따라서 오픈 다이얼로그를 시스템에 새로 도입하려 기획할 경우, 관련된 방법론, 성과 등에 대한 연구를 동시에 기획하는 것이 필수적이다.

동료지원가(Peer supporter) 참여

동료지원가를 오픈 다이얼로그에 초대하는 일은 비교적 최근의 움직임이지만, 오픈 다이얼로그의 13번째 핵심 실행요소로 비유될 정도로 중요시되고 있는 지침이다.

동료지원가는 질환과 회복에 대한 자신의 산 경험을 나눔으로써 내담자들을 더 잘 공감하며 신뢰를 형성하여 치료팀과 네트워크 간의 관계를 강화할 수 있다(Repper and Carter 2011). 또한 동료지원가는 전통적인 치료 관계에서 발생할 수 있는 권위적 위계를 완화시킴으로써 오픈 다이얼로그의 철학인 평등하고 수평적인 대화의 생성에 기여한다(Seikkula and Arnkil 2013). 나아가 동료지원가는 당사자와 비슷한 시각에서 문제를 바라보며 심리적 안전감을 제공할 뿐만 아니라 치료팀에 독특하고 다원적인 관점을 추가할 수 있다(Borg et al. 2012). 이는 오픈 다이얼로그의 핵심 가치인 폴리포니의 생성에 기여한다.

또한 이 작업은 당사자 뿐 아니라 동료지원가들에게도 도움이 되는 것으로 알려져 있는데, 이는 '의도적 동료지원(Intentional peer support)'이 일방적 시혜가 아니라 동료지원가와 그 조력을 받는 당사자 사이의 '상호적인 배움(mutual learning)'의 과정을 강조한다는 면과 일맥상통한다(Fortuna, et al 2022).

동료지원이 회복 기반의 정신건강 서비스의 핵심 요소로 자리잡아가는 현재 추세에 발맞추어 오픈 다이얼로그 개발과 보급에 있어서도 필수적으로 포함될 필요가 있다.

10 한국에서의 오픈 다이얼로그 실천

1) 초기 도입

오픈 다이얼로그의 공식적 적용은 2020년 새로 개원한 경기도립정신병원의 회복/인권 기반 서비스에서 국내 최초로 시작되었다. 2019년에 재개원한 경기도립정신병원은 정신 응급 의료전달체계에서의 응급/행정 입원기능 강화를 운영 목적으로 설정했으며 동시에 5대 핵심 사업 중 3가지로 WHO 퀄리티라이츠의 인권/회복 서비스의 핵심 요소를 포함시켰다. 그 구체적인 항목은 비강압치료(Non-coercive treatment), 절차 조력을 통한 자기 결정권 지원, 오픈 다이얼로그(Open Dialogue), 동료지원이다.

오픈 다이얼로그 프로그램의 경우 '초기 집중 네트워크 면담'이라는 명칭으로 환자와 가족 대상으로 병원 치료진, 지역 정신건강복지센터 종사자, 동료지원 절차보조원과의 협업을 통하여 진행되었는데, 국제공인 훈련을 수료한 정신과전문의 주도로 이루어졌다는 면에서 국내 최초의 오픈 다이얼로그 도입 사례로 규정할 수 있다.

경기도립정신병원의 운영을 통한 성과는 여러 지표를 통하여 입증되었다. 2018년 기준 국내 정신의료기관 평균 재원기간은 199일인 데 비해 경기도립정신병원 입원환자 평균 재원기간은 21일이었다. 퇴원 후 지역사회 정신재활기관 연계 비율도 77%로서 심평원 통계 기준 2020년 조현병환자의 지역사회서비스 의뢰율 43.3%에 비해 크게 높았다. 특히 퇴원 후 환자들의 퇴원 후 1개월 이내 재입원율이 6.9%에 그쳤는데, 이는 건강보험심사평가원 통계 기준 전체 퇴원환자 재입원율 26.3%(2020년 국정감사제출자료), 조현병 환자의 퇴원 후 재입원율인 42.6%(2020년)와 비교해 대단히 낮은 수준이었다(제철웅 et al. 2022).

비공식적 방식으로 오픈 다이얼로그적 접근이 시도된 것은 훨씬 더 이전이었다고 할 수 있는데, 그 중 대표적인 것은 이음병원(경기도 용인시 소재)의 사례이다. 2012년에 치료공동체의 본격적 실천을 표방하며 개원한 이 병원에서는 초기부터 오픈 다이얼로그와 필요 맞춤 치료를 입원 치료에 적용하기 위한 시도를 시작했다. 입원 초기에 환자와 가족, 다학제 치료팀이 모두 모여 장시간 대화를 나누는 'DOTP(Dialogue of treatment plan; 퇴원 계획을 위한 대화)'라고 명명된 이 프로그램은 오픈 다이얼로그의 원형인 필요 맞춤 치료의 원리들을 한국 병동에 맞추어 변형한 방식이라고 볼 수 있다(이 내용은 '병원형 네트워크 미팅' 지침에서 별도로 기술된다).

2) WHO 퀄리티라이츠 연구개발 사업에 오픈 다이얼로그 탑재

이러한 새로운 시도가 이루어지면서 한국의 서비스 이용자 단체들은 지속적으로 WHO QualityRights 기반 서비스와 OD의 도입을 요구해 왔으며, 인권 기반 및 사람 중심 서비스의 존재와 필요성에 대한 공감대가 형성되었다(Park 2021). 그 결과, WHO QualityRights 기반 서비스의 필요성이 정신건강복지법 개정안과 새로운 정신건강 정책 혁신 계획에 언급되었다.

2021년, 보건복지부는 WHO QualityRights 기반 서비스의 한국 내 확산을 목표로 하는 R&D 프로젝트를 공고하며, OD를 포함한 교육 및 실행 지침의 개발을 요구하였다. 이 프로젝트의 일환으로 한국 최초의 OD 입문 워크숍과 1년간의 시험 운영이 이루어졌다(Cho et al. 2024). 시험 운영은 아래의 단계를 거쳤다.

1. 오픈 다이얼로그 워크숍

2023년 3월, 핀란드와 영국에서 초청된 국제 강사 두 명이 참여하여 5일간(총 40시간) 입문 워크숍을 진행하였다. 워크숍에는 정신과 의사, 간호사, 사회복지사, 임상 심리사, 동료지원가, 가족활동가, 인문학자 등 다양한 직군에서 총 28명이 참여하였다.

워크숍의 구성 요소는 OD의 7가지 핵심 원칙과 12가지 핵심 요소에 대한 이론 강의, 소그룹 실습 및 역할극을 통한 기법 연습, 국내 OD 도입 방안에 대한 심도 있는 토론이 포함되었다.

2. 오픈 다이얼로그 시험 운영

네트워크 모임 시험 운영은 2022년 10월부터 수원시 지역을 중심으로 진행되었다. 수원시행복정신건강복지센터에서 홍보가 이루어졌으며, 참여를 희망하는 개인 또는 가족이 센터에 연락하면 연구진으로 구성된 촉진자팀이 모임을 주관하였다. 모임 장소는 당사자가 선호하는 장소(대부분 자택)로 지정되었으며, 대상자는 정신병적 증상이 의심되거나 진단된 경우에 참여할 수 있었다. 연구 기간 동안 총 15 가족에 대해 100회 이상의 네트워크 모임이 진행되었으며, 모든 모임은 최소 90 분 동안 진행되었다.

촉진자팀에는 영국에서 국제 공인 오픈 다이얼로그 훈련자인 정신과전문의가 포함되어 핵심 요소의 충실성을 유지하기 위해 거의 모든 모임을 진행하였다.

3. 수퍼비전

네트워크 모임 중 일부는 당사자와 가족으로부터 동의를 받은 후 비디오로 녹화되었으며, 영국의 국제 훈련자 집단으로부터 수퍼비전을 받아 연구진 내에서 공유되었다. 전체 촉진자 집단 대상의 월간 수퍼비전 모임이 진행되었으며 별도의 주간 모임에서의 수퍼비전도 병행되었다.

4. 병원기반 오픈 다이얼로그 운영

지역기반 오픈 다이얼로그 시험운영과 별도로, 이음병원의 입원 환자를 대상으로 병원기반 오픈 다이얼로그(네트워크 미팅) 운영이 병행되었다. 관련한 내용은 별도 지침에 기술되었다.

5. 시험운영 평가 및 연구[10]

워크숍과 일 년간의 시험운영 참가자들을 대상으로 시행한 연구(부록1)가 이루어졌다. 이 연구는 Frontiers in Psychology 저널이 마련한 '전 세계에서의 오픈 다이얼로그-적용, 성과, 경험 그리고 조망(Open Dialogue around the world-implementation, outcomes, experiences & perspectives)'이라는 주제의 특집에 게재되었다(Cho et al. 2024).

또한 WHO 퀄리티라이츠와 오픈 다이얼로그를 접목한 한국의 시험운영 모델은 2024년 세계 오픈 다이얼로그 국제 학술대회 기조 발표로 선정되어 호평을 얻었다('28TH IMDRAP' 2024).

이와는 별도로 시험운영에 참여한 가족지원가에 의해 실제 오픈 다이얼로그 서비스를 받은 가족들을 개별 인터뷰하는 방식의 조사(부록2)가 이루어졌다. 서비스 이용자의 입장에서 경험된 오픈 다이얼로그에 관한 이 조사 결과는 많은 종사자와 서비스 이용자에게 공유되었다(박 2023).

11 오픈 다이얼로그 국내 보급 및 확산 방안

이 파트에서는 한국의 정신건강 서비스에 오픈 다이얼로그를 도입하려 기획할 때에 우선적으로 고려되고 추진되어야 할 사항들에 대해 제안한다.

핀란드 서부 라플란드를 제외하면, OD의 7가지 원칙이 완전히 구현된 정신건강 시스템은 아직 존재하지 않는다(Buus et al. 2017). 핀란드 이외의 국가에서 기존의 정신건강 서비스에 오픈 다이얼로그를 도입하는 과정은 다양하지만, 특정 지역 또는 병원 단위의 정신건강서비스에서 자발적인 풀뿌리 운동 방식의 상향식(Bottom-up)도입으로 시작되었다는 것이 대체적인 공통점이다(Raffaella Pocobello 2023).

오픈 다이얼로그가 공공보건 서비스 안에서 시행되는 지역도 있고, 공공과는 분리된 민간 서비스로 이루어지는 사례들도 있어왔다. 많은 지역에서 아직 정신건강 서비스의 비주류로 시작되었으나, 인권/회복 기반 치료로서의 가치를 공유하는 전문가, 이용자 집단의 열정에 의해 빠른 속도로 확산되는 중이다. 최근에는 이러한 노력이 점차 공감대를 얻으면서 영국(Razzaque 2021)과 이탈리아(R. Pocobello and el Sehity 2017)처럼 지역정신건강 정책에 오픈 다이얼로그 도입을 포함시켜 교육훈련과 실천을 추진하는 하향식(top-down) 보급의 사례가 늘어나는 추세이다.

우리나라에서 오픈 다이얼로그를 성공적으로 도입하여 실천하기 위해서는 기존 정책과 연동하면서 부족한 부분을 보완하며, 정신건강서비스 현장의 종사자들이 받아들이기에 용이한 방식으로 보급되는 것이 바람직하다. 따라서 정교한 하향식 정책 마련과 상향식 동기부여가 동시에 진행되는 것이 효과적인 방식으로 보인다.

초기 도입을 위한 교육훈련, 시스템 및 제도개선에 대한 보다 상세한 고찰은 부록 1의 연구 논문에 상세히 기술되어 있다.

1) 오픈 다이얼로그 교육 훈련 도입

OD를 성공적으로 도입하려면 시스템 내에서 대규모 정식 교육이 필수적이다. 이를 위해 OD에 대한 사회적 인식 제고와 이해관계자 간의 합의를 증진하는 노력이 선행되어야 한다. 한편 OD를 처음 도입한 국가에서 이러한 새로운 협업 방식에 대해 조직적, 직업적, 개인적 저항이 발생하여 OD의 수용과 실행 과정에서 주요한 도전 과제가 될 수 있음이 드러난 바 있고(Weber and Johansen 2007) 한국(Cho et al. 2024)과 호주(Dawson et al. 2021)에서는 참가자들이 OD의 가치를 인정하면서도 그 수용을 주저하는 양가감정이 보고된 바 있으므로, 이러한 저항 내지 양가감정을 극복할 수 있는 전략이 필요하다.

가장 바람직한 방식은 오픈 다이얼로그 실행훈련의 기본인 기초훈련(foundation training)을 도입하는 것이다. 그러나 기초훈련을 곧바로 도입할 예산과 시간 등의 자원이 부족할 경우를 고려하여 단기간의 입문 워크숍(introductory workshop) 형태의 교육으로 개시하는 것도 현실적인 선택지가 될 수 있다.

더불어 이러한 단기 교육은 OD 실천에 국한되지 않고 기존 환경에서의 업무 방식과 팀워크에도 다방면으로 긍정적인 영향을 미치는 것으로 밝혀져 있다. 예를 들어, 호주에서 단기간의 OD 교육 이후의 시범 운영을 통해서도 참여자들이 기존과는 "다른" 학습 경험을 통해 치료적 접근에 대한 이해도와 교육 참가자 간 유대감이 강화되었다는 보고(Buus, Ong, and McCloughen 2023)와, 미국의 정신과 병동 치료진에게 단기 OD 교육 후 시범운영을 실시한 뒤 임상 효율성과 당사자-전문가 간 의사소통, 이용자 중심의 치료환경 조성에 효과가 있었다는 결과(Rosen and Stoklosa 2016a) 등이 그 근거가 될 수 있다.

한국에서의 시험운영에 관한 연구(Cho et al. 2024)에서도 짧지만 체계적으로 설계된 입문 워크숍이 OD에 익숙하지 않은 참여자들에게 큰 동기부여를 제공할 수 있음을 확인하였고, 교육 마련에서 고려되어야 할 두 가지 핵심 요소가 아래와 같이 제시되었다.

1. OD 원칙에 대한 이론적 설명보다는 경험적 학습을 우선적으로 고려

OD 원칙이나 이론의 단순한 전달보다는 경험적 학습, 삶의 방식으로서의 OD, 그리고 OD의 본질과 과정을 "몸으로 체득하는 것(bodily knowing of OD)"에 중점을 두는 것(Shotter 2007)이 바람직하다. 훈련 중의 실습과 역할극 과정에서 자신의 이야기를 경청 받고 응답 받는 경험을 통해 위기 당사자와 네트워크 구성원의 감정을 이해하는 통찰이 훈련의 중요한 동기가 되었다는 보고(Hendry, Corredor, and Roth 2021)는 이러한 경험적 요소의 중요성을 뒷받침한다.

한국에서의 시험 운영 참여자들도 소그룹 실습과 역할극 활동이 이러한 활동이 OD 워크숍에서 가장 만족스러운 부분으로 평가했으며 이 경험을 통해 "이론적으로 받아들이기 어려웠던OD의 중요성을 몸소 깨닫게 되었다"고 보고하였으므로(Cho et al. 2024) 향후 교육에서 이런 부분에 가장 주안점을 둘 필요가 있다.

2. 혼합 집단 구성

OD가 실천될 지역 내의 다양한 지역사회 정신건강 기관과 의료기관에 소속된 전문가, 동료 지원가, 가족들이 함께 참여하는 교육훈련이 효과적이다. 이러한 혼합 집단 구성은 WHO QualityRights 훈련 도구(World Health Organization 2019)의 권장 사항을 반영하는데, 한국 워크숍의 참여자들은 다양한 배경을 가진 이들의 다양한 대화를 통해 참여자들의 연대감과 희망, 동기부여가 강화되는 것을 일관되게 보고하였다. 서비스들이 구조적으로 분절 되어있는 한국의 상황에서 동일 지역 내 의료기관과 지역사회 정신건강센터 종사자들이 함께 모여 교류한 경험 자체가 큰 성과였으며, 다기관 협력을 통해, 당사자를 중심으로 서비스가 연동될 기대감이 드러났다(Cho et al. 2024). 오픈 다이얼로그를 통해 구축되는 새로운 연대는 전체 정신건강 서비스의 거버넌스를 강화하는 데에도 효과가 있을 것으로 보인다.

위의 두 가지 요소를 포함할 수 있기 위한 최소한의 입문 워크숍 기간은 3-4일 정도가 필요하다.

이러한 워크숍을 통해 오픈 다이얼로그에 대한 경험적 이해와 이후의 적용에 대한 동기부여를 도모할 수 있다.

본격적인 오픈 다이얼로그 서비스 제공을 위해 참여자들이 네트워크 미팅 수행 역량을 갖추기 위해서는 20일의 기초훈련 전체 커리큘럼을 제공하는 교육이 필수적이다. 기초훈련이 정착된 유럽과 미국에서는 총 20일을 5일 단위의 훈련 단위(Block)를 4회에 걸쳐 시행하거나 2-3일로 구성된 단위를 7-8회에 걸쳐 진행하는 방식으로 진행된다. 모든 경우 전체 훈련 기간은 1년 정도 소요된다.

오픈 다이얼로그 교육훈련은 그 자체로 대단히 밀도 있는 경험적 집단 학습이므로 교육자의 역량이 결정적으로 중요하다. 따라서 국제공인 자격을 갖춘 훈련자/지도자에 의해 이루어져야 하며, 실제 당사자와 가족에 대한 오픈 다이얼로그 과정에 대한 수퍼비전이 정기적으로 제공할 수 있도록 기획되는 것이 바람직하다.

2) 다른 인권기반 서비스와 오픈 다이얼로그의 상호보완성

세계보건기구(WHO)에 의한 높은 평가에 추가하여, 오픈 다이얼로그는 유럽평의회(Council of Europe)에서 정신건강 분야의 인권적 서비스의 모범 사례로 등재되었다(Gooding 2021). 실제로 OD의 핵심 원리들과 실행 요소들이 WHO 퀄리티라이츠(QualityRights)의 기반이 되는 장애인권리협약(CRPD)의 여러 조항들의 원칙과 일치한다고 제안되었으며(von Peter et al. 2019), 이런 특성은 훈련에서도 동일하게 경험된다는 것이 국내 시험운영을 통해 밝혀졌다(Cho et al. 2024). 시험운영 참여자들은 이러한 접근이 강압적 개입을 회피하고 위기 당사자의 존엄성과 선택권이 존중되는 정신건강 서비스로 경험되었다고 질적 연구결과에서 보고했다. 이러한 발견은 OD가 단순히 정신건강 문제를 해결하는 데 그치지 않고, 개인의 존엄성과 권리를 지지하는 관계와 지원 체계를 촉진할 잠재력을 가지고 있음을 보여준다(Cho et al. 2024).

이와 관련하여 한국에서의 오픈 다이얼로그 도입 모델의 가장 중요한 특징은, 오픈 다이얼로그가 단독으로 도입되는 것이 아니라 세계 보건기구(WHO)가 주도하는 인권/회복 지향 서비스 변혁 프로젝트인 퀄리티라이츠(QualityRights)의 여러 핵심 요소와 동시에 연동하도록 설계되었다는 점이다. 이처럼 잘 구성된 정신건강 서비스 체계에 오픈 다이얼로그를 탑재하여 보급하는 한국의 방식은 여러 면에서 장점을 가진다.

한국 정신건강 분야에서 인권은 실무자들에게 다소 불편한 주제로 간주되기도 하는데(Kang et al. 2016), 이는 인권에 대한 교육이 실제 임상 결과를 변화시킬 수 없다는 회의론과 관련된다. WHO 퀄리티라이츠(QualityRights) 역시 정신건강 분야 일부로부터의 논란에 직면해 있으며(Hoare and Duffy 2021), 그 이유는 주목할만한 성과(Pathare et al. 2021)에도 불구하고 관습적 치료의 대안으로서 인권 기반 치료의 효과를 실제로 경험한 이들이 적기 때문일 수 있다. 한국의 시험 운영 과정에서 심각한 정신건강 위기 상황에서도 OD를 강제 입원이나 기계적 강박을 피할 수 있었던 사례들이 부각된 것은, 오픈 다이얼로그 접근이 현실 안에서 인권에 부합하는 치료 경과가 도출되는 데에 기여할 수 있는 잠재력이 확인되었다는 면에서 의미심장하다(Cho et al. 2024).

또한 오픈 다이얼로그 방법론은 WHO가 만든 퀄리티라이츠 교육 도구를 개선할 수 있는 잠재력을 가진다. 퀄리티라이츠 훈련도구는 다양한 배경을 가진 참가자가 포함된 혼합 그룹 장려, 모든 구성원의 참여와 상호작용 보장, 누구도 배제되거나 안전하지 않다고 느끼지 않도록 보장, 개방적이고 편견 없는 환경, 모든 당사자가 이해하기 쉬운 언어 사용 등 OD와 매우 유사한 주요 그룹 교육 지침을 제공한다(World Health Organization 2019). 한편 이 도구는 여러 의제와 참고 자료로 구성되어 있어 참여자들이 때때로 어려워하거나 따라가기 힘들어하는 경우가 있었는데, 회기의 진행 속도를 늦추고 모든 의견을 듣고 경청할 수 있도록 하는 등의 대화적 요소를 적용하여 더 효과적으로 진행될 수 있었다.

위의 결과를 바탕으로, OD가 WHO 퀄리티라이츠 교육이 슬로건과 가치 공유를 공유하는 단계에서 보다 구체화된 경험적 학습으로 나아가는 데 도움이 되는 잠재력이 존재한다고 가정할 수 있다. 이러한 부분은 본 연구개발의 다른 결과물인 '회복/퇴원 계획 수립 종사자 훈련도구'에 반영되었다.

달리 말하자면, 오픈 다이얼로그에 내재된 경험적 학습이 WHO 퀄리티라이츠의 개념을 더 수용적으로 만들거나 반대로 WHO 퀄리티라이츠의 명시적인 내용이 OD의 보다 실용적인 개념화에 기여할 수 있는 쌍방향의 장점이 존재한다. 그러므로 오픈 다이얼로그는 비강압치료, 회복 프로그램, 동료지원 및 지원의사결정(절차조력) 등 WHO가 제안하는 인권/회복 기반 서비스와 서로 연동할 때에 상호 보완적인 시너지를 낼 수 있으므로, 서비스 개선 과정에서 여러 도구를 동시에 적용할 것을 권장한다.

기존 정신건강 서비스 시스템에의 오픈 다이얼로그 적용

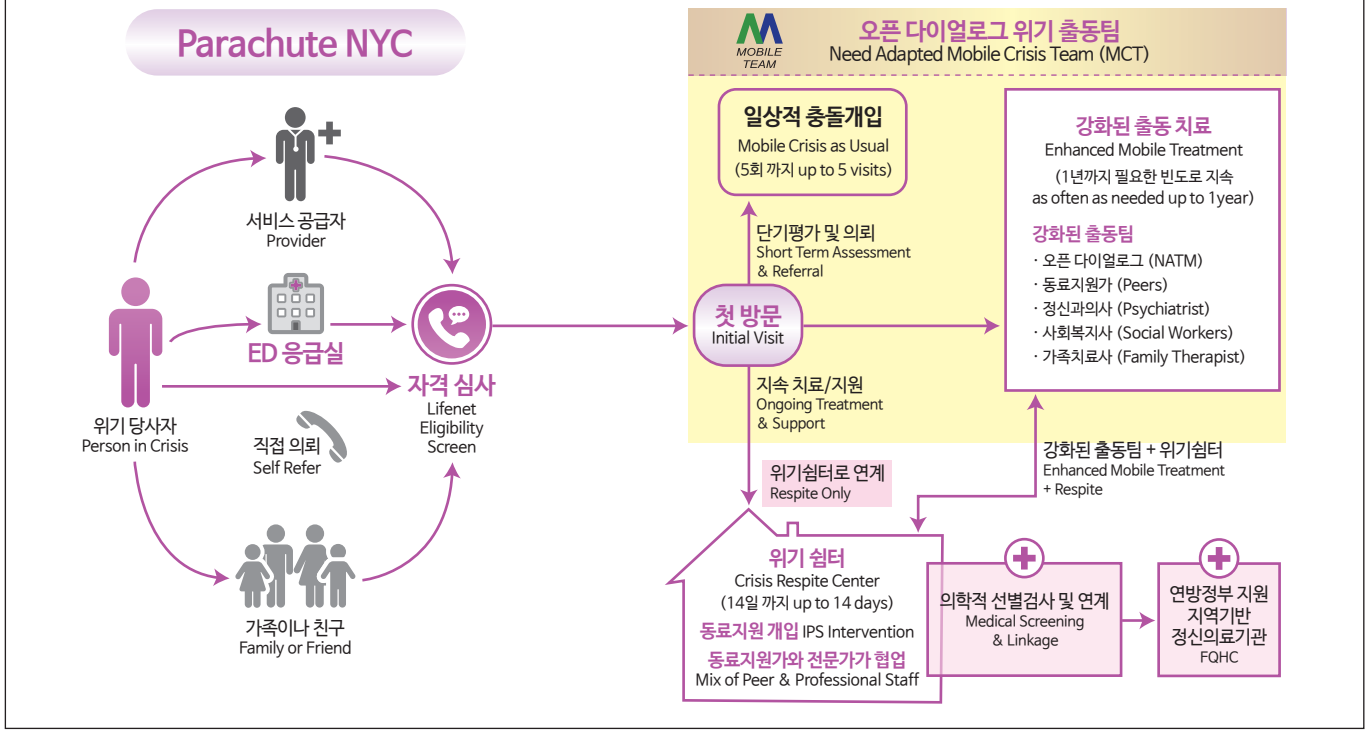
한국의 정신건강서비스 시스템에 오픈 다이얼로그를 본격 도입하기 위해서는 한국 환경에 맞는 정교한 설계가 필요하다. 그러므로 해외에서 기존 정신건강서비스에 오픈 다이얼로그를 도입한 사례들을 참고할 필요가 있다.

1. 뉴욕 파라슈트(Parachute) 프로젝트

오픈 다이얼로그가 한 지역의 정신건강 위기대응의 핵심으로 도입된 사례로서 미국 뉴욕의 파라슈트(Parachute) 프로젝트가 있다(Sadler 2016). 이 프로젝트는 2012년부터 2014년까지 시행된 모델로서 정신건강전문가와 동료지원가가 한 팀으로 구성된 출동 팀이 위기 당사자가 있는 가정, 위기쉼터, 의료기관을 방문하여 오픈 다이얼로그를 시행하는 방식으로 운영되었다.

위기대응 시스템 적용 사례 : 뉴욕 낙하산(Parachute Project) 프로젝트 (Sadler, 2016)

- 오픈 다이얼로그+동료지원+위기쉼터 : 2012-2014.
  1760만 달러(2000억원) 투입
- 자택, 급성기병동, 응급실, 위기쉼터 등으로 출동



2. 영국 오데시(ODDESSI) 시험운영

'오데시(ODDESSI)'는 '오픈 다이얼로그 - 중증 정신질환을 위한 사회적 네트워크 개입의 개발과 평가(Open Dialogue - Development and Evaluation of a Social Network Intervention for Severe Mental Illness)'의 약자다. 오데시는 영국의 여러 지역이 참여하는 국가 수준의 무작위대조군 시험(Random control trial)과 질적분석으로 이루어진 대규모 연구로서 영국 국립 건강 연구소(NIHR)로부터 240만 파운드를 지원받았다. 영국 국가보건서비스(NHS) 트러스트 여섯 곳에서 300명이 넘는 종사자와 상당수의 동료지원가들이 오픈 다이얼로그 기초훈련을 수료하고 600명이 넘는 대상자에 대해 서비스를 제공했다. 이 대규모 연구의 결과는 2025년중에 발표될 예정이다.

위에 예시로 든 미국과 영국의 사례 모두, 특정 지역의 의료 서비스와 지역사회 서비스가 동시에 연동하도록 구성하며 정신건강전문가와 동료지원가가 한 팀으로 오픈 다이얼로그를 실천할 수 있도록 충실한 교육훈련을 도입했다. 그리고 본 지침서의 초반에 언급한 좁은 의미의 오픈 다이얼로그 네트워크 미팅이 가능한 팀워크 유지를 위한 수퍼비전을 시도하고, 동시에 넓은 의미의 오픈 다이얼로그로서 여러 차원의 서비스가 연동하도록 디자인했다는 공통점을 가진다. 한국에서의 오픈 다이얼로그 본격 적용을 위해서도 같은 원칙이 적용될 필요가 있다.

오픈 다이얼로그를 위한 환경 조성

오픈 다이얼로그는 정신건강 시스템의 조직 및 작동 원리이기도 하므로, 무엇보다 당사자 중심으로 서비스가 배치되고 제공자 간의 협업이 고취될 수 있는 환경 조성이 중요하다. 그러므로 어떻게 서비스의 기반 구조가 갖추어져야 하는 가에 대한 몇 가지 조건이 아래와 같이 제시되어 있는데, 이는 초기 환경 조성의 유용한 가이드가 될 수 있다.

오픈 다이얼로그를 지지하기 위한 기반 구조를 평가하는 몇 가지 기준들(Olson 2021)

① 네트워크 접근법을 우선시하기

② 존중, 진정성, 협업을 구현하는 리더십

③ 오픈 다이얼로그 팀의 작업에 대한 보상

④ 오픈 다이얼로그를 잘 훈련받은 직원들

⑤ 서비스를 요청하는 사람들을 환영하고 배려하는 따뜻한 분위기

⑥ 임상적 서비스와 지역사회 서비스를 제공하고 연결할 역량

⑦ 위기 팀에서의 불확실성에 대한 용인과 대화의 역할에 대한 기관 차원의 지지

⑧ 즉각적인 도움 제공과 필요 맞춤형 서비스를 받게 해줄 역량

⑨ 네트워크 모임에서의 협력적인 공동 의사 결정(약물치료, 입원, 치료 계획 등)

오픈 다이얼로그가 실천되기 위한 기반 구조는 위와 같은 다양한 차원의 조직 문화와 역량을 필요로 한다. 그 육성을 위해서는 리더십과 사업 지침, 개별 종사자들의 팀워크와 역량 강화 등 여러 레벨에서의 변화가 요구되는데, 초기 단계부터 이러한 측면들이 동시에 충분히 고려되는 것이 바람직하다. 이러한 환경을 갖추기 위해 효과적인 방안은 정신보건 서비스 전체의 지향점을 공동체와 관계 중심으로 설정하는 것이다. 이렇듯 지역 정신보건서비스 내지 정신의료의 지향점을 수정한 사례로 최근 영국 런던 지역의 국가보건서비스(NHS)를 들 수 있다.

영국의 경우 최근 전국적 정신의학 학술단체인 왕립정신의학회(Royal college of psychiatrists)에서 '자애롭고 대인관계적인 정신의학(Compassionate & Relational Psychiatry)' 이라는 새로운 분야의 리더를 임명하여 공동체 내의 관계망 및 사회적 자원 복원을 도모하려는 시도를 하고 있으며(Razzaque and Mckenzie 2024), 그와 관련하여 런던의 North East London NHS Foundation Trust (NELFT)에서는 '관계 기반 돌봄 센터(Relational care faculty)'를 설립하여 지역사회 정신건강 서비스 전체를 이러한 목적 하에 운영되도록 교육하고 조력하는 작업을 시작하였다(NELFT NHS Foundation, n.d.). 이 조직을 통하여 오픈 다이얼로그적인 방식으로 치료적 관계를 구축하고 이용자를 중심에 놓은 돌봄을 제공하며 치료진의 어려움을 지지하는 서비스 문화를 도모한다.

오픈 다이얼로그의 다양한 적용 방식

오픈 다이얼로그 도입의 최종 목표는 7대 핵심 원리가 모두 구현될 수 있는 시스템 구축으로 설정되는 것이 이상적이다. 그러나 OD를 기존의 치료 환경에 통합하려 할 때는 가치의 차이로 인한 어려움이 있을 수 있으며(Ong et al. 2019), 주류적 정신의학적 모델이 이러한 전인적 접근의 적용에 장애가 될 수 있다는 등의 의견(Sch tze 2015)이 존재해 왔다. 이는 한국의 기존 정신건강 서비스 문화와 시스템에 7대 원리 전체를 곧바로 적용하는 것은 현실적 어려움이 따른다는 시험운영 결과와 일관된다(Cho et al. 2024).

그래서 OD가 처음 도입될 때는 해당 조직의 특성과 상황에 맞게 조정된 형태로 시도될 필요가 있으며(Heumann et al. 2023), 핵심 원리 중 일부 요소만 도입하더라도 충분히 가치 있는 시도가 될 수 있다고 제안되었다(Sch tze 2021). 실제로 많은 국가에서 오픈 다이얼로그의 일부 원리를 적용한 변형된 형태의 적용을 시도하고 있다. 이러한 방식은 최근 '오픈 다이얼로그 응용 서비스(Open Dialogue inspired/informed service)'로 정의된다(Cotes et al. 2023; Twamley, Dempsey, and Keane 2021).

한국에서의 오픈 다이얼로그 도입 과정에서 이렇듯 변형된 방식의 적용들이 시도되었으며, 그 중 유용한 몇 가지 방법을 아래에 소개한다.

1. 병원기반 필요맞춤 치료

오픈 다이얼로그는 기본적으로 지역사회 기반 서비스이지만, 정신과 입원 병동에서도 의미 있게 적용될 수 있다. 미국 하버드 의대 맥린(Mclean)병원과 노르웨이의 아케르스후스 대학병원(Akershus University Hospital)은 OD 교육 후 변형된 형태로 입원 치료에 적용했을 때 다양한 긍정적인 효과가 있었다는 연구를 보고했다(Rosen and Stoklosa 2016b; Ritva et al. 2018). 또한 세계보건기구의 모범사례로 등재된 독일 하이든하임(Heidenheim) 병원에서도 오픈 다이얼로그 방문 팀을 운영하는 등의 방식으로 적극 적용하고 있다(WHO 2021a).

오픈 다이얼로그의 원형인 '필요 맞춤치료(Need adapted treatment)'가 애초에 입원병동 에서 비롯된 만큼(Alanen 1997), 정신과 병동에 다학제 종사자들의 협업 문화가 조성되어 있다면 충분히 효과적인 적용이 가능하다. 특히 급성기의 첫 치료가 정신과 병동 입원으로 시작되는 사례가 많은 한국에서는 특히 필요한 방식이라고 할 수 있다. 본 연구개발 사업의 공동연구기관인 이음병원에서 이러한 병원기반 오픈 다이얼로그를 개발 및 적용해 왔으며 그 내용은 별도 지침서에서 상세히 소개된다.

2. 비급성기의 대화적 집단 상담(Dialogical group practice)

오픈 다이얼로그의 첫 번째 핵심 원리인 '즉각적 도움(immediate help)'는 급성 정신증 위기 대응이로 기능하기 위한 필수 요소이지만, 현실 정신건강 서비스에서 가장 적용하기 어려운 조건이기도 하다. 여러 국가에서는 오픈 다이얼로그를 위기개입 시점 이후의 심리사회적 개입에 적용을 시도하고 있다.

그 예로 영국의 'Dialogue first(NELFT NHS Foundation, n.d.)', 미국 버몬트의 'Collaborative pathway(Gordon et al. 2016)' 등의 서비스는 아급성기(subacute) 이후 단계의 대상자에게 오픈 다이얼로그의 실행 요소를 적용한 네트워크 미팅을 제공하는데, 통합적이고 전인적인 대화적 접근을 장기간 제공하는 성공 사례로 평가받고 있다. 또한 스위스 인터라켄(Interlaken) 지역 정신건강 서비스는 '적극적 지역사회 치료(Assertive Community Treatment ;ACT)'에 오픈 다이얼로그를 적용하는 시도를 하고 있다. 다학제 방문 사례관리팀이 OD 수련을 받아 대상자 가족과 함께 협업하는 방식은 기존의 정신사회 재활 모델에 오픈 다이얼로그가 성공적으로 결합한 모델이라고 할 수 있다.

우리나라에서도 이번 연구개발의 일환으로 수원시 행복정신건강복지센터와 성인정신건강복지센터의 의뢰로 이루어진 실제 개입의 일부가 아급성기 이후의 사례였고 대체적으로 양호한 경과를 보였다. 이러한 방식은 아직 급성기 위기 단계 오픈 다이얼로그 운영이 어려운 국내 환경에서 유용한 도입 방식이 될 수 있다.

3. 돌봄 조직에 대한 대화적 성찰작업

오픈 다이얼로그는 심리사회적 위기 당사자/가족에 대한 임상적 조력을 넘어, 정신건강 서비스 조직 구성원들의 역량 및 팀워크 강화에도 적용될 수 있다. 정신건강서비스 현장의 종사자들은 그 특성상 정서적 어려움과 소진을 겪을 가능성이 높다고 알려져 있다. 그들의 일은 정신건강 위기를 겪는 이들의 강렬한 정서를 현장에서 맞닥뜨리고 감당하는 고난이도의 감정 노동이기 때문이다.

그래서 치료공동체의 실천가 케나드(Kennard)는 "정신 질환을 다루는 조직의 치료진이 된다는 것은 세상에서 가장 정서적으로 감당하기 어려운 도전에 맞닥뜨리는 일이다" 라고 언급했고(Kennard 1998), 정신증에 대한 심리사회적 접근을 다룬 정신분석가 힌셀우드(Hinshelwood) 역시 "정신보건서비스 현장에서의 과업은 그 자체로 치료진으로 하여금 결국 낙담하거나 소진되게 만들 위험성을 내포하는 어려운 일이다" 라고 평하며 정신건강 종사자들이 지지받을 수 있는 조직 문화의 필요성을 강조했다(Hinshelwood 2004).

이러한 필요로 인해, 영국을 비롯한 유럽 여러 국가에서는 정신건강 돌봄 조직에서 직원들의 역량 강화와 소진 방지를 위한 일종의 수퍼비전으로서 이른바 '성찰적 작업(Reflective practice)"이라는 조직내 모임을 정기적으로 가질 것을 권장하고 있다(Eyres 2021; Webber and Nathan 2010).

나아가 최근 들어 핀란드에서는 조직 구성원들의 팀워크와 역량 강화 프로그램에 오픈 다이얼로그의 기법을 적용한 이른바 "대화적 수퍼비전(Dialogical supervision)"이 시도되고 있는데(Alhanen et al. 2020), 국내의 오픈 다이얼로그 보급 과정에서도 지역 정신건강 돌봄 조직을 위해 이러한 프로그램이 시도되었다. 구체적으로 아주대학병원 정신과, 수원시 성인정신건강복지센터, 수원시 행복정신건강복지센터, 화성시 아동청소년정신건강복지센터 종사자 워크숍 형태의 대화적 성찰작업이 이루어졌는데, 오픈 다이얼로그의 반영과 소집단 활동 등을 응용한 4-6시간의 공동 작업을 통해 정신건강서비스 업무의 의미 부여와 동기부여의 성과가 드러났다.

이러한 방식의 적용은 조직 문화 향상을 넘어서서 종사자들이 오픈 다이얼로그에 대해 체험적 과정을 통해 이해하고 동기부여되게 해 준다는 면에서, OD가 새롭게 소개되는 기관에 처음으로 시도될 수 있는 유용한 수단이 될 수 있다.

4. 동료지원 조직의 대화적 인터비전(Intervision)

영국의 오픈 다이얼로그에서는 동료지원가의 참여가 중요한 요소이다(Kinane et al. 2022). 또한 동료지원과 오픈 다이얼로그는 쌍방향으로 기여할 수 있다. 즉 동료지원가가 오픈 다이얼로그 촉진자 팀의 일원으로서 기여할 수 있고, 동료지원가 조직의 팀워크와 지지를 위해 오픈 다이얼로그 적인 방법론이 도움될 수 있다.

후자의 경우는 동료지원가들이 필요한 조력에 관한 것이다. 동료지원가 역시 상호 도움과 반영을 주고받을 수 있는 시간, 그리고 동료들의 개인사와 어려움에 대해 탐색할 수 있는 안전한 공간이 필요하며, 자기 자신과 타인의 회복에 대한 열정을 유지하며 자신의 신념을 지키고 권리를 행사할 수 있기 위한 지지가 필요하다(Razzaque 2023). 이 경우 역시 대화적 접근이 대단히 유용하다.

국내에서는 동료지원 서비스를 제공하는 세 곳의 조직(정신장애와 인권 파도손, 아름다운 세상, 브솔시냇가) 구성원에 대한 오픈 다이얼로그 교육과 수퍼비전이 진행되었다. 반영팀 활용, 피시볼(fishbowl) 기법 등의 다양한 방식을 통해 동료지원가들은 업무 과정에서의 고충에 대한 대화를 나누고 서로 조력하게 된다.

동료지원가들이 실행하는 오픈 다이얼로그는 사람과 사람이 상대방을 경청하여 이해하고, 진심 어린 대화를 통해 도우려 하는 선의와 고통에 기반한 돌봄의 원형을 보여준다는 면에서 각별히 감동적인 작업이다. 향후 국내에 동료지원 서비스가 발전해가는 과정에서 동료지원가을 위한 역량/팀워크 강화 프로그램으로 대화적 접근은 큰 위력을 가질 수 있다.

5. 대화 기반의 다가족/가족간 치료(multi/inter-family therapy)

여러 가족이 함께하는 대집단 프로그램에서 오픈 다이얼로그를 적용하는 이 시도는 스페인의 '가족간 치료(interfamily therapy;IFT)에서 처음 시도되었다(Sempere and Fuenzalida 2021). 단일 가족을 위한 OD 네트워크 모임과 마찬가지로, 다가족 모임도 미리 정한 의제 없이 진행된다. 주요 목적은 대화를 발생시켜 경험들이 공유될 수 있게 하는 것, 그리고 연대의 공간 안에서 감정들이 표출될 수 있게 하는 것이다. 촉진자들의 역할은 가족들이 서로 연결되도록 돕는 것인데, 대화적 실행의 주요 원리들에 따라 집단 내부의 세 층(참가가 각각의 내면, 한 가족 구성원 사이, 다른 가족 사이)에서 왕성한 폴리포니가 생성된다.

한국 보급 과정에서 수원시 정신건강 가족 학교에 참석한 여러 정신장애인 가족들이 모인 대집단 세팅에서 처음 시도되었으며, 평소 친분이 없던 여러 가족들이 모인 대집단에서도 상당히 밀도 있는 공감과 지지가 이루어질 수 있음이 확인되었고 참석자들의 만족도가 높았다. 한국에서는 스페인의 방식에 새로운 기법이 더 추가되어 시도되었으며, 앞으로 지역정신건강 서비스의 중요한 한 축인 가족교육 프로그램을 획기적으로 발전시킬 수 있는 잠재력을 지닌다.

국내의 오픈 다이얼로그 교육훈련 자원

현재 국내에서 공식적인 오픈 다이얼로그 실천이 시행된 사례는 본 연구개발이 유일하다. 이 사업의 지역기반 오픈 다이얼로그 및 병원기반 필요맞춤치료 시험운영에 참여한 연구진, 정신건강전문가, 동료지원가, 가족 지원가들은 지속적인 오픈 다이얼로그 국내 보급을 위해 '한국 오픈 다이얼로그 학회(Korean Open Dialogue Society)'를 조직하였다.

이 학회는 오픈 다이얼로그를 국내 정신건강 서비스에 공식 도입하기 위해, 국제적 합의에 부합하는 수준의 교육과 실천을 지향한다. 그에 따라 국제공인 훈련자/지도자가 주도하여 아래 주제의 임상/학술활동, 교육훈련, 수퍼비전 및 자문을 활발하게 진행해오고 있다.

1. 오픈 다이얼로그(Open Dialogue)

2. 병원형 필요맞춤치료(Need Adapted Treatment)

3. 돌봄 조직의 팀워크/역량 강화를 위한 대화적 성찰작업(Dialogical reflective practice)

4. 대화 기반의 다가족/가족간 치료(multi/inter-family therapy)

5. 오픈 다이얼로그의 인문학

- 한국 오픈 다이얼로그 학회 : https://blog.naver.com/opendialoguekorea
- 네이버 블로그 : 한국 오픈 다이얼로그 학회

12 감사의 말씀

이 연구 프로젝트에 참여해 주신 모든 산 경험을 가진 당사자, 가족, 그리고 다양한 전문 영역의 실천가 및 공직자 여러분께 깊이 감사드립니다.

또한 이 지침서의 많은 부분은 닉 푸트맨(Nick Putman)과 브라이언 마틴데일(Brian Martindale)의 『정신증을 위한 오픈 다이얼로그 - 대화, 관계, 의미를 우선시하는 정신건강서비스 조직화』와 러셀 라자크(Russell Razzaque)의 『대화정신의학』으로부터 발췌·번안한 내용에 기반하고 있음을 알려드립니다.

그리고 영국 오픈다이얼로그 협회(Open Dialogue UK)의 국제 훈련자/지도자 양성과정 교수진, 핀란드를 비롯한 전 세계의 실천가들, 일본 오픈다이얼로그협회(Open Dialogue Japan), 그리고 세계보건기구(WHO) 본부의 미셸 펑크(Michelle Funk)와 나탈리 드류(Nathalie Drew)의 지속적인 지원과 협력에도 깊은 감사를 드립니다.

13 참고 문헌

'28TH IMDRAP'. 2024. 28TH INTERNATIONAL MEETING ON DIALOGICAL AND REFLECTIVE APPROACHES TO PSYCHOSIS AND OTHER CHALLENGING MENTAL STATES (IMDRAP) 28.08.2024-01.09.2024 LONDON. 2024. https://imdrap.weebly.com/.

Aaltonen, Jukka, Jaakko Seikkula, and Klaus Lehtinen. 2011. 'The Comprehensive Open-Dialogue Approach in Western Lapland: I. The Incidence of Non-Affective Psychosis and Prodromal States'. Psychosis 3 (3): 179 - 91. https://doi.org/10.1080/17522439.2011.601750.

Alanen, Yrjo O. 1997. SCHIZOPHRENIA: Its Origins and Need-Adapted Treatment. KARNAC BOOKS.

Alhanen, Kai, Anne Kansanaho, Olli-Pekka Ahtiainen, Marko Kangas, Katriina Lehti, Tiina Soini, and Jarkko Soininen. 2020. Dialogical Supervision: Creating A Work Culture Where Everybody Learns. BoD - Books on Demand.

Borg, Marit, Bengt Karlsson, Hesook Suzie Kim, and Brendan McCormack. 2012. 'Opening up for Many Voices in Knowledge Construction'. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 13 (1). https://doi.org/10.17169/fqs-13.1.1793.

Buus, Niels, Ben Ong, and Andrea McCloughen. 2023. 'Open Dialogue Trainees' Perspectives on Learning Processes and Psychotherapeutic Practice: A Prospective Focus Group Study'. Family Process 62 (3): 993 - 1005. https://doi.org/10.1111/famp.12832.

Cho, Sooni, Yong Hyuk Cho, Jai Sung Noh, Seong Kwon Jeong, Shin Kwon Kim, and Seongsu Kim. 2024. 'Introducing Open Dialogue as Part of the WHO QualityRights Project in South Korea: Experiences and Opinions from an Introductory Workshop and 1-Year Pilot Practice'. Frontiers in Psychology 15 (October). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1426122.

Cotes, Robert O., Justin M. Palanci, Beth Broussard, Stephanie Johnson, M. Alejandra Grullón, Grayson S. Norquist, C. Christina Mehta, et al. 2023. 'Feasibility of an Open Dialogue-Inspired Approach for Young Adults with Psychosis in a Public Hospital System'. Community Mental Health Journal 59 (7): 1428 - 35. https://doi.org/10.1007/s10597-023-01120-2.

Eyres, Maria. 2021. 'Reflective Practice and Its Central Place in Mental Health Care'. In Seminars in the Psychotherapies, 298. Cambridge University Press.

https://books.google.com/books?hl=ko&lr=&id=QTorEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA298&dq=Reflective+Practice+and+Its+Central+Place+in+Mental+Health+Care&ots=BFPLL7lWLI&sig=yCyWLvx7q_SX-qQX15hVXEsHDT8.

Fortuna, Karen L., Phyllis Solomon, and Jennifer Rivera. 2022. 'An Update of Peer Support/Peer Provided Services Underlying Processes, Benefits, and Critical Ingredients'. Psychiatric Quarterly 93 (2): 571 - 86. https://doi.org/10.1007/s11126-022-09971-w.

Funk, Michelle, and Natalie Drew Bold. 2020. 'WHO's QualityRights Initiative'. Health and Human Rights 22 (1): 69 - 75.

Gooding, P. 2021. 'Compendium Report: Good Practices in the Council of Europe to Promote Voluntary Measures in Mental Health: Report Commissioned by the Committee on Bioethics (DH-BIO) of the Council of Europe'. Council of Europe.

Gordon, Christopher, Vasudha Gidugu, E. Sally Rogers, John DeRonck, and Douglas Ziedonis. 2016. 'Adapting Open Dialogue for Early-Onset Psychosis Into the U.S. Health Care Environment: A Feasibility Study'. Psychiatric Services 67 (11): 1166 - 68. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201600271.

Heumann, Kolja, Mira Kuhlmann, Maike Böning, Helene Tülsner, Raffaella Pocobello, Yuriy Ignatyev, Volkmar Aderhold, and Sebastian von Peter. 2023. 'Implementation of Open Dialogue in Germany: Efforts, Challenges, and Obstacles'. Frontiers in Psychology 13 (February). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1072719.

Hinshelwood, R.D. 2004. Suffering Insanity: Psychoanalytic Essays on Psychosis. Brunner-Routledge.

Hoare, Fiona, and Richard M. Duffy. 2021. 'The World Health Organization's QualityRights Materials for Training, Guidance and Transformation: Preventing Coercion but Marginalising Psychiatry'. The British Journal of Psychiatry 218 (5): 240 - 42. https://doi.org/10.1192/bjp.2021.20.

Hopper, Kim, Jennifer Van Tiem, Lauren Cubellis, and Leah Pope. 2020. ' Merging Intentional Peer Support and Dialogic Practice: Implementation Lessons From Parachute NYC'. Psychiatric Services 71 (2): 199 - 201. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201900174.

Kang, Yu Ree, Joon-Ho Ahn, Yeonho Joo, and Chang Yoon Kim. 2016. ' Current Human Rights Education for Psychiatrists Leaves Much to Be Desired'. Journal of Korean Neuropsychiatric Association 55 (4): 289. https://doi.org/10.4306/jknpa.2016.55.4.289.

Kennard, David. 1998. An Introduction to Therapeutic Communities. J. Kingsley Publishers.

Kim, Sung-Wan. 2018. 'Psychosocial Intervention for Patients with Schizophrenia'. Journal of Korean Neuropsychiatric Association 57 (3): 235. https://doi.org/10.4306/jknpa.2018.57.3.235.

Kinane, Catherine, James Osborne, Yasmin Ishaq, Marcus Colman, and Douglas MacInnes. 2022. 'Peer Supported Open Dialogue in the National Health Service: Implementing and Evaluating a New Approach to Mental Health Care'. BMC Psychiatry 22 (1): 138. https://doi.org/10.1186/s12888-022-03731-7.

Lorenz-Artz, Karin, Joyce Bierbooms, and Inge Bongers. 2023. 'Introducing Peer-Supported Open Dialogue in Changing Mental Health Care'. Frontiers in Psychology 13 (January). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1056071.

Mosse, David, Darren Baker, Molly Carroll, Liana Chase, Ruth Kloocke, Kiara Wickremasinghe, Bethan Cramer, Keira Pratt-Boyden, and Milena Wuerth. 2023. 'The Contribution of Anthropology to the Study of Open Dialogue: Ethnographic Research

13 참고 문헌

Methods and Opportunities'. Frontiers in Psychology 14 (May). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1111588.

NELFT NHS Foundation. n.d. 'Dialogue First Service'. NELFT NHS Foundation Trust. Accessed 4 February 2025. https://ww-w.nelft.nhs.uk/aboutus-initiatives-dialoguefirst.

Olson, Mary. 2021. 'Open Dialogue Adherence and Fidelity Tools'. In Open Dialogue for Psychosis. Routledge.

Olson, Mary, Jaakko Seikkula, and Douglas Ziedonis. 2014. 'THE KEY ELEMENTS OF DIALOGIC PRACTICE IN OPEN DIALOGUE: FIDELITY CRITERIA'.

Ong, Ben, Rachel Barbara-May, Judith M Brown, Lisa Dawson, Carl Gray, Andrea McCloughen, Kristof Mikes-Liu, et al. 2019. 'Open Dialogue: Frequently Asked Questions'. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 40 (4): 416 - 28. https://doi.org/10.1002/anzf.1387.

Park, Jong Eon. 2021. '[Press conference] Human rights treatment stranded..."We support human rights-friendly treatment at the new Gyeonggi Provincial Psychiatric Hospital"'. 15 March 2021. http://www.-mindpost.or.kr/news/articleView.html?idxno=5176.

Pathare, Soumitra, Michelle Funk, Natalie Drew Bold, Ajay Chauhan, Jasmine Kalha, Sadhvi Krishnamoorthy, Jaime C. Sapag, et al. 2021. ' Systematic Evaluation of the QualityRights Programme in Public Mental Health Facilities in Gujarat, India'. The British Journal of Psychiatry 218 (4): 196 - 203. https://doi.org/10.1192/bjp.2019.138.

Peter, Sebastian von, Volkmar Aderhold, Lauren Cubellis, Tomi Bergstr□m, Peter Stastny, Jaakko Seikkula, and Dainius Puras. 2019. ' Open Dialogue as a Human Rights-Aligned Approach'. Frontiers in Psychiatry 10. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fp-syt.2019.00387.

Pocobello, R., and T. el Sehity. 2017. 'Evaluation of Open Dialogue in the Context of the Italian Mental Health Services'. Technical Report for the Italian Ministry of Health, ISTC-CNR, Rome.

Pocobello, Raffaella. 2023. 'Open Dialogue Services around the World: A Scoping Survey Exploring Organizational Characteristics in the Implementation of the Open Dialogue Approach in Mental Health Services', Frontiers in Psychology, , November.

Putman, Nick, and Brian Martindale. 2021. Open Dialogue for Psychosis: Organising Mental Health Services to Prioritise Dialogue, Relationship and Meaning. Routledge.

Rawlins, Michael. 2008. 'De Testimonio: On the Evidence for Decisions about the Use of Therapeutic Interventions'. The Lancet 372 (9656): 2152 - 61. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61930-3.

Razzaque, Russell. 2019. Dialogical Psychiatry: A Handbook For The Teaching And Practice Of Open Dialogue. Omni House Books.

———. 2021. 'The UK ODDESSI Trial'. In Open Dialogue for Psychosis. Routledge.

———. 2023. 'BRINGING LIVED EXPERIENCE INTO THE NHS Aspiring to Make a Difference'. Presentation.

Repper, Julie, and Tim Carter. 2011. 'A Review of the Literature on Peer Support in Mental Health Services'. Journal of Mental Health 20 (4): 392 - 411. https://doi.org/10.3109/09638237.2011.583947.

Ritva, Jacobsen, Jorunn S ø rgård, Bengt Eirik Karlsson, Jaakko Seikkula, and Hesook Suzie Kim. 2018. '"Open Dialogue behind Locked Doors" - Exploring the Experiences of Patients ,Family Members, and Professionals With Network Meeetings in a Locked Psychiatric Hospital Unit: A Qualita-tive Study', August. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.5.e5.

Rosen, Kayla, and Joseph Stoklosa. 2016. 'Finland in Boston? Applying Open Dialogue Ideals on a Psychotic Disorders Inpatient Teaching Unit'. Psychiatric Services 67 (12): 1283 - 85. https://doi.org/10.1176/ap-pi.ps.201600340.

Sadler, Pablo. 2016. 'Peer Participation and Recovery from Severe Mental Illness in Parachute NYC'. Presentation presented at the 15th International Conference for Mental Health & Rehabilitation.

Sch□tze, Werner. 2015. 'Open Dialogue as a Contribution to a Healthy Society: Possibilities and Limitations'. Postępy Psychiatrii i Neurologii 24 (2): 86 - 90. https://doi.org/10.1016/j.pin.2015.05.002.

———. 2021. 'The Challenge of Developing Open Dialogue in Hospital Settings'. In Open Dialogue for Psychosis. Routledge.

Seikkula, Jaakko. 2021. 'Psychosis Is Not an Illness but a Response to Extreme Stress - Dialogue Is a Cure for It'. In Open Dialogue for Psychosis. Routledge.

Seikkula, Jaakko, Birgitta Alakare, Jukka Aaltonen, Juha Holma, Anu Rasinkangas, and Ville Lehtinen. 2003. 'Open Dialogue Approach: Treatment Principles and Preliminary Results of a Two-Year Follow-up on First Episode Schizophrenia'. Ethical Human Sciences and Services 5 (3): 163 - 82.

Seikkula, Jaakko, and Tom Erik Arnkil. 2013. 'Open Dialogues and Anticipations - Respecting Otherness in the Present Moment'. THL. 2013. https://www.julkari.fi/handle/10024/114692.

Sempere, Javier, and Claudio Fuenzalida. 2021. 'Interfamily Therapy: Application of Dialogical Practices in the Multifamily Group'. In Open Dialogue for Psychosis. Routledge.

Shotter, John. 2007. 'Not to Forget Tom Andersen's Way of Being Tom Andersen: The Importance of What "Just Happens" to Us', 2007.

Twamley, Iseult, Maria Dempsey, and Nicola Keane. 2021. 'An Open Dialogue-Informed Approach to Mental Health Service Delivery: Experi-ences of Service Users and Support Networks'. Journal of Mental Health (Abingdon, England) 30 (4): 494 - 99. https://doi.org/10.1080/09638237.2020.1739238.

13 참고 문헌

Valtanen, Kari, and Mia Kurtti. 2017. 'Fundamental Course for Dialogical Training'.

Webber, Martin, and Jack Nathan. 2010. Reflective Practice in Mental Health: Advanced Psychosocial Practice with Children, Adolescents and Adults. Jessica Kingsley Publishers.

Weber, Kirsten, and Lone Johansen. 2007. Åben Dialog-Nu Og i Fremtiden? : Erfaringer

Med at Indføre Elementer Af Åben Dialog-Tænkningen i Sygehuspsykiatrien 2004-06. Roskilde Universitet. https://forskning.ruc.dk/en/publications/%C3%A5ben-dialog-nu-og-i-fremtiden-erfaringer-med-at-indf%C3%B8re-elementer.

WHO. 2021. 'Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centred and Rights-Based Approaches'. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707.

World Health Organization. 2019. Human Rights: WHO QualityRights Core Training - for All Services and All People: Course Guide. Geneva: World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/329538.

박종언. 2023. '"오픈 다이얼로그를 진행하며 아들이 아들이 아니라 고통받는 한 '인간'으로 보였다" 〉 뉴스 | E마인드포스트'. E마인드포스트. 2023. http://www.-mindpost.or.kr/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id =7059&sfl=wr_-subject%7C%7Cwr_content&stx=%EC%98%A4%ED%94%88+%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%96%BC%EB%A1%9C%EA%B7%B8&sop=and&page=2.

제철웅, 강상경, 김문근, 김성수, 장창현, 정성권, and 정여진. 2022. '정신장애인 인권친화적 치료환경 구축을 위한 실태조사'. [NHRC] 국가인권위원회 발간자료, January, 2022.

부 록 1.

연구논문 전체 수록

다음 논문은 본 가이드북의 기초 자료로 활용된 연구 논문이며, 독자의 이해를 돕기 위해 원문 전체를 부록에 수록합니다. 본 논문은 Open Access (CC BY 4.0) 하에 배포되고 있습니다.

논문 정보

Sooni Cho, Yong Hyuk Cho, Jai Sung Noh, Seong Kwon Jeong, Shin Kwon Ki, Seongsu Kim. (2024).
Introducing Open Dialogue as part of the WHO QualityRights Project in South Korea: experiences and opinions from an introductory workshop and 1-year pilot practice.
Frontiers in Psychology, 15, Article 1426122.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1426122

© 2024 Sooni Cho, Yong Hyuk Cho, Jai Sung Noh, Seong Kwon Jeong, Shin Kwon Ki, Seongsu Kim.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). Use, distribution or reproduction is permitted, provided the original authors and source are credited. No use is permitted which does not comply with these terms.

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

입문 워크숍과 1년 시범 운영 참여자들의 경험과 의견을 중심으로[1]

초록

본 연구는 한국에서 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 진행된 오픈 다이얼로그(Open Dialogue, OD) 단기 입문 워크숍과 1년간의 OD 시범 운영에 참여한 이들의 경험과 OD에 대한 의견을 탐구하기 위해 설문조사를 활용한 연구이다. 의도적 표본 추출을 통해 선정된 24명의 연구 참여자를 대상으로, 워크숍 직후와 1년 후의 경험 및 OD에 대한 의견을 조사하였으며, 수집된 데이터는 통계적 접근법과 주제분석법을 통해 분석되었다.

양적 분석 결과, 모든 참여자에게서 '유연성과 이동성(Flexibility and Mobility)'의 가용성이 통계적으로 유의미하게 감소한 것으로 나타났으며(p=0.044), 1년 동안 네트워크 모임에 참여한 그룹에서는 '불확실성에 대한 수용(Tolerance of Uncertainty)'의 가용성이 유의미하게 감소한 것으로 관찰되었다(p=0.04).

질적 분석 결과, 참여자들은 초기에는 제도적, 문화적, 직업적 어려움으로 인해 OD 도입에 대해 불편한 양가감정을 느꼈으나, 경험적 학습을 통해 이러한 양가감정이 희망으로 전환되었고, 연대감과 함께 향후 OD 실천에 대한 긍정적인 전망을 형성한 것으로 나타났다. 또한, 참여자들은 OD가 당사자의 인권을 지원하는 접근법임을 인식했으며, 동시에 OD를 성공적으로 도입하기 위해 개인적, 조직적, 정책적 수준에서의 과제를 해결해야 한다는 점을 자각하였다. 본 연구 결과는 한국에서 OD 교육 및 실행 지침을 개발하는 데 중요한 통찰을 제공하며, OD 교육 및 도입을 효과적으로 실행하기 위해 첫번째, 경험적 학습에 중점을 둔 교육 설계, 두 번째, OD 도입 지역(catchment area)의 다양한 기관에 소속된 혼합 그룹 교육생 구성, 셋째, OD가 당사자의 인권을 지지하고 촉진할 잠재력을 강조, 넷째, OD정책 기획 시 개인, 조직, 시스템의 세 가지 수준의 통합적인 고려하길 제언한다.

본 연구는 하향식 국가 연구개발 프로젝트를 통한 OD 보급의 새로운 사례이자, WHO QualityRights 서비스 패키지에 OD가 통합된 최초의 사례로서, OD와 국제적 인권 기반 정신건강 이니셔티브 간의 상호보완적 가능성을 제시한다.

키워드: Open Dialogue, WHO QualityRights, human rights, recovery practice, person-centered

1. 서론

오픈 다이얼로그(OD)는 핀란드 서부 라플란드에서 개발된 정신건강 관리 시스템으로, 위기 상황이나 도움이 필요한 사람들에게 치료적이면서도 철학적인 접근 방식을 제공한다. 이는 정신건강 서비스를 조직하는 방식으로, 위기 상황의 사람들에게 응답할 수 있는 가능성을 최대화하는 접근법이다. (Jackson & Perry, 2015; Putman, 2021b). OD는 개인 심리역동적 치료와 체계적 가족 치료의 요소를 통합하며, 관계의 중심성을 강조하고 가족 및 네트워크 참여를 통해 연결감을 증진하는 데 초점을 맞춘다(WHO, 2021, 9페이지)

[1] 이 논문은 본 연구개발의 일환으로 작성되어 국제 학술지인 Frontiers in Psychology에 개제된 원고의 국문번역본이다.
원문 링크: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1426122/full

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

수십 년간의 발전 과정을 통해OD의 일곱 가지 핵심 원칙이 도출되었다(Seikkula 외, 2001). 이 원칙에는 (1) 즉각적인 도움(immediate help), (2) 사회적 네트워크 관점 (social network perspective), (3) 유연성과 이동성(flexibility and mobility), (4) 책임감(responsibility), (5) 심리적 연속성 (psychological continuity), (6) 불확실성에 대한 관용(tolerance of uncertainty), (7) 대화주의(dialogism)가 포함된다. 처음 다섯 가지 원칙은 서비스 구조와 관련되며, 마지막 두 가지는 실천의 형태와 관련된다. 이러한 원칙은 각각 독립적인 것이 아니라 상호 연관되어 있으며 서로 긴밀히 의존하고 있다(-Seikkula & Olson, 2003). 따라서 OD를 효과적으로 실행하기 위해서는 실질적인 기술과 팀워크가 서비스 시스템의 조정 방식과 필수적으로 연계되어야 한다.

OD의 효과는 다수의 연구를 통해 검증되었다. 2018년 핀란드에서 진행된 등록 기반 코호트 연구에서는 약 19년에 걸쳐 전국 대규모 대조군과 비교하여, OD 코호트가 병원 치료 기간, 장애 수당, 신경 안정제 사용률에서 유의미하게 낮은 수치를 보였다(Bergstr☒m 외, 2018). 또한, OD 코호트 참여자들은 전통적 치료군보다 직장 고용 결과에서 더 나은 성과를 보이는 경향이 있었다(Seikkula 외, 2006). 또 다른 전국 단위의 5년 코호트 연구에서는 서부 라플란드가 핀란드에서 병원 치료 기간과 장애 연금 수급률이 가장 낮은 지역임을 밝혔다(Kiviniemi, 2014). 질적 연구 결과에서도 당사자, 가족, 전문가들이 OD 접근법에 대해 긍정적으로 평가하였다(Tribe 외, 2019).

한편, 세계보건기구(WHO)는 유엔(UN) 장애인권리협약(CRPD)에 기반하여 정신건강 시스템과 서비스, 실천이 인권을 존중하도록 설계된 다중 구성요소 프레임워크인 QualityRights 이니셔티브를 개발하여 보급하였다(Funk & Bold, 2020). 이 프로젝트의 일환으로 WHO는 지역사회 기반 정신건강 서비스에 대한 지침에서 OD를 포함시켜, 정신건강 위기 대응 서비스에서 사람 중심적이고 인권 기반 접근법으로 OD를 모범 사례로 권장하였다(WHO, 2021, 27페이지).

이처럼 인상적인 성과를 바탕으로 OD는 전 세계로 빠르게 확산되고 있으며, 현재 5개 대륙 24개국에 100개 이상의 센터에서 이 접근법을 제공하고 있다(Pocobello 외, 2023).

1-1. 다양한 배경에서의 OD 초기 도입

핀란드 서부 라플란드를 제외하면, OD의 7가지 원칙이 완전히 구현된 정신건강 시스템은 아직 존재하지 않는다(Buus et al., 2017). 이는 국가별로 서비스 제공 체계와 협력 구조가 상이하기 때문으로 보인다. 이러한 차이에도 불구하고, OD가 다양한 정신건강 시스템을 가진 국가들에서 어떻게 도입되고 있는지에 관한 연구와 담론이 점차 증가하고 있다(Pocobello et al., 2023).

국가마다 맥락은 다르지만, OD 도입의 초기 단계에서 공통적으로 강조되는 것은 전문가가 OD 실천에 필요한 기술을 습득할 수 있도록 돕는 교육 프로그램의 도입이다. 현재 많은 국가에서는 OD 기초 교육을 전문가들에게 제공하며, 이 교육은 일반적으로 16~20일의 기간으로 구성된다(Putman, 2021a).

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

한편, 본격적인 교육에 앞서 짧은 입문 워크숍이나 단기 교육을 실시하는 사례도 많다. 이는 사회적 합의와 정책적 지원이 충분하지 않은 상황에서, 제한된 시간과 자원을 활용하여 OD를 현실적으로 도입하고 확산하기 위한 방안으로 볼 수 있다. 예를 들어, 영국의 한 OD 컨퍼런스 설문조사에서는 참가자들이 OD가 임상적 가치와 팀워크에 긍정적 변화를 가져올 가능성에 동의했으나, 이를 성공적으로 실행하기 위해서는 자원 투자와 서비스 문화의 전환이 필요하다는 점을 지적하였다(Razzaque & Wood, 2015). 비교적 짧은 42시간의 OD 교육 프로그램과 시범 운영에 참여한 호주의 사례에서는 참여자들이 기존과는 "다른" 학습 경험을 통해 치료적 접근에 대한 관점을 재정립하고, 교육 참가자 간 유대감이 강화되었다고 보고하였다(Buus et al., 2023). 이와 함께, 두 개의 공공보건기관에서 단기 교육을 시행한 경험은 조직 문화와 리더십이 보다 관계 지향적으로 전화해야 할 필요성을 강조하기도 했다 (Lennon et al., 2023). 또한, 미국의 정신과 병동에서 단기 OD 교육 후 시범운영을 실시한 연구에서는 이 접근법이 임상 효율성을 높이고, 당사자-전문가 간 의사소통을 개선하며, 당사자 중심의 치료 환경을 조성하는 데 효과적이라는 결과를 제시하였다(Rosen & Stoklosa, 2016). OD 정식 교육 없이 온라인 워크숍만 경험한 정신건강 종사자 그룹에서도, 정기적 슈퍼비전을 기반으로 대화적 접근이 임상 실천과 팀워크에 유의미한 영향을 미쳤다는 보고가 있다(Skourteli et al., 2023). 여러 지역에서는 2~4일간의 짧은 OD 워크숍이 다수 진행된 바 있으나(예: Yale University Institute for Dialogic Practice, 2022; Brown, 2023; Dialogue (R)Evolution, 2022), 이러한 워크숍에 대한 연구는 정식 교육이나 기초 교육에 비해 상대적으로 부족한 상황이다.

앞서 제시한 선행 연구에 따르면, OD의 초기 도입을 위해 단기 워크숍 및 시범 운영에 참여한 전문가들은 OD 원칙에 기반한 접근이 전문가의 정체성, 조직 내 팀워크, 그리고 외부 기관과의 협력을 포함한 다층적 변화가 요구된다고 보고하였다. 동시에, OD와 기존 서비스 체계 간 차이로 인해 실천 과정에서 발생하는 어려움도 빈번히 보고되었다.

따라서 OD를 처음 도입하려는 국가나 시스템에서는 정식 교육뿐만 아니라 초기 입문 단계부터 기존 서비스와의 갈등 및 저항을 최소화하고, 참여자들이 OD 교육의 고유한 강점을 충분히 체험하며 실천 동기를 가질 수 있도록 교육 과정을 신중히 설계할 필요가 있다.

1-2. 한국의 WHO QualityRights 프로젝트 일환으로서 OD 도입

한국의 정신건강 서비스 체계는 다학제적 협력을 촉진할 법적·실무적 기반이 부족하여 심각한 분절화로 인한 다양한 문제를 겪고 있으며, 시스템 내 당사자의 참여도 매우 미약한 실정이다(국립정신건강센터, 2023). 지역사회 기반 위기 개입은 주로 급속하고 비자발적 입원에 의존하고 있으며, 이는 정신건강 종사자들 사이에서 높은 소진율과 이직률을 초래하고 있다(Yoon, 2023). 국가인권위원회는 한국 정신건강 부문에서 당사자의 인권 보호가 여러 측면에서 미흡하다고 지적하며, 자기결정권 보장, 비입원적 대안의 제공, 강압적 치료 감소가 시급히 필요하다고 제안하였다(국가인권위원회, 2021).

현재의 한국 정신건강 시스템은 당사자와 치료자 모두에게 부담을 가중시키고 있어, 이러한 상황을 극복하기 위해 새로운 형태의 협력과 대화가 절실하다. 이에 따라 WHO가 제안한 인권 및 회복 기반 접근법은 다중 이해관계자 및 다 부문 협력을 촉진하며, 서비스 개혁을 위한 유용한 틀로 주목받고 있다(Cho, 2023).

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

2021년, 보건복지부는 WHO QualityRights 기반 서비스의 한국 내 확산을 목표로 하는 R&D 프로젝트를 공고하며, OD를 포함한 교육 및 실행 지침의 개발을 요구하였다. 이 프로젝트의 일환으로 한국 최초의 OD 입문 워크숍과 1년간의 시범 운영이 이루어졌다. 프로젝트의 전체 조직과 실행 과정, 한국 정신건강 서비스의 구체적인 상황에 대한 세부 사항은 보충 자료에서 확인할 수 있다. (보충자료 1)

1-3. 연구 목적

본 연구는 다음과 같은 주요 연구 질문을 다룬다.

- 5일간의 OD 입문 워크숍에 참석한 참여자들의 경험은 어떠했는가?
- 1년간의 OD 시범 운영에 참여한 참여자들의 실천 경험은 어떠했는가?
- WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 진행된 OD 입문 워크숍 이후, 1년간의 OD 시범 운영 기간 동안 참여자들의 OD에 대한 의견은 어떻게 변화하였는가?

이러한 질문을 통해 한국 정신건강 시스템의 요구에 부합하는 OD 교육 및 서비스 지침 설계를 위한 기초 자료를 제공하고, OD가 현장의 이해관계자들에게 도달하는 방식을 구체화하고자 하였다.

또한, 본 연구는 OD가 단독으로 도입된 것이 아니라 WHO 가이드라인을 기반으로 한 QualityRights서비스 패키지의 일환으로 도입되었다는 점에서 차별성을 갖는다. 이에 따라, OD를 새로운 인권 기반 프레임워크에 포함시켰을 때 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 확장된 질문도 제기된다.

2. 연구 방법

2-1. 연구 배경 및 운영 과정

본 연구는 OD, 비강압 치료, 지원 의사결정, 리커버리 프로그램 개발을 병행하는 R&D 프로젝트의 일환으로 수행되었다. 본 연구는 특히 OD 실행 지침 개발에 초점을 맞추어 다음과 같은 단계로 진행되었다.

2-1-1. OD 입문 워크숍

2023년 3월, 핀란드와 영국에서 초청된 국제 강사 두 명이 참여하여 5일간(총 40시간) 입문 워크숍을 진행하였다. 워크숍에는 정신과 의사, 간호사, 사회복지사, 임상 심리사, 당사자 지원가, 가족 활동가, 인류학자 등 다양한 직군에서 총 28명이 참여하였다. 워크숍의 구성 요소는 OD의 7가지 핵심 원칙과 12가지 핵심 요소에 대한 이론 강의, 소그룹 실습 및 역할극을 통한 기법 연습, 국내 OD 도입 방안에 대한 심도 있는 토론이 포함되었다.

2-1-2. 1년간의 네트워크 모임 시범운영

네트워크 모임 시범 운영은 2022년 10월부터 수원시 지역을 중심으로 진행되었다. 홍보는 지역 정신건강센터를 통해 이루어졌으며, 참여를 희망하는 개인 또는 가족이 센터에 연락하면 촉진자 팀이 모임을 주관하였다.

모임 장소는 당사자가 선호하는 장소(대부분 자택)로 지정되었으며, 대상자는 정신병적 증상이 의심되거나 진단된 경우에 참여할 수 있었다. 연구 기간 동안 총 11가족과 89회의 네트워크 모임이 진행되었으며, 모든 모임은 최소 90분 동안 진행되었다. 촉진자 팀에는 영국에서 공식 OD 기초 교육을 이수하고 국제 트레이너 훈련을 받고 있는 정신과 의사(김성수)가 포함되었으며, 핵심 요소의 충실성을 유지하기 위해 대부분의 모임에 참여하였다.

2-1-3. 슈퍼비전

네트워크 모임 중 일부는 당사자와 가족으로부터 동의를 받은 후 비디오로 녹화되었으며, 연구자(김성수)는 영국의 국제 트레이너로부터 슈퍼비전을 받고 그 피드백을 한국의 동료들과 공유하였다. 워크숍 참가자 전원을 대상으로 월간 슈퍼비전 모임이 개최되었으며, 이 모임에서는 현재 진행 상황, 네트워크 모임에서의 어려움과 긍정적인 경험을 공유하였다. 프로젝트 연구자들은 매주 정기적으로 모여 시범 운영에 대한 심도 있는 논의를 진행하였으며, 모든 슈퍼비전 회의는 동일한 연구자(김성수)가 주관하였다.

2-2. 참여자

OD 입문 워크숍에 참석한 참가자를 대상으로 의도적 표집을 통해 연구 참여자를 선정하였다. 총 2 8명이 워크숍에 참여하였으며, 이 중 25명이 연구 참여에 동의하고 첫 번째 설문에 응답하였다. 두 번째 설문에서는 25명 중 24명이 설문을 반환하였다. 시범 운영 종료 후, 연구 참여자는 네트워크 모임 경험 여부에 따라 두 그룹으로 분류되었다:

- 네트워크 모임 경험 그룹 : 특정 연구자(김성수)와 함께 시범 운영 동안 네트워크 모임에 촉진자로 참여한 총 10명.
- 네트워크 모임 미경험 그룹 : 네트워크 모임 경험 그룹에 포함되지 않은 나머지 참여자들.

2-3. 연구 자료

참여자들에게는 성별, 연령, 직업, 정신건강 서비스 경험 등 인구통계학적 정보를 수집하기 위한 설문지가 제공되었다.
OD에 대한 참여자들의 의견과 워크숍 및 시범 운영에 대한 경험을 평가하기 위해 Razzaque와 Wood(2015)가 개발한 설문지를 기반으로 OD 의견 설문지(Open Dialogue Questionnaire)를 작성하였다. 첫 번째 설문은 워크숍 종료 1주 후에, 두 번째 설문은 워크숍 종료 1년 후에 실시되었다. 설문지는 정량적 및 정성적 요소를 포함한 두 섹션으로 구성되었다. 첫 번째 섹션은 리커트형 문항으로, 두 번째 섹션은 개방형 문항으로 이루어졌다.

리커트형 문항은 OD의 7가지 핵심 원칙(Seikkula et al., 2001, 2003)에 대한 참여자들의 평가를 요청하였다. 7가지 원칙은 다음과 같다: 1) 즉각적인 도움, 2) 사회적 네트워크 관점, 3) 유연성과 이동성, 4) 책임성, 5) 심리적 연속성, 6) 불확실성에 대한 수용, 7) 대화주의

각 원칙에 대해 참여자들에게 다음 두 가지 리커트형 문항이 제시되었으며, 참여자들은 0점(전혀 동의하지 않음)에서 9점(매우 동의함)까지의 10점 척도로 응답하였다.

- "각 핵심 원칙이 당사자 돌봄에 얼마나 중요하다고 생각하십니까?"
- "각 핵심 원칙이 현재 한국의 정신건강 서비스에 적용 가능하다고 생각하십니까?"

또한, 두 번째 설문에서는 추가로 "각 원칙을 자신의 직장에서 바로 적용할 수 있다고 생각하십니까?"라는 문항이 포함되었으며, 동일한 리커트 척도를 사용하여 응답하였다.

질적 응답을 얻기 위해 다음 네 가지 개방형 질문이 제시되었다.

- 오픈 다이얼로그가 어떤 점에서 중요하다고 생각하시나요?
- 오픈 다이얼로그에 대해 귀하의 의견/생각은 무엇인가요?
- 오픈 다이얼로그 방식을 구현하는 데 어떤 어려움이 있을 것으로 예상되나요? (첫 번째 설문)
  "오픈 다이얼로그 방식을 구현하는 데 어떤 어려움을 겪으셨나요?" (두 번째 설문)
- 오픈 다이얼로그를 다른 사람에게 설명한다면 어떻게 설명하겠습니까?

추가적으로, 첫 번째 설문에서는 다음 두 가지 질문이 포함되었다:

- OD 워크숍에서 좋았던 점은 무엇입니까?
- OD 워크숍에서 아쉬웠던 점은 무엇입니까?

두 번째 설문에서는 추가로 다음과 같은 질문이 포함되었다.

- 현재 귀하의 직장에서 적용 가능성이 높다고 평가한 오픈 다이얼로그 주요 원칙을 실행하고 유지하기 위해 어떤 도움이나 자원이 필요하다고 생각하십니까?

2-4. 자료 수집

참여자들에게 두 설문지가 워크숍 마지막 날 이메일로 발송될 것임을 사전에 안내하였다. 설문지 발송에 앞서, 참여자들은 연구 동의서에 서명하였으며, 인구통계학적 데이터를 포함한 기본 양식을 작성하였다. 첫 번째 설문지는 2023년 3월 워크숍 종료 후 발송되어 1개월 이내에 회수되었으며, 두 번째 설문지는 워크숍 종료 1년 후 발송되어 동일한 회수 기간 내에 완료되었다. 개방형 질문에 대한 응답 내용이 불명확한 경우, 이메일이나 문자 메시지를 통해 참여자에게 확인을 요청하여 정확한 표현을 확보하였다.

2-5. 윤리적 고려

본 연구는 아주대학교병원 기관윤리심의위원회(AJOUIRB-SB-2023-173)의 승인을 받았다. 참여자들은 서면으로 연구 참여에 동의하였으며, 참여는 자발적이며 언제든지 불이익 없이 철회할 수 있음을 안내받았다. 연구는 국내 법률 및 기관 규정을 준수하였으며, 데이터는 익명성을 보장받았고 최소한의 인구통계학적 정보만을 수집하여 비밀번호로 보호된 안전한 노트북에 저장되었다.

2-6. 분석

2-6-1. 변수 및 통계 분석

Shapiro - Wilk 검정을 통해 설문 데이터의 정규성을 확인하였다. 연령과 경력 데이터를 비교하기 위해 네트워크 모임 경험 여부를 독립변수로 설정하여 Student's t-검정을 수행하였으며, 카이제곱 검정을 통해 기타 인구통계학적 데이터를 비교하였다.

리커트 척도로 측정된 OD 7가지 핵심 원칙에 대한 중요성과 적용 가능성 점수의 평균 및 표준편차는 두 시점(첫 번째 및 두 번째 설문조사)에서 계산되었다(n=24). 모든 참여자들의 시간 경과에 따른 점수 변화의 통계적 유의성을 평가하기 위해 대응 표본 t-검정을 수행하였으며, 네트워크 모임 경험 그룹(n=10)과 미경험 그룹(n=14) 간 시간에 따른 점수 변화가 상이한지를 확인하기 위해 혼합 분산분석(mixed ANOVA)을 실시하였다. 시간과 경험 그룹 간의 상호작용 효과를 검정하는 데 중점을 두었다. 모든 통계 분석은 SPSS 25.0 버전을 사용하여 수행되었다.

2-6-2. 주제 분석

개방형 설문지 응답은 Braun과 Clarke(2006)의 6단계 주제 분석법을 기반으로 분석되었다. 두 명의 저자(조순이와 김성수)는 원자료에 깊이 몰입하여 개방형 질문에 대한 참여자들의 응답을 철저히 검토하였으며, 주요 의미 단위를 식별하였다. 이후 두 저자는 독립적으로 코딩 작업을 수행한 후, 도출된 코드를 상호 비교하였다. 의견이 일치하지 않는 경우 심도 있는 논의를 통해 합의에 도달하였으며, 최종적으로 750개의 코드를 도출하였다.

이후 공동 1저자(조순이)는 유사한 코드를 군집화하고 핵심 내러티브를 구체화하였으며, 일관성과 적합성을 검토하며 세부적으로 정제하였다. 그 다음 OD 입문 워크숍에 참여한 경험이 있는 두 연구자(조용혁과 정성권)가 검증 과정에 참여하여 주제를 정의하고 명명하는 작업을 공동으로 수행하였다. 조용혁은 지역사회 정신건강센터 소속 정신과 전문의이며, 정성권은 정신건강 의료기관 소속 정신과 전문의로, 두 연구자는 실천적 경험을 바탕으로 연구 결과에 실용적 관점을 더하는 데 기여하였다. 최종적으로 총 4개의 주요 주제와 10개의 하위 주제가 도출되었으며, 이는 네 명의 연구자가 논의와 합의를 통해 참여자들의 경험을 가장 충실히 반영한 결과이다.

3. 연구 결과

3-1. 인구통계학적 특성

총 24명의 참여자가 두 차례 설문조사 (워크숍 직후와 1년 후)를 모두 완료하였다. 참여자는 정신건강의학과 전문의, 간호사, 사회복지사, 임상심리사, 미술치료사, 동료지원가 및 가족 활동가 등 다양한 직군으로 구성되었다. 또한, 국민건강보험 체계 내의 의료기관에서 근무하는 인력과 공공보건 예산으로 운영되는 지역사회 기관에서 근무하는 인력을 구분되었다. 모든 참여자의 인구통계학적 특성은 〈표 1〉에, 네트워크 모임 참여 여부에 따른 두 집단의 특성은 〈보충자료 1〉에 제시하였다.

Demographic			N	%	Mean	S.D.
Age			24		47.88	10.67
Gender	Male		5	20.8		
	Female		19	79.2		
Occupation	Medical	Psychiatrist	3	12.5		
		Nurse	11	45.8		
	Non-medical	Social worker	4	16.7		
		Psychologist	1	4.2		
		Art therapist	1	4.2		
		Peer support	2	8.3		
		Family activist	2	8.3		
Length of career			24		16.18	7.31

Table 1. Demographic characteristics of participants

3-2. OD 리커트형 척도

워크숍 직후(t1)와 1년 후(t2) 두 시점에서 OD의 7가지 핵심 원칙의 중요성과 적용 가능성에 대한 전체 참여자들의 인식을 비교하기 위해 Paired t-test를 실시하였다〈표 2〉. 워크숍 직후(t1), 모든 원칙의 평균 중요도 점수는 7.71 이상이었으며, 이 중 대화주의의 평균 점수가 8.50으로 가장 높게 나타났다. 적용 가능성 점수 또한 대화주의에서 가장 높은 평균 6.83을 기록하였으나, 모든 원칙에서 중요도 점수보다 낮은 경향을 보였다. 1년 후(t2), 모든 원칙에서 중요도 평균 값이 감소하는 경향이 있었으나, 이러한 변화는 통계적으로 유의하지 않았다. 반면 적용 가능성에서는 t1에 비해 전반적인 감소가 관찰되었으며, 특히 '유연성과 이동성(flexibility and mobility)'의 평균 값이 5.79에서 4.79로 유의미하게 감소($p = 0.044$)하였다.

하위 그룹 분석에서 참여자들은 네트워크 모임 참여 여부에 따라 두 그룹으로 나뉘어 분석되었다. 혼합분산분석(mixed ANOVA)을 통해 시간(t1에서 t2까지)과 그룹 경험 간의 상호작용 효과를 평가하였으며, 네트워크 미팅 참여 여부에 따른 차이에 초점을 맞추었다. (표 3).중요도에 대한 분석에서는 네트워크 모임을 실시한 그룹과 그렇지 않은 그룹 모두 t1에서 t2로 유사한 평균값 변화를 나타냈으며, 통계적으로 유의미한 차이는 관찰되지 않았다. 즉, 그룹 간(네트워크 모임 참여 그룹 vs. 비참여 그룹) 주효과, 시간(t1 vs. t2) 주효과, 그룹과 시간 간 상호작용 효과 모두 유의미하지 않았다. 반면, 적용 가능성에 대한 분석에서는 '불확실성의 수용' 원칙에서 그룹 또는 시간에 따른 주효과는 유의하지 않았으나, 그룹과 시간 간의 상호작용 효과는 통계적으로 유의미하게 나타났다($p = 0.04$).

Variable		Mean (±S.D.)	t	p
Importance				
Provisionofimmediatehelp	t1	7.71 ± 1.65	1.813	0.083
	t2	7.33 ± 1.97		
Asocialnetworkperspective	t1	8.17 ± 1.07	2.076	0.050
	t2	7.39 ± 1.85		
Flexibilityandmobility	t1	7.96 ± 0.95	0.768	0.450
	t2	7.71 ± 1.49		
Responsibility	t1	7.96 ± 0.86	1.440	0.163
	t2	7.50 ± 1.50		
Psychologicalcontinuity	t1	7.92 ± 0.97	1.551	0.135
	t2	7.50 ± 1.69		
Toleranceofuncertainty	t1	8.04 ± 1.40	1.440	0.163
	t2	7.58 ± 1.32		
Dialogism	t1	8.50 ± 0.98	0.440	0.664
	t2	8.42 ± 0.83		
Availability				
Provisionofimmediatehelp	t1	4.63 ± 2.04	0.000	1.000
	t2	4.63 ± 2.39		
Asocialnetworkperspective	t1	5.92 ± 1.86	0.730	0.478
	t2	5.54 ± 1.82		
Flexibilityandmobility	t1	5.79 ± 1.82	2.127*	0.044
	t2	4.79 ± 1.59		
Responsibility	t1	5.75 ± 1.70	0.720	0.479
	t2	5.50 ± 1.59		
Psychologicalcontinuity	t1	4.29 ± 2.16	-1.496	0.148
	t2	5.13 ± 2.21		
Toleranceofuncertainty	t1	5.17 ± 2.04	-0.920	0.367
	t2	5.54 ± 1.91		
Dialogism	t1	6.83 ± 1.88	0.207	0.838
	t2	6.75 ± 1.54		

NM,networkmeeting,*p<0.05.

Table 2. Results of a paired T-test for measures 1 month post-workshop (t1) and 1 year post-workshop (t2) for all participants.

Variable		Group that practiced NM Mean (±S.D.)	Group that did not practiceNM Mean (±S.D.)	*F*	*p*
Importance					
Provisionofimmediatehelp	t1	7.40 ± 1.35	7.93 ± 1.86	1.813	0.083
	t2	7.20 ± 1.99	7.43 ± 2.03		
Asocialnetworkperspective	t1	8.44 ± 0.88	8.00 ± 1.18	2.076	0.050
	t2	7.78 ± 1.79	7.14 ± 1.92		
Flexibilityandmobility	t1	7.90 ± 1.10	8.00 ± 0.88	0.768	0.450
	t2	7.90 ± 0.99	7.57 ± 1.79		
Responsibility	t1	7.80 ± 0.79	8.07 ± 0.92	1.440	0.163
	t2	7.80 ± 1.23	7.29 ± 1.68		
Psychologicalcontinuity	t1	7.80 ± 1.03	8.00 ± 0.96	1.551	0.135
	t2	7.40 ± 1.35	7.57 ± 0.95		
Toleranceofuncertainty	t1	8.20 ± 1.03	7.93 ± 1.64	1.440	0.163
	t2	8.10 ± 0.88	7.21 ± 1.48		
Dialogism	t1	8.80 ± 0.42	8.29 ± 1.20	0.440	0.664
	t2	8.70 ± 0.48	8.21 ± 0.97		
Availability					
Provisionofimmediatehelp	t1	4.80 ± 2.04	4.50 ± 2.10	2.07	0.13
	t2	3.80 ± 2.53	5.21 ± 2.19		
Asocialnetworkperspective	t1	6.60 ± 1.35	5.43 ± 2.06	0.74	0.40
	t2	5.70 ± 1.70	5.43 ± 1.95		
Flexibilityandmobility	t1	5.90 ± 1.73	5.71 ± 1.94	0.28	0.6
	t2	5.20 ± 1.23	4.50 ± 1.79		
Responsibility	t1	5.70 ± 1.49	5.79 ± 1.89	0.13	0.72
	t2	5.60 ± 1.43	5.43 ± 1.74		
Psychologicalcontinuity	t1	3.50 ± 2.12	4.86 ± 2.07	0.73	0.40
	t2	4.90 ± 2.28	5.29 ± 2.23		
Toleranceofuncertainty	t1	5.90 ± 1.66	4.64 ± 2.17	4.76	0.04*
	t2	5.30 ± 1.83	5.71 ± 2.02		
Dialogism	t1	7.30 ± 1.34	6.50 ± 2.18	0.20	0.66
	t2	7.00 ± 1.76	6.57 ± 1.40		

NM,networkmeeting,*p<0.05.
ThevaluesofFandparethevaluesof(group*time).
Table 3. Results of a mixed ANOVA for measures taken at 1 month post-workshop (t1) and 1 year post-workshop (t2) for participants grouped by network meeting practice

3.3 질적 결과

주제분석을 통해 총 4 개의 주요 주제와 10개의 하위 주제가 도출되었다 (표4). 주요 주제와 하위 주제는 대표적인 인용문과 함께 아래에 요약된다.

Maintheme	Subtheme Content	
Uncomfortable ambivalence toward OD : systemic, cultural, and professional challenges in korea vs.human rights potentials	Reluctance and doubt about a different approach to traditional practice	• Systemic challenges • Cultural challenges • Anxiety of new professional roles
	The weighty responsibility of OD implementation as a human rights potential	• Recognizing the limitations of conventional psychiatric services in SouthKorea • Thepotentials of OD for human rights restoration
From ambivalence to hope : creating safe spaces with experiential learning of OD in workshop	Gradual immersion in OD through exercises and role-plays	• Healing experiences of being heard and having responses • Recognizing the need for multiple perspectives through reflection exercises • Experiencing different roles and understanding each other
	Creating a safe space and solidarity	• Hierarchy dissolution and individual spontaneity unleashed • Internal ambivalence and diverse external perspectives evolve into polyphony • Building a sense of Solidarity
	Fueled with hope for implementing OD inpractice	• Understanding OD as a way of life beyond a mere skill and discovering resources as a facilitator • Expecting OD implementation in various settings and attunement among services
Striving to implement OD as a human rights approach in various settings	Restoring dignity	• Attentive listening and respecting voices • Respecting pace and embracing uncertainty
	The role of Open Dialogue in supporting human rights	• Restoring autonomy and self-determination • Reducing coercion • Promoting collaboration within network and inclusion in community
Identifying challenges and exploring complements for O Dimplementation	Personal perspectives	• Confusion surrounding the comprehension of OD • Facilitator self-reflection • Maintaining connectivity and sustaining reflective supervision
	Organizational perspectives	• Difficulty in implementing in hierarchical institutional cultures • Creating a new institutional culture
	Policy and institutional perspectives	• Time commitment • Difficulty in ensuring psychological continuity • Safety and legal concerns in crisis intervention • Need for training programs • Policy and institutional support

Flexibility and mobility

Table 4. Main themes and subthemes extracted from the thematic analysis

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

제 1 주제.
OD에 대한 불편한 양가감정 : 한국의 제도적, 문화적, 직업적 도전 vs. 인권 지원 서비스로서의 가능성

제1주제는 OD 입문 워크숍에서 참여자들이 처음으로 OD를 접했을 때 느낀 불편한 양가감정을 묘사한다. 이는 기존의 전통적 모델과 확연히 다른 접근 방식으로 인해 발생한 반응으로, OD를 한국에서 실행하기 어렵고 부적합하다고 인식하며 주저와 의구심을 표현했다. 그러나 동시에 OD가 당사자의 인권을 회복하는 데 필요한 중요한 접근 방식임을 공감하며, 이를 배우고 실천해야 한다는 책임감 또한 느꼈다. 하위주제로는 '기존 정신건강서비스 모델과 다른 접근법에 대한 주저와 의구심', '인권 지원 서비스로서의 OD 실천에 대한 막중한 책임감' 이 도출되었다.

하위주제 1 : 기존 정신건강서비스 모델과 다른 접근법에 대한 주저함과 의구심

참여자들은 OD를 국내에서 실천하는 데 있어 양가감정을 느꼈으며, 이 중 첫 번째로는 새로운 접근법에 대한 주저와 의구심이 하위 주제 1로 도출되었다. 워크숍 첫날, 참여자들은 OD의 핵심 원칙과 요소를 소개받았다. 대부분의 참여자들이 OD에 대한 사전지식이 거의 없었고, 많은 이들이 OD가 기존의 전통적 모델과 뚜렷이 다른 점을 발견하고, 이를 기반으로 한국에서 OD를 실행하는 것이 가능할지에 대해 의문을 제기하였다. 일부 참여자들은 이를 "의문점", "불편함", "상당히 도전적인 서비스"라고 표현하며 우려를 나타냈다(P8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21).

· 제도적 도전과제

참여자들은 핀란드와 한국 간의 보건의료제도 차이로 인해 OD 도입이 여러 제도적 도전 과제를 동반할 가능성이 높다고 지적하였다(P2, 6, 15, 20, 22). 한국의 국민건강보험제도가 행위별 수가제를 기반으로 운영되는 상황에서 OD를 이 체계에 통합하는 것이 현실적으로 가능할지에 대해 의문이 제기되었다(P20).

구체적으로, OD와 관련된 별도의 청구 코드가 부재하여 수가 설정 단계에서 혼란이 발생할 가능성이 제기되었으며(P6, 15, 20), OD가 공중보건예산을 통해 지원될 경우 예산 확보가 충분히 이루어질 수 있을지에 대한 우려가 나타났다. 또한, OD가 비급여 항목으로 분류될 경우 '높은 치료 비용으로 인한 귀족 치료화'와 같은 문제가 발생하여 서비스 불균형을 초래할 가능성이 있다고 지적되었다(P17, 22).

참여자들은 OD 서비스를 지원하기 위한 정책적 프레임워크와 가이드라인이 한국 내에 부재하다는 점도 주요 장애 요인으로 꼽았다(P9, 13, 24). 한국의 정신건강 서비스 체계는 분절적인 구조를 띠고 있으며, 정신의료기관과 지역사회 정신건강 서비스 기관 간의 협력을 촉진할 수 있는 지침이 부족하여 당사자에게 연속적이고 통합적인 서비스를 제공하기 어렵다는 점이 강조되었다. 이러한 상황에서 OD의 핵심 원칙인 "책임성"과 "심리적 연속성"을 구현하기가 어려울 것으로 예상되었으며, 이는 "서비스 조직 간의 장벽을 극복해야 할 과제"로 인식되었다(P2, 3, 6, 17, 24).

다수의 참여자는 인력 부족과 과도한 업무량 문제가 OD 실행의 주요 장애 요인으로 작용할 것이라고 강조하였다(P1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25). 잦은 인력 교체와 높은 이직률로 인해 심리적 연속성을 유지하기가 어렵다는

점이 지적되었으며(P6, 7, 15), 기존 서비스 유지와 OD 도입이 동시에 이루어지는 것이 정신건강 전문 인력 부족으로 인해 매우 어렵다고 응답하였다(P11, 21, 25).

한 참여자(P21)는 "지역사회 정신건강센터에서 한 명의 전문 인력이 50-60명 이상의 등록 회원을 관리하며, 프로그램 진행, 증진사업, 교육 등의 필수 업무까지 수행해야 한다"**고 지적하였다. 또 다른 참여자(P22)는 "정신건강의학과 전문의가 60-70명의 입원 환자를 담당해야 하는 정신의료기관의 상황도 크게 다르지 않다"고 언급하였다.

관리자급 참여자들은 팀이 인력 부족과 과도한 업무에 시달리는 상황에서 추가적으로 OD 수행을 제안하기가 어렵다고 밝혔다. 특히, 정부가 지역 정신건강 서비스 기관에 양적 성과를 요구하는 상황에서 OD 사업을 시행할 경우, 직원들 사이에 반감을 초래할 가능성이 있다는 우려를 표명하였다(P8, 12, 16).

· 문화적 도전 과제

참여자들은 한국의 문화적 요인이 OD의 적용을 저해할 수 있다는 우려를 나타냈다(P3, 4, 7, 8, 12, 16, 20, 22). 특히, 한국의 "빨리빨리" 문화는 OD의 불확실성 수용 원칙과 상충된다고 평가되었다(P7, 8, 20, 22). 이러한 긴급성을 중시하는 문화적 경향은 한국의 급속한 경제 성장을 촉진한 주요 동력이었으나, 동시에 불확실성에 대한 불편함을 반영한다(Park, 2019). 한 참여자는 "빨리빨리" 문화가 당사자와 가족들로 하여금 신속한 해결책을 추구하도록 만들며, 위기 상황 상황에서 불확실성을 견디는 것을 어렵게 만들 것이라고 언급하였다(P8, 20, 22). 또한, 한국의 빠른 의료 시스템에서 정신과 의사와의 신속한 진료 예약 및 약 처방이 용이하다는 점이 관련된 도전 과제가 될 것으로 예상되었다(P20, 22).

추가적으로, "평가와 판단이 익숙하고 침묵이 미덕으로 여겨지는 문화에서 대화주의를 채택하는 것이 어려울 것"이라는 우려도 제기되었다(P2, 3). 한국 문화에서 침묵을 중시하는 관행은 '눈치'라고 불리는, 타인의 감정을 읽고 조화를 유지하기 위해 행동을 조정하는 문화적 요소에서 비롯되었으며(Robertson, 2019), 이는 대화주의 원칙과 대조적이다.

· 새로운 전문가 역할에 대한 불안감

참여자들은 OD에서 요구되는 새로운 전문가 역할에 익숙하지 않으며, 이는 전문가, 당사자, 네트워크가 OD를 이해하고 신뢰하는 데 오랜 시간이 걸릴 것이라고 우려하였다(P2, 11, 18, 16). 특히, 위기 상황에 있는 당사자와 네트워크가 OD의 철학을 이해하도록 하는 데 어려움을 느꼈으며, 이들은 일반적으로 약물 치료를 통한 빠른 증상 완화를 기대한다고 하였다(P2).

참여자들은 OD가 기존의 익숙했던 관습적 역할을 버리고 새로운 접근 방식을 수용할 용기가 필요하다는 것을 이론적으로 알고 있었으나(P2), "문제를 해결하려는 관습적인 경향을 내려놓는 것에 대한 어려움"을 겪었다 (P18). 이들은 "기존의 틀에 갇힌 자신을 보며 자존감이 하락하고 양가감정을 느꼈다 (P17). 또한, '전문가의 언어를 바꾸는 작업', '판단 중지', '불확실성의 용인'과 같은 대화적 태도를 구현하는 데 도전 과제를 경험하였다(P2, 3, 16).

참여자들은 전문가 중심 체계 내에서 기존에 부여된 역할을 벗어나는 데 불편함을 느꼈다. 한 가족 활동가(P4)는 '의료 지식이 없고 경험 밖에 없는 가족이라서 네트워크 모임에 촉진자로 참여하기가 겁이 난다' 고 하였으며, 또 다른 참여자인 당사자 지원가(P9)는 '전문가가 아니기에 촉진자로서 적합하지 않다'고 느꼈다. 한 정신과 의사(P13)는 '병과 환자에 대한 종합적인 이해가 필요하기 때문에 의사가 적극적으로 나서야 한다'고 주장했으며, 또 다른 가족 활동가(P3)는 '당사자와 가족이 대체적으로 약물과 증상에 대해 듣기를 원하기에 네트워크 미팅에 정신건강의학과 전문의의 부재가 제한적일 수 있다'고 우려하였다.

하위주제 2 : 인권 지원 서비스로서의 OD 실천에 대한 막중한 책임감'

하위주제 2는 워크숍 초기에 참여자들이 OD에 대해 느낀 실천적 책임감을 설명한다. 이는 OD에 대한 양가감정 중 두 번째 감정을 반영하며, OD가 당사자의 인권 회복을 조력하는 잠재력을 지니고 있다는 점을 인식하고 실행에 대한 막중한 책임감을 느낀 상태를 반영한다.

참여자들은 한국적 맥락에서 OD를 적용하는 데 있어 상당한 도전 과제가 존재한다는 점을 인지하고 있었다. 그럼에도 불구하고, 참여자들은 인권적 한계가 드러나는 기존 정신건강 서비스를 보완할 수 있는 OD의 가능성과 필요성을 이해하였다. 이러한 깨달음은 OD가 인권을 증진하는 접근법으로서의 잠재력을 지니고 있다는 점을 강조하며, 참여자들에게 강력한 실천적 책임감을 불러일으켰다.

· 한국의 기존 정신건강 서비스의 한계 인식

워크숍에서 한국의 정신건강 서비스가 지닌 인권적 한계가 직접적으로 논의되지는 않았으나, 다수의 참여자들이 설문 응답을 통해 기존 서비스에서 경험한 부정적 사례를 서술하였다. 워크숍은 참여자들로 하여금 "전통적인 의료 모델의 현실과 한계를 재고하게" 했으며다(P11, 22), 기존 시스템의 구조적 문제와 한계를 성찰하는 계기가 되었다.

참여자들은 강제 치료의 트라우마를 떠올리며, 입원과 약물 치료가 위기 상황에서 대해 기본적이고 우선적인 대응으로 자리 잡고 있음을 언급하였다(P16, 17, 24). 이러한 비자발적 치료는 평생 지속되는 심리적 외상을 초래하였고(P13, 15, 24), 당사자가 낙인과 불안을 느끼게 만들었으며(P5), 자신을 입원시킨 가족에게 원한을 품어 오히려 가족 간 갈등과 고립을 심화하는 결과를 초래하였다고 하였다(P1). 참여자들은 비자발적 입원이 당사자의 사회적 역할과 지위를 상실하게 만드는 주요요인으로 작용했다고 목격한 경험을 언급하였다 (P6, 14).

특히, 전통적인 정신건강 서비스에서 흔히 나타나는 일방적인 소통은 당사자의 고립을 심화 시키는 문제로 지적되었다. "주도적이고 통제적인 개입에 익숙한" 전문가들(P13)은 "당사자를 일방적으로 체계화하거나"(P3), "치료 회의를 전문가들끼리만 진행하며"(P5), "대화 과정에서 당사자를 배제하는 경향"이 있었다고 평가되었다(P5, 14). 이러한 접근은 당사자를 수동적이고 저항적으로 만들었으며(P13), 결과적으로 "당사자의 의존성으로 인해 전문가에게 과도한 심리적 부담을 초래하는 악순환을" 초래한다고 표현하였다(P11, 21, 23).

· OD의 당사자 인권 회복의 잠재력

전통적인 정신건강 서비스와 대조적으로, 참여자들은 OD가 당사자의 인권 가치를 실현하는 데 의미 있는 접근법이라고 평가하였다(P5, 13, 14, 23, 25). OD는 당사자에게 정신건강 치료 과정에서의 주도권과 통제권을 부여하고 상호적인 책임감을 촉진함으로써 당사자의 인권을 회복시키는 것으로 여겨졌다(P6, 15, 17, 18, 22, 23, 24).

또한, OD는 "전문가가 주도하는 독점적 서비스가 아닌 당사자와 함께하는 협력적 서비스"로 인식되었다(P13). OD를 통해 당사자가 치료과정에서 주도권을 가짐으로써, 전문가들 역시 과도한 심리적 부담과 책임감에서 벗어날 수 있는 가능성을 기대하였다 (P5, 11, 13, 15, 20, 21, 24). 이로써 OD는 당사자와 전문가 모두에게 상호적으로 긍정적인 영향을 미치는 접근법으로 자리매김할 잠재력을 지닌 것으로 평가되었다.

제 2주제.

양가감정에서 실천적 희망으로의 전환 : 경험적 학습을 통한 안전한 공간의 형성

제 2주제는 참여자들이 OD 워크숍을 통해 초기의 양가감정이 OD 실천에 대한 희망으로 전환되는 장면을 다룬다. 체험 학습을 통해, 참여자들은 OD가 단순한 치료 기법이 아니라 태도이자 삶의 방식임을 깨닫게 되었으며, 이를 통해 OD의 실천적 가능성을 발견하였다.

워크숍에서 제공된 안전한 공간은 참여자들이 내면의 양가감정을 자유롭게 표출할 수 있는 기회를 제공하였다. 이러한 과정은 다양한 내적 및 외적 관점이 자연스럽게 폴리포니(polyphony)로 공존할 수 있는 환경을 조성하였다. 특히, 이와 같은 강렬한 감정 교류는 참여자들 간의 연대감을 형성하였으며, 이들은 정신건강 서비스의 미래를 함께 만들어가고 OD를 현장에서 구현하고자 하는 희망을 공유하였다. 하위 주제로는 "소그룹 실습과 역할극을 통해 OD에 점진적으로 스며듦," "안전한 공간과 연대감이 형성됨," "향후 OD 실천에 대한 희망을 가짐"가 도출되었다.

하위 주제 1 : 소그룹 실습과 역할극을 통해 OD에 점진적으로 스며듦

하위 주제 1은 워크숍에서 진행된 소그룹 실습과 역할극을 통해 참여자들이 OD에 자연스럽게 스며드는 과정을 설명한다. 다수의 참여자들은 이러한 활동이 OD 워크숍에서 가장 만족스러운 부분으로 평가하며, 실제 네트워크 모임에 참여하는듯한 느낌을 받았다고 응답하였다(P13, 23). 한 참여자는 "실습과 역할극을 통해 이론적으로 받아들이기 어려웠던OD의 중요성을 몸소 깨닫게 되었다"고 언급하였다(P17).

· 무조건적인 경청과 응답을 경험하며 치유받음

소그룹 실습과 역할극을 통해 참여자들은 자신의 이야기를 온전히 공유하고 응답을 받는 기회를 가졌으며, 무조건적인 경청을 경험하게 하였다. 다수의 참여자들이 이를 치유적인 경험으로 평가하였다(P8, 9, 10, 16, 17, 18, 20). 한 정신과 의사는 다음과 같이 워크숍 경험을 요약하였다.

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

"정신건강 전문가들이 가장 깊은 이야기를 공유하고 공감을 경험할 기회가 거의 없는데, 이 워크숍은 안전한 공간에서 치유의 경험을 제공하였다. 이 경험은 우리가 당사자의 이야기를 듣는 데 도움을 줄 것이다" (P20).

당사자 지원가였던 한 참여자(P9)는 자신의 정신과 진료 경험과 워크숍에서의 경험을 비교하며 다음과 같이 응답하였다.

"진료를 받을 때는... 뒤에 대기하는 사람이 많아서 충분히 이야기를 나누지 못했고,... (힘든 상황을) 말하면 약 용량을 높일까 봐 말 안 하기도 했고... (워크숍) 둘째 날부터 생각이 많아지고 울기도 했지만 나의 속마음을 털어놓고 공감도 받고, 다른 사람들의 이야기를 들어주고 그런 과정들이 너무 좋았습니다."(P9)

· 반영 실습을 통해 다양한 관점의 필요성을 인식함

참여자들은 반영 실습을 통해 네트워크 모임에서 다양한 관점의 가치가 필요함을 인식하였다(P6, 8, 14, 15, 21, 22). 한 참여자는 "반영 경험을 통해 내면의 다양한 목소리가 공명하는 것을 경험할 수 있었다" (P22)고 말하였으며, 또 다른 참여자는 "굳어 있던 생각을 환기시키고 정리할 수 있었다" (P14)고 평가하였다. 일부 참여자는 이러한 실습이 당사자를 보다 다각적으로 이해하는 데 큰 도움이 되었다고 언급하였다(P6). 한 참여자(P8)는 "반영이 염려의 중심에 있는 사람과 네트워크 구성원 모두에게 특별한 에너지를 불어넣는 강력한 도구임을 깨달았다"고 언급하였다.

· 다양한 역할을 경험하며 서로를 이해함

워크숍에서의 역할극은 참여자들에게 다양한 역할을 체험할 기회를 제공하며 타인을 더 깊이 이해하도록 도왔다. 정신병적 증상을 경험하는 자신의 아들 역할을 맡은 한 가족 활동가는 다음과 같은 소감을 밝혔다.

"역할극을 통해 서로 연결될 때 우리가 상대방 입장에서 생각할 수 있음을 깨달았고, 우리의 영혼이 수정구슬처럼 맑고 투명하다는 것을 오래오래 생각하게 되었다"(P3).

정신건강 전문가로 참여한 이들은(P21, 22) 역할극이 당사자를 이해하는 데 유익했다고 평가하였으며, 당사자 지원가(P9, 14)는 전문가 역할을 맡아보는 것이 매우 의미 있는 경험이었다고 응답하였다.

하위 주제 2 : 안전한 공간과 연대감이 형성됨

하위 주제 2는 초기에 불편했던 양가감정을 희망으로 전환하는 데 중요한 역할을 한 안전한 공간의 조성 과정을 다룬다. 경험적 학습을 통해, 참여자들은 서로의 목소리를 존중하고 경청하는 법을 배웠으며, 의견 차이를 논쟁이나 설득이 아닌 대화의 다양성으로 받아들이게 되었다. 이러한 과정은 내면의 양가감정과 외부의 갈등을 다성(polyphony)으로 전환시켜, 감정과 의견의 활발한 교류를 통해 연대감을 형성하는 계기가 되었다.

· 위계질서가 용해되고 자발성이 발현됨

짧은 워크숍 기간에도 불구하고, 참여자들은 내면의 중요한 변화를 경험하며 함께 안전한 공간을 구축하였다.

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

초기에는 참여자들 간 보이지 않는 위계로 인해 목소리의 불균형이 존재하였으나, 워크숍 진행됨에 따라 이러한 위계가 점차 해소되었다. 참여자들은 "누구나 계급장을 떼고", "편견 없이 대화를 누릴 수 있는 안정감"을 느꼈다 (P10, 16). 안전한 공간이 마련된 후, "참여자들 사이의 대화가 활발해지고 그들의 능동적인 자발성이 발휘되었다" (P24).

다음 인용문은 위계가 허물어지고 안전한 공간이 형성되는 과정을 잘 보여준다.

"참여자 중 가장 나이가 어리고 정신과 임상 경험이 전무한 참여자가 날이 갈수록 긴장을 풀고, 자기 개방을 하고, 눈치 보지 않고 자신의 의견을 피력했다. 다른 참여자들이 그녀에게 열렬한 호응을 하는 모습에 감동마저 느껴졌다."(P2)

· 내면의 양가감정과 외부의 다양한 관점이 폴리포니로 전환됨

안전한 공간이 조성된 이후, 참여자들은 자신들의 다양한 관점과 의견을 자유롭게 공유하기 시작하였다. 내면의 양가감정은 더 이상 불편한 것이 아니었으며, "자신의 욕구를 인식하게 되는 기회" (P19) 였고 사고방식을 전환하는 기회로 작용하였다(P6). 참여자들의 목소리는 이제 설득이나 합의의 도구가 아니라 서로 다른 관점을 존중하며 다성적 대화를 만들어가는 기반이 되었다. 참여자들은 서로 다른 기관의 전문가, 당사자, 가족들이 나누는 다채로운 대화는 워크숍을 풍부하고 밀도 있게 만들었다고 평가하였다(P2, 6, 11, 12, 17, 21, 22). 다음 인용문은 다양한 참여자들의 목소리가 내부와 외부의 폴리포니를 형성하는 과정을 보여준다.

"진정한 폴리포니였다. 특히 토론 시간에 OD에 대한 회의적인 관점도 함께 들을 수 있어서 상당히 좋았다. 누군가는 내가 이전에 고민했던 내용을 질문해주기도 하고, 내가 전혀 생각하지 못했던 우려를 공유하기도 했다. 워크숍 이전에 헷갈리고 복잡하던 내 마음이 정리되는 것 같기도 했다."(P22)

· 연대감이 형성됨

안전한 공간에서 자유롭게 의견과 감정을 교류한 경험은 참여자들 간 강한 유대감을 형성하였으며(P20), 서로를 위로하고 지지하는 계기가 되었다(P13, 21, 23). 한 참여자는 "사람이 희망" (P16)이라는 문구를 떠올렸고, 다른 이들은 새로운 패러다임을 함께할 "동료가 생겼다"고 표현했다 (P19, 22). 많은 참여자들은 한국에서 OD의 가치를 확보하고 실천하는 과정에서 예상되는 어려움에도 불구하고, "함께함의 가치" (P16)를 믿으며, "집단과 과정의 힘을 믿어보겠다"는 다짐을 하였다(P2). 이와 같은 다짐은 워크숍 이후에도 지속적인 연대를 약속하는 강한 의지로 이어졌다.

하위 주제 3 : 향후 OD 실천에 대한 희망을 가짐

하위 주제 3은 워크숍 이후 OD를 어떻게 실천할지 적극적으로 계획하는 참여자들의 모습을 담고 있다. 워크숍 마지막 날, 참여자들은 미래 계획 수립에 집중하였으며 한 참여자는 이 과정에서 참여자들의 높은 적극성과 주도성을 목격했다고 언급하였다(P24). 참여자들은 OD 촉진자로서의 역할과 OD의 가치를 재점검하며, 각자의 자리에서 OD를 실천하기 위한 구체적인 전략을 구상하였다. 또한, 워크숍에서 만난 다양한 동료들과 향후 교류를 지속하며 협업과 연대를 이어가기를 희망하였다.

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

· 삶의 방식으로서의OD를 이해하고 촉진자로서 자신의 가능성을 발견함

워크숍 초기, 참여자들은 OD를 당사자의 인권을 증진하기 위한 이상적인 기술로 인식하였고, 이를 완벽하게 구현해야 한다는 책임감과 부담감을 느꼈다. 그러나 워크숍이 진행되며, OD가 단순히 구현해야 하는 기술이 아니라 삶의 방식이라는 점을 깨닫게 되었다.

워크숍은 참여자들이 당사자에 대한 태도를 성찰할 기회를 제공하였다(P1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 25). 참여자들은 "당사자를 판단하고 평가하는 것이 그들의 회복에 도움이 되지 않는다"(P15)는 점을 인식하였으며, 단순히 경청하는 것만으로도 큰 도움이 될 수 있음을 깨닫게 되었다(P1, 25). 또한, 자신이 주변인과 진정성 있는 대화를 나누고 있는지 스스로에게 질문하며(P8), 그 동안 바쁜 나머지 잊고 지냈던 자신의 삶의 철학과 가치를 재확인하였다(P12). 이들은 OD를 "단순한 치료 기술 이상의 심오한 무엇"으로 인식하게 되었다(P22).

· 다양한 환경에서의 OD 실행과 서비스 간 협력을 기대함

워크숍을 통해 참여자들은 OD가 한국의 정신건강서비스 체계에서도 실행 가능하다는 희망을 품게 되었다(P9, 16). 워크숍 종료 후, 자신들의 직장에서 OD를 어떻게 구현할지 고민하기 시작하였으며(P2, 4, 8, 11, 16, 17, 24), 한국적 맥락에서 이를 실천하기 위한 방법을 구체적으로 구상해보았다. 한국의 정신건강 서비스 체계는 구조적으로 분절 되어있는 상황에서 참여자들은 동일 지역 내 의료기관과 지역사회 정신건강센터 종사자들이 함께 모여 교류한 경험 자체가 큰 성과라고 여겼다(P4, 22).

또한, 워크숍에 참여한 정신의료기관과 지역사회 서비스 기관 간의 협력을 통해, 당사자를 중심으로 서비스가 연동되는 OD의 철학이 구현될 것이라는 기대감을 표출하였다(P24). 이러한 목표를 달성하기 위해, 워크숍 종료 후에도 정기적인 협의체나 모임을 통해 지속적으로 교류하고 상호 연결을 유지할 것을 희망하였다(P4).

제 3주제.

다양한 환경에서 인권적 방식으로서의 OD 실천을 위해 고군분투함

제 3주제는 워크숍 참여자들이 각자의 직장에서 OD를 실천하기 위해 고군분투하는 과정을 다룬다. 참여자들은 다양한 방식으로 OD원칙을 적용하며 실천을 시도하였다. 열 명의 참여자는 촉진자로 구성된 팀의 일원으로 네트워크 모임에 참석하였고(P2, 7, 8, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24), 이들은 네트워크 모임 경험 그룹으로 분류되었다. 네트워크 모임 비경험 그룹의 참여자들 또한 정신과 병동(P2, 7, 15, 19, 20, 22), 낮병원(P5, 25), 지역사회 정신건강센터(P1, 12), 자살예방센터(P18, 21) 등에서 당사자, 가족, 전문가를 모아 대화적 접근을 시도하였다. 이들은 당사자와의 상호작용에 OD의 원칙과 요소를 일부 적용하였으며(P1, 3, 6, 7, 15, 18), 일부 참여자들은 OD 원칙과 요소를 당사자 및 가족 자조 모임에도 적용하였다(P3, 14). 모든 참여자는 월별 슈퍼비전에 초대되어 OD 실천 사례를 공유하였다. 하위 주제는 "당사자의 존엄성 회복을 목격함"과 "인권 증진 서비스로서의 OD를 목격함"으로 도출되었다.

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

하위 주제 1: 당사자의 존엄성 회복을 목격함

이 하위 주제는 참여자들이 다양한 환경에서 OD를 실천하며 당사자의 존엄성을 회복하기 위해 노력한 과정을 묘사한다. 참여자들은 당사자의 목소리를 존중하고 그들의 속도에 맞추어 그들의 삶의 여정을 가치있게 여기는 것이 OD 실천의 핵심임을 깨달았다.

· 주의 깊게 경청하고 목소리를 존중함

참여자들은 "당사자의 고통스러운 경험을 충분히 들어주고, 그들이 스스로 길을 선택하도록 돕는 것"(P2)이 중요하다는 점을 인식하였다. 이들은 한 사람의 삶을 경청하는 것이 OD의 핵심 가치라고 보았으며(P2, 3, 10), OD를 통해 억눌린 목소리를 여과 없이 경청하는 것이 당사자가 존중받는 느낌을 갖게 하는데 기여한다고 믿었다(P5, 18).

한 사람의 이야기에 오랜 시간 온전히 집중하는 것은 촉진자들에게 도전 과제였다(P8, 15, 17). 그러나 이들은 진정성 있는 경청이 대화를 이끄는 힘이 있다는 점을 깨닫고 이를 실천하기 위해 부단히 노력하였다. 예를 들어, 한 참여자(P2)는 한 문장을 말하는 데 10분 이상 걸린 당사자를 끝까지 경청한 사례를 회상하며, 이후 당사자가 위로를 받고 마음을 여는 모습을 목격했다고 언급하였다(P19). 또한, "네트워크 모임에서 당사자뿐 아니라 모든 참여자의 목소리를 존중하는 것이 치유의 장으로 이끄는 필수적인 요소"라는 점도 강조되었다(P15).

네트워크 모임에 참석하지 않았던 다른 참여자들도 자신이 속한 환경에서 주의 깊은 경청을 실천하려는 노력을 보였다. 보호병동에서 근무하는 한 참여자(P7)는 자해 행동을 보이는 당사자에게 처음에는 부정적인 감정이 들었지만, 병원에서 전문가와 가족이 함께 대화적 접근을 시도하면서 당사자의 행동 이면에 숨겨진 목소리를 듣으려는 노력을 기울였다고 표현했다. 대학병원의 낮병원에서 일하는 전문가들(P5, 25) 역시 위기의 당사자와 가족을 모아 그들의 어려움과 갈등을 경청하는 시간을 가졌다고 보고하였다.

한 가족 활동가(P3)는 다가족 자조모임의 운영 방식을 대화적 방식으로 전환하며, "가족들이 목소리를 내고 이를 경청받는 경험이 회복에 가까워지는 계기가 될 것"이라고 믿었다. 또한, 한 동료 지원가(P14)는 자조 모임을 진행하면서 "증상이 심한 당사자를 직면시키거나 모임에서 배제하는 대신, 그들의 목소리를 포함한 다양한 목소리를 존중하려고 노력했다."고 밝혔다.

· 당사자의 속도를 존중하며 불확실성을 수용함

참여자들은 당사자의 속도를 존중하고 불확실성을 수용하는 것이 OD의 핵심 가치임을 인식하였다. 그러나 이러한 속도를 맞추는 것은 특히 가족들이 불확실성을 수용하기 어려워할 때 도전 과제였다(P19). 가족들은 종종 대화보다는 해결책을 우선시하며, 전문가에게 신속한 결정을 요구하는 경우가 많았다(P2, 22). 한 참여자는 "전문가들도 해결책을 제공하는 역할에 익숙하기 때문에 기다리는 과정이 쉽지 않았다"며, 가족의 조급함과 좌절감에 공감한다고 기술했다(P5).

당사자의 느린 변화는 참여자들에게 "정신적 소진"을 가져다주기도 하였으며, 때로는 '증상이 악화되어 입원을 하는 것이 더 나은 해결책이 될 수 있다'는 고민이 들기도 하였다(P19). 하지만 네트워크 모임이 거듭될수록 참여자들과 당사자, 가족들 모두가

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

불확실성을 수용하는 데 익숙해지는 모습을 보였다(P17). 참여자들은 "OD의 가장 인상적인 점은 시간이 대상자를 중심으로 흐른다는 점"이라며, , 변화에는 기다림이 필요하고 "시간이 쌓여야 한다"(P15, 17, 22)는 것을 깨달았다.

한 병원 사회복지사는 초기에는 완벽한 계획과 실행이 변화를 위한 필수 조건이라고 믿었으나, 불확실성을 수용하는 원칙을 실천하면서 당사자의 다양성을 더 깊이 이해하고 수용할 수 있게 되었다고 밝혔다(P6). 자살예방센터에서 일하는 한 참여자(P18)는 당사자의 침묵을 기다리는 경험이 신뢰 관계로 이어졌던 사례를 공유하였다. 아래 인용문은 이에 대한 묘사이다. "발화량이 상당히 적어 면담하기 어려웠던 당사자에게 '지금 아무 말을 안 해도 괜찮아요. 이 시간을 그냥 같이 있어도 됩니다.' 라고 말하며 그의 침묵을 두려워하지 않고 기다려주었다. 그 이후로는 서로 신뢰가 생긴 느낌이었다." (P18)

하위 주제 2 : 인권 친화적인 역할로서 OD를 인식함

하위 주제 2는 참여자들이 당사자의 목소리를 주의 깊게 경청하고 그들의 속도를 존중하며 불확실성을 감내하는 과정을 통해, 당사자와 네트워크에 나타난 중요한 변화를 관찰한 내용을 다룬다. 이러한 경험을 통해 참여자들은 OD가 인권을 보호하고 증진하는 효과적인 수단임을 인식하였다. OD는 당사자가 자율성과 자기결정권을 회복하고 행사할 수 있도록 지원하며, 강압적 치료를 줄이는 데 기여하였다. 또한, 당사자가 지역사회 내에서 자신의 자리를 찾아갈 수 있도록 돕는 과정을 통해, 그들의 삶에 실질적인 변화를 이끌어냈다. 참여자들은 OD를 통해 당사자와 네트워크 구성원이 경험한 이러한 긍정적 변화를 관찰하며, 이를 인권 신장의 중요한 사례로 평가하였다.

· 당사자의 자율성과 자기결정권이 회복됨

OD를 실천하는 과정에서 참여자들은 전문가의 역할이 당사자의 자기결정권을 존중하고 이를 지원하는 데 있다는 점을 새롭게 인식하였다(P5, 7, 15, 20). 특히, "당사자가 모임의 시간, 장소, 참석 인원을 스스로 선택하도록 질문하는 것이 자율성과 자기결정권을 보장하는 첫 번째 열쇠"라고 평가하였다(P14). 실제로, 당사자와 네트워크 구성원은 모임 장소를 스스로 선택함으로써 더 큰 안정감을 느꼈다고 보고하였다(P7).

참여자들은 네트워크 모임을 거듭할수록 당사자가 점차 자율성을 회복하는 모습을 목격하였다(P17, 22). 예를 들어, 한 당사자는 정신과 약물 복용을 선택하지 않았음에도 불구하고 낮병원 프로그램에는 자발적으로 꾸준히 참여하였다(P2, 17, 19). 이러한 경험을 통해 참여자들은 "당사자와 가족의 필요를 반영하는 방식으로 치료 중단율을 감소시킬 수 있었다"고 인식하였다(P6).

OD 실천 이전, 참여자들은 당사자를 취약하고 수동적이며 선택권이 제한된 존재로 여기는 경향이 있었다(P4). 그러나 OD를 통해 당사자를 독립적이고 주체적인 존재로 재인식하게 되었다(P3, 7). 이들은 당사자가 자신의 삶을 능동적으로 형성할 수 있는 역량을 지니고 있음을 깨달았으며(P15), 모든 서비스가 상호 합의된 상태에서 제공될 수 있도록 대화적 방식을 구축하기 위해 노력하였다(P4).

당사자와 네트워크가 자율성과 자기결정권을 회복하는 경험은 참여자들에게 OD의 본질적 가치를 새롭게 깨닫게 하였다.

14 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 한국에서 Open Dialogue 도입

참여자들은 OD를 "당사자와 네트워크가 스스로의 욕구를 이해하고 선택하도록 돕는 회복 지향적 시스템"으로 인식하였으며(P4), OD가 "'당사자 중심적'이고 '당사자 관점을 현장에 반영할 수 있는 실질적인 경로"로 기능한다고 평가하였다(P21).

· 강압적 치료가 감소함

OD를 실천하면서, 참여자들은 OD가 강압적 치료를 줄이는 데 중요한 역할을 한다는 점을 목격하였다. 한 참여자는 여러 네트워크 모임에 참석하며 단지 모임만으로 위기를 해결한 사례를 목격하였다(P15). 기존의 정신건강 서비스 체계에서는 경찰에 의해 즉각적인 입원으로 이어질 상황이 OD를 통해 해결되었다(P4). 다음 인용문은 네트워크 모임을 통해 위기가 해결된 사례를 보여준다.

"한 당사자는 아랫집 이웃과 싸우기도 하고 노인 시체 냄새가 난다며 경찰도 부르고, 솔직히 네트워크 모임에 참여하지 않았다면 (얼마 가지 않아 경찰에게 의뢰되어) 응급입원하고도 남았다고 생각한다. 현재 OD 진행하는 분도 초반에는 밤마다 엄마에게 전화해서 엄마가 자신을 죽이러 올 것이라며 욕하고 했다. 하지만 강제적인 조치 없이 거의 1년이 지난 시점에 스스로 외래를 방문하고 이제는 낮병원도 다니고 있다." (P15)

이와 같은 사례를 통해, 참여자들은 OD가 기존 전통적 접근 방식이 당사자에게 신체적·심리적 상처를 초래할 가능성이 높은 반면, OD는 당사자의 본질적 가치를 훼손하지 않는 방식으로 작동한다고 확신하게 되었다(P13, 15, 17, 20, 21, 22, 24). 한 참여자는 OD를 "친절하고 다정한 접근"으로 정의하며 이를 긍정적으로 평가하였다(P2).

네트워크 모임의 촉진자로 참여하지 않았던 다른 참여자들 또한 자신의 직장에서 OD의 가치를 실천하며, OD가 당사자와 가족들에게 보다 인권 친화적인 접근법임을 확인하였다. 한 지역사회 정신건강센터의 참여자(P12)는 정신과적 응급 상황에서 새로운 방식을 시도하였다. 전통적으로 한국에서는 지역정신건강센터 위기 개입팀과 경찰이 함께 비자의적 응급 입원을 의뢰하는 방식이 보편적이었다. 그러나 이 참여자는 입원 전에 당사자의 가족, 경찰, 지역사회 센터의 정신건강 전문 요원을 함께 모아 대화적 접근 방식을 시도하였다. 그 결과, 당사자는 자발적으로 외래 진료를 방문하고 스스로 입원을 결정하였다. 이 과정을 회고하며 참여자는 "평소보다 세 배의 시간이 걸리는 어려운 과정이었지만, 인권 중심의 입원 과정을 경험하였고 전문가로서의 역할을 다시 생각하게 된 계기"라고 평가하였다.

대학병원 낮병원의 전문가들(P5, 25) 역시 가족-당사자 대화 모임을 개최한 후 입원이 연기되는 사례를 경험하였다. 이들은 "당사자가 가족과 작은 소통만 되어도 강제 입원을 예방할 수 있음"을 깨달았다(P25). 급성 정신과 병동에서 근무하는 한 간호사(P7)는 과거 도전적 행동을 보이는 환자들에게 강압적인 주사나 격리 조치를 사용했던 반면, 이제는 환자의 행동 이면에 숨겨진 심리적 요인을 이해하기 위해 대화를 우선적으로 시도한다고 밝혔다.

이와 같은 경험들은 참여자들에게 깊은 울림을 주었으며, 강제 치료로 인해 당사자가 평생 지속될 심리적 트라우마를 겪는 모습을 자주 목격했던 과거의 경험과 연결되었다(P15). 참여자들은 OD를 "힘을 잃은 사람들에게 말할 수 있는 기회"(P2)로 인식하였으며, "강제 입원을 줄이기 위한 최선의 선택"(P20)이라고 평가하였다.

· 네트워크와 협력이 촉진되고 지역사회로 통합됨

OD 접근 방식을 통해 당사자와 가족 간의 협력과 소통이 증진되고, 당사자가 지역사회에 점차 통합되는 모습을 목격한 참여자들은 OD를 "위기 상황의 당사자를 무조건 입원시키지 않고도 사회 구성원으로서 살아갈 수 있도록 돕는 안전하고 실용적인 방법"으로 인식하였다(P2, 6).

네트워크 모임 경험을 통해 참여자들은 당사자와 네트워크가 대화를 통해 서로의 생각과 관점을 알아가는 과정이 변화의 중요한 촉매임을 깨달았다(P9, 16). 특히, "다수의 네트워크 구성원이 서로를 지지하고 공감할 때 당사자의 회복에 큰 도움이 된다"는 점이 강조되었다(P15).

네트워크 모임 이후, 가족들은 촉진자의 대화 방식을 모델로 삼아 당사자의 고통과 슬픔을 이해하고 경청하면서 가족 내 소통을 증진시켰다(P22). 이러한 과정은 가족들이 당사자를 대하는 태도와 말투를 변화시키며, 서로를 기다리고 이해하는 마음을 갖게 하는 계기를 마련하였다(P15). 뿐만 아니라, 가족들은 자신을 돌보는 데에도 더 많은 관심을 기울이기 시작했다. 예를 들어, 가족들은 자발적으로 정신건강의학과에 방문해 자신의 심리적 상태를 돌보려는 노력을 보였다(P2).

이와 같은 변화는 당사자가 지역사회에 포함되고 적극적으로 참여하는 결과로 이어졌다. 외출을 꺼리던 당사자가 가족과 함께 미술관을 방문하거나(P15), 낮병원에 꾸준히 참석해 동료들과 대화하거나, 취업에 성공하거나(P2), 학교로 복학하는 모습을 보였다(P25).

제 4주제

OD 실천을 위한 도전 과제와 보완 방안을 모색함

OD를 각자의 직업적 환경에서 적용하면서, 참여자들은 개인적, 조직적, 정책적 수준에서 마주한 도전 과제를 검토하고 이를 극복하기 위한 실질적인 해결책을 모색하였다. 제 1주제가 참여자들이 자신들의 통제 밖에 있는 거시적인 도전 과제에 집중했던 것과 달리, 제 4주제에서는 국내 OD 실천을 위한 구체적이고 실현 가능한 보완 방안을 탐구하려는 참여자들의 의지가 점차 강화되고 있음을 보여준다. 이는 OD가 단순한 이론적 논의를 넘어 현장에서 인권적 실천으로 자리잡기 위한 구체적인 전략과 방안을 제시하는 단계로 나아가고 있음을 시사한다. 하위 주제는 "개인적", "조직적", "정책적 관점"으로 도출되었다.

3.3.4.1 하위 주제 1 : 개인적 관점

이 하위 주제는 OD 실천 과정에서 참여자들이 겪은 개인적인 도전과제와 이를 극복하기 위한 보완 방안을 다룬다. 참여자들은 OD 개념과 원칙을 이해하고 이를 실천과 연결하는 데 혼란을 경험한 바 있다. 이러한 혼란을 극복하기 위해, 참여자들은 자기 성찰을 통해 촉진자로서의 태도를 점검하고, 팀원 간의 연결성을 유지하며, 반영적 슈퍼비전에의 참여하는 것이 중요하다고 강조하였다.

· OD 이해와 적용에서 혼란을 겪음

참여자들은 OD를 이해하고 적용하는 과정에서 혼란을 느꼈다. 일부 참여자들은 OD를 통해서 내면에 다양한 목소리가 생기며 혼란을 경험했다고 토로했으며, OD의 철학이 당사자를 병원 입원이나 약물 복용으로 이끄는 부드러운 방식에 불과할 수도 있다는 우려를 표현하기도 했다(P2, 17). 동료 지원가 모임에서 OD 경험이 없는 이들에게 OD의 의미를 전달하고 경청을 실천하는 것도 도전 과제였다(P3, 14). 한 참여자는 OD가 매뉴얼화된 이론으로 제시되지 않아 주관적으로 해석될 가능성이 있고, 이로 인해 혼란을 초래할 수 있다고 언급하였다(P3).

· 촉진자의 자기 성찰

참여자들은 이러한 혼란을 극복하기 위해 촉진자로서의 역할에 대해 개인의 성찰과 마음 챙김의 중요성을 강조하였다(P2, 8, 16).

· 팀원과의 연결성 유지와 반영적 슈퍼비전의 지속

참여자들은 OD를 실천하는 데 있어 슈퍼비전의 중요성을 강조하였다(P2, 3, 6, 14, 15, 16). 지속적인 슈퍼비전은 아이디어 교환과 개인적 성장을 보장하며(P14, 15, 16), 반영적 작업이 없는 네트워크 모임이 "영리 목적의 시간 때우기 프로그램"으로 전락할 위험이 있음을 언급하였다(P2).

효과적인 촉진자팀의 팀워크 또한 중요한 요소로 언급되었으며, 정기적인 모임은 팀원 간의 관계를 강화하는 데 기여할 것이라고 언급하였다(P6). 참여자들은 또한 OD를 실천하면서 겪는 혼란을 팀원들과 공유하고 이를 해석하는 과정을 통해 학습과 성찰이 가능해진다고 강조하였다(P2, 3).

3.3.4.2 하위 주제 2 : 조직적 관점

이 하위 주제는 OD 실천에서 조직적 차원에서의 도전 과제와 이를 극복하기 위한 보완 방안을 다룬다. 의료기관 내에서 OD를 적용하려는 시도는 수직적인 의사소통 방식과 기존 의료 모델 중심의 문화로 인해 도전적인 과제로 인식되었다. 이러한 도전을 극복하기 위해서는 기관 내에서 수용적이고 협력적인 문화를 조성하는 것이 필요하다는 점이 강조되었다.

· 위계적인 조직 문화에서 OD 실행의 어려움

참여자들은 위계적인 의료 조직 내에서 네트워크 미팅을 조직하는 데 많은 어려움을 겪었다. 한 참여자(P22)는 본인이 소속된 병원이 치료 공동체의 원칙을 기반으로 설립되었음에도 불구하고, 환자의 증상 완화를 주요 목표로 하는 병원의 특성상 수직적 의사소통이 우선시될 수밖에 없다고 설명하였다. 첫 번째 네트워크 모임은 관리자에 의해 상향식(top-down) 방식으로 조직되었으며, 참여자들이 상사와 함께 촉진자로 활동할 때 동등한 입장에서 의견을 표현하는 데 어려움을 겪기도 하였다(P2, 22). 이러한 상황은 팀워크에 부정적인 영향을 미쳤으며, 미팅 중 불확실성을 감내하는 데도 장애 요인으로 작용하였다 (P22). 또한, 개선을 위한 제안이 종종 받아들여지지 않는 것처럼 여겨졌고, 당사자와 가족들로부터 새로운 접근법에 대한 저항과 담당 의료 인력에 대한 역할 혼란이 발생하여 네트워크 모임의 효과성이 저하되었다고 지적되었다(P2, 20, 22).

· 새로운 조직 문화 조성이 요구됨

여러 참여자들은 OD를 성공적으로 실행하기 위해서는 수용적이고 협력적인 조직 문화를 조성할 필요성을 강조하였다(P2, 5, 6, 18, 19, 22, 24). 이들은 "동료들과의 유대감을 느끼고 함께 성장하는 업무 환경"(P18), "회복 중심 관점을 수용하는 분위기"(P22), 그리고 "당사자와 지역사회를 연결하기 위한 기관의 노력이 이루어지는 문화"(P5)가 중요하다고 언급하였다.

3.3.4.3 하위 주제 3 : 제도적 관점

이 하위 주제는 OD 실천에서 참여자들이 직면한 정책적 및 제도적 도전 과제와 이를 극복하기 위한 보완 방안을 다룬다. 주요 쟁점으로는 헌신적인 시간 할애의 부담, 파편화된 정신건강 시스템 내에서 심리적 연속성 보장, 위기 개입 시 안전 및 법적 문제, 전문인력 양성, 그리고 제도적 지원의 필요성이 제기되었다.

· 시간 투자의 부담감

OD를 실천하기 위해 참여자들은 기존 업무를 유지하면서 추가적으로 시간을 할애해야 했고, 이는 초과 근무와 심리적 스트레스를 증가시켰다(P12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25). 네트워크 미팅에 참여한 참여자들은 "당사자의 집으로 이동하고 미팅을 진행하는 데 근무 시간의 절반을 사용해야 하는 현실"을 강조하며 이러한 시간이 큰 부담으로 작용했다고 언급하였다(P2, 15, 19, 20, 22).

· 심리적 연속성 확보의 어려움

한국의 파편화된 정신건강 체계는 OD 실천에서 심리적 연속성을 보장하는 데 큰 장애물로 작용하였다. 예를 들어, 네트워크 미팅이 진행 중에 당사자가 갑작스럽게 입원하면서 병원과의 협력 부재로 인해 미팅이 중단되는 일이 있었다(P22, 24). 이러한 경험은 "입원부터 퇴원까지 환자를 연계할 수 있는 시스템 구축"의 필요성을 강조하게 되었다(P6, 25).

· 위기 개입 시 안전 및 법적 문제

참여자들은 정신과 응급 상황에서 OD를 적용할 때 안전성과 법적 보호장치의 부재에 대한 우려를 나타냈다(P1, 7, 20). 자살 위기 상황에서 OD가 탄력적으로 수용될 수 있는지에 대한 의문과(P21), 위기 상황에서 촉진자의 역할에 대한 고민이 있었다(P14).

· 교육 프로그램의 필요성

OD를 한국에 성공적으로 도입하기 위해 전문인력 교육의 필요성이 강조되었다(P3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 25). 참여자들은 OD 중심으로 운영과 교육을 담당할 전문 조직이 필요하며, 이 조직을 통해 수준 높은 교육과 훈련이 제공되어야 한다고 제안하였다(P4, 9, 20).

· 정책적 및 제도적 지원

참여자들은 OD 도입과 실행을 위해 제도적 지원과 공급망 구축이 필요하다고 강조하였다(P3, 7, 15, 19, 20, 21, 22, 24). 정책적으로는 교육과 슈퍼비전을 기본 업무에 통합할 수 있는 지원이 필요하며(P24), 회복 관점을 촉진하기 위한 재정 지원과

실천 지침 마련이 요구되었다(P3, 20, 22, 24). 또한, 인력 확보를 위한 추가 수당 지급(P7, 15), OD의 특성을 반영한 질적 평가 방법, 그리고 위기 상황에서 촉진자를 보호하기 위한 법적 보호 장치도 필요하다는 의견이 제시되었다(P20, 21).

4 논의

본 연구는 WHO QualityRights 프로젝트의 일환으로 진행된 5일간의 OD 입문 워크숍과 1년간의 OD시범 운영에 참가한 참여자들의 주관적 경험과 의견을 탐구하는 것을 목표로 하였다. 연구 결과, 참여자들은 초기에는 한국의 제도적, 문화적, 그리고 직업적 어려움으로 인해 OD에 대해 양가감정을 느끼며 주저와 의구심을 표출하였다. 그러나 동시에OD가 인권 회복에 기여할 가능성을 인식하고, 이를 구현해야 한다는 막중한 책임감을 느꼈다(제 1주제).

워크숍이 끝날 무렵, 참여자들의 양가감정은 희망으로 전환되었고, 이는 참여자들 간에 연대감을 형성하고 향후 OD 실천에 대한 긍정적인 전망을 키우는 계기가 되었다(제 2주제). 워크숍 이후 참여자들은 각자의 환경에서OD를 실천하며 당사자의 존엄성과 자율성을 회복하고 강압적 치료를 줄이며 지역사회 참여를 증가시키는 성과를 목격하였다(제3주제). 또한, 개인적, 조직적, 정책적 차원에서의 과제를 인식하고 이를 해결하기 위한 방안을 모색하였다(제 4주제). 이러한 결과는 한국의 정신건강 체계에서 OD의 공식적인 교육 프로그램 및 실행 지침을 개발하기 위한 기초 자료를 제공한다.

양적 분석은 두 가지 방법을 통해 수행되었다. 전체 참여자를 대상으로 한 대응 표본 t-검정과 네트워크 미팅 경험에 기반한 혼합 ANOVA이다. 대응 표본 t-검정 결과, OD의 7가지 핵심 원칙 중 “유연성과 이동성(Flexibility and Mobility)”의 적용 가능성 점수만이 시간 경과에 따라 유의미하게 감소한 것으로 나타났다. 이는 한국의 정신건강 시스템이 분절화되고 공급자 중심으로 운영되는 구조적 한계를 반영하며, 당사자의 개별적인 요구를 충족시키기 위해 필요한 유연성을 제한했을 가능성을 시사한다. 또한, 네트워크 미팅에 참여한 참여자들이 당사자의 집으로 이동하고 모임을 진행하는 데 소요되는 시간과 노력으로 인해 부담을 느꼈다는 점(Main Theme 4, Subtheme 3: 시간 투자의 부담)도 영향을 미쳤을 수 있다.

혼합 ANOVA 결과, 1년간 네트워크 모임에 참여한 그룹에서 "불확실성의 수용(Tolerance of Uncertainty)"의 적용 가능성이 통계적으로 유의미하게 감소한 것으로 나타났다. 불확실성 수용은 OD의 핵심 원칙 중 하나이나, 참여자들은 이를 지속적으로 유지하는 데 상당한 어려움을 겪었다(제3주제, 하위 주제1). 신속한 결론 도출, 전통적 중재 방식, 가설 및 평가 도구의 사용 등은 불확실성을 수용을 방해하고 치료적 장(therapeutic context or “scene”)을 통해 구축되는 신뢰를 방해하는 요인으로 작용한다(Seikkula & Olson, 2003). 본 연구의 참여자들이 주로 전통적 관행에 의존하는 기관에 고용되어 있어 이러한 노력이 더욱 어려웠을 가능성이 있다. 이는 OD를 기존 치료 방식(TAU) 환경에서 도입할 때 발생하는 어려움을 지적한 선행 연구(Anestis et al., 2024)와도 일치한다. 불확실성을 효과적으로 수용하려면 팀워크와 슈퍼비전이 필수적이며, 이를 통해 언어적·신체적 조율과 관계 유지가 가능해진다(Lagogianni et al., 2023). 이러한 내용은 본 연구의 제4주제와도 맥을 같이 한다. 한편, “대화주의(Dialogism)”는 중요성, 적용 가능성, 즉각적 적용 가능성을 평가한 두 시점에서 모두 가장 높은 점수를 기록하였다. 이는 참여자들이 입문 워크숍과 1년간의 시범운영을 통해, 단어 그대로의 ‘열린 대화’ 그 자체를 실제로 경험했음을 시사한다.

다음 파트에서는 본 연구의 질적 결과를 1) 교육, 2) 실행, 2) 팀 및 정책 이라는 세 가지 주요 영역으로 나누어 논의점과 시사점을 검토하고자 한다.

4-1. OD 교육에 대한 논의

본 연구의 참여자들은 OD 입문 워크숍 초기, OD 도입의 주저와 의구심을 표출하며, 다양한 도전 과제를 예상하였다. 이러한 태도는 OD를 처음 도입한 국가에서 전문가들이 보인 반응과 유사하다. OD의 도입 과정에서 조직적, 직업적, 개인적 저항이 발생할 수 있으며, 이는 OD의 수용과 실행 과정에서 주요한 도전 과제가 될 수 있음이 보고된 바 있다(Weber & Johansen, 2007; Sønderggaard, 2010). 예를 들어, 영국에서는 OD 도입 전 NHS 소속 전문가들을 대상으로 한 설문조사에서는 OD가 급진적인 변화로 인식되어 저항이 나타났으며 전문가들은 역할 변화에 대한 우려를 표현했다(Razzaque & Wood, 2015) 또한 다른 도입 국가의 전문가들도 무능력함과 비판에 대한 불안(Skourteli et al., 2023), 그리고 임상적·조직적 저항에 대한 지속적인 관리 필요성(Lennon et al., 2023)을 보고한 것으로 나타났다.

본 연구에서 새롭게 확인된 점은, 전문가들이 OD를 처음 접했을 때 단순한 저항만이 아니라 양가감정을 느꼈다는 것이다. 이러한 양가감정은 호주의 민간 의료기관에서도 확인된 바 있으며, OD 교육 및 실행 과정에서 전문가들이 낙관적이면서도 회의적인 태도를 동시에 보였음이 보고되었다(Dawson et al., 2021).

양가감정(attitudinal ambivalence)은 동일한 대상에 대해 긍정적·부정적 감정이 충돌하는 상태를 의미하며(Jonas & Ziegler, 2007), 이는 불편한 감정으로 인식되어 사람들이 상반된 평가 간의 갈등을 해결하기 위해 적극적으로 노력하게 만든다(Newby-Clark et al., 2002). 따라서 OD 도입과 교육 과정에서 양가감정을 다루는 것은 필수적이겠다.

또한 본 연구는 참여자들이 느낀 막중한 책임감도 원활한 OD 교육을 위해 반드시 다뤄야 할 중요한 요인임을 제시한다. 참여자들은 OD를 당사자의 인권을 증진할 이상적인 방법으로 인식했지만, 이를 완벽히 구현해야 한다는 의무감으로 인해 상당한 부담을 느꼈다. Stockmann et al. (2019) 은 다기관 ODDESSI 연구에서 일부 OD 교육생들이 “기술적 접근을 우선시하는 시스템” 내에서 OD를 실천하기 어려움을 보고하며, OD를 숙달해야 할 기술로 간주하는 것이 전문가들에게 부담이 될 수 있고 OD 실천을 저해하는 요인이 될 수 있음을 시사한다.

정신질환에 대한 심리역동적 관점에서는 이러한 현상을 무의식적 과정으로 설명하며, 이는 전문가와 당사자 간 권력 불균형에서 기인한다. 전문가들은 “항상 건강하고, 박식하며, 친절하고, 강력하고, 적극적”인 역할을 맡는 반면, 당사자는 “항상 병들고, 고통받으며, 무지하고, 수동적이고, 순종적이며, 감사해야 하는” 역할을 맡게 된다(Hinshelwood, 2004). OD에서 강조되는 ‘아니알기 자세(not-knowing stance)’는 이러한 역할 분담에 상충하며, 이는 전문가들에게 “취약함을 수용할 용기” (Lorenz-Artz et al., 2023)를 요구한다. 이러한 과정은 전문가들에게 부담으로 작용하거나 OD를 단순한 치료 기법으로 간주하게 만들며, 이를 완벽히 숙달해야 한다는 압박감을 느끼게 할 수 있다.

이러한 실천적 부담감을 해소하기 위해서는 OD를 단순한 치료 기법이 아닌 "삶의 방식"으로 경험하도록 교육 과정을 설계하는 것이 중요하다. OD가 "치료 기법"인지 "삶의 방식"인지에 대한 논의는 이전부터 지속되는 이슈이나(Ong et al., 2019), Seikkula(2011)는 대화주의를 의사소통을 통해 학습된 "삶의 방식"으로 묘사하며, 단순히 듣고, 반응하며, 응답을 주고받는 과정 자체가 치유적일 수 있으며, 이는 유아기부터 체화된 본질적 요소로 설명한다. 워크숍에서 이러한 본질적 요소를 다시 경험한 것이 참여자들이 OD를 삶의 방식으로 받아들이고, 실천에 대한 자신감을 갖게 된 데 기여했을 것으로 보인다.

본 연구는 양가감정과 막중한 책임감을 희망으로 전환시키기 위해 고려해야 할 두 가지 중요한 요인을 확인하였다. 이는 교육 내용과 교육 과정의 체계적 구성을 통해 실현될 수 있으며, 다음 항목에서 이를 구체적으로 다룰 것이다.

4-1-1. 교육 내용 및 과정

본 연구는 5일간의 단기 워크숍으로 진행되었음에도, 그 결과는 장기 교육 과정에서 참여자들이 경험한 내용과 여러 측면에서 유사한 양상을 보였다. 예를 들어, 3년간의 OD 교육 과정에 참여한 이들은 신뢰를 바탕으로 한 분위기 속에서 의미, 언어, 그리고 관계를 공동으로 생성(co-production)하는 변화를 경험하였으며, 이를 예상치 못한 치유적 경험으로 묘사하였다(Runciman, 2021). 또한, 1년간의 기초 교육에서는 실습과 역할극을 통해 자신의 이야기를 경청 받고 응답 받는 경험이 강조되었고, 이를 통해 위기 상황에 처한 당사자와 네트워크 구성원의 감정을 이해하는 통찰을 얻었다고 보고되었다(Aderhold and Hohn, 2021; Hendry et al., 2021). 호주에서 진행된 4일간의 단기 입문 교육에서도 참여자들은 짧은 기간에도 불구하고 대화적 실천에 적응하며 내면적 통찰(inner knowing)을 경험한 것으로 나타났다(Thorley et al., 2023).

이러한 선행 연구와의 비교를 통해 본 연구는 OD 단기 워크숍의 잠재적 효과를 극대화하기 위해 OD 원칙이나 이론의 단순한 전달보다는 경험적 학습, 삶의 방식으로서의 OD, 그리고 OD의 본질과 과정을 "몸으로 체득하는 것(bodily knowing of OD)"(Shotter, 2007)에 중점을 두어야 함을 시사한다. 본 연구의 참여자들은 경험적 학습을 통해 점차 대화적 실천에 익숙해졌으며, 초기의 양가감정을 극복해야 할 문제로 인식하지 않게 되었다. 이들은 상이한 의견을 설득하거나 합의하려는 태도에서 벗어나, 다성주의(polyphony) 속에서 자연스럽게 공존하는 법을 익혔다.

비록 본 연구에서 직접적으로 확인된 바는 아니지만, 이러한 변화는 트레이너가 다양한 목소리를 위한 안전한 대화적 공간을 조성하고 다성주의를 장려한 결과일 가능성이 크다. 참여자들이 트레이너의 역할에 대해 구체적으로 언급하지는 않았으나, 이는 트레이너가 대화적 공간에서 자연스럽게 지지와 용기를 제공하는 존재(container)로서 대화적 문화를 촉진했음을 시사한다(Thorley et al., 2023). 이러한 자연스러운 과정은 참여자들에게 자율적으로 학습하고 있다는 느낌을 주었을 가능성도 있다. 또한, OD 교육을 구성할 때 OD 원칙에 대한 이론적 설명보다는 경험적 학습을 우선적으로 고려하는 방식이 OD를 삶의 방식으로 이해하는 데 효과적일 수 있다. 한 질적 연구에서는 OD를 처음 접하는 참여자들에게 OD 원칙을 이론적으로 설명하기보다는 네트워크 모임에 직접 참여하게 하는 것이 OD를 가장 본질적으로 이해할 수 있는 방법이라고 제안하였다(Lorenz-Artz et al., 2023). 이는 OD의 핵심 원칙과 대화적 실천이 체화된 경험을 통해 보다 깊이 이해될 수 있음을 보여준다.

4-1-2 혼합 그룹 구성의 강점

본 연구에서 워크숍은 OD가 도입될 지역 내 다양한 지역사회 기관과 의료기관에 소속된 전문가, 동료 지원가, 가족들을 한자리에 모아 교육을 진행하였다. 이러한 혼합 그룹 구성은 WHO QualityRights 교육 도구(World Health Organization, 2019)의 권장 사항을 반영하여 설계되었으며, 전문가와 당사자 등 다양한 배경의 참여자들로 그룹을 구성할 것을 강조한다. 더불어, 이 구성은 OD 네트워크 모임의 다성적(polyphonic) 특성을 반영한다는 점에서 중요한 의의를 가진다.

참여자들은 워크숍을 통해 다양한 배경을 가진 이들과 다채로운 대화를 나누며 연대감을 느꼈다고 보고하였다. 이러한 경험은 기존 선행 연구에서도 확인된 바 있다. 영국에서 진행된 3년간의 OD 교육 과정에서는 교육 그룹 자체가 상호작용적인 방식으로 의견 차이를 수용하고, 토론 과정에서 발생한 내부 긴장과 감정적 어려움을 극복하며 상호 학습하는 경험을 제공한 것으로 나타났다(Wates et al., 2022). 또한, 호주에서 진행된 OD 교육에서는 참여자들이 서로 강한 연결감을 느끼며, 집단적 학습 과정을 통해 새로운 통찰을 얻었다고 보고되었다(Buus et al., 2022). 유사하게, 영국에서 진행된 동료지원 오픈다이얼로그(Peer-supported Open Dialogue, POD) 교육에서는 참여자들이 타인과의 정서적 연결을 통해 유의미한 경험을 했다고 평가하였다(Stockmann et al., 2019).

따라서, OD 교육을 계획하고 조직할 때 OD가 도입될 지역 내 지역사회 조직 및 의료기관의 전문가, 당사자 지원가, 가족을 포함하는 혼합 그룹 구성을 고려하는 것이 중요하다. 이러한 구성은 향후 OD 실천에 대한 연대감과 희망을 고취하는 효과적인 방안으로 제안될 수 있다.

특히, 본 연구 참여자들의 설문 응답에서 “희망”이라는 단어가 반복적으로 등장한 점은 주목할 만하다. 이는 희망이 단순한 개인적 감정의 차원을 넘어, 공유된 실천(shared practice)과 언어의 한 형태로 작용할 수 있음을 시사한다(Cuffari et al., 2022). 이러한 집단적 희망은 참여자들이 새로운 접근 방식을 수용하고 실천하도록 동기를 부여하는 데 중요한 역할을 했다.
마지막으로, 본 연구는 그림 1을 통해 앞서 논의한 참여자들의 변화를 시각적으로 제시한다.

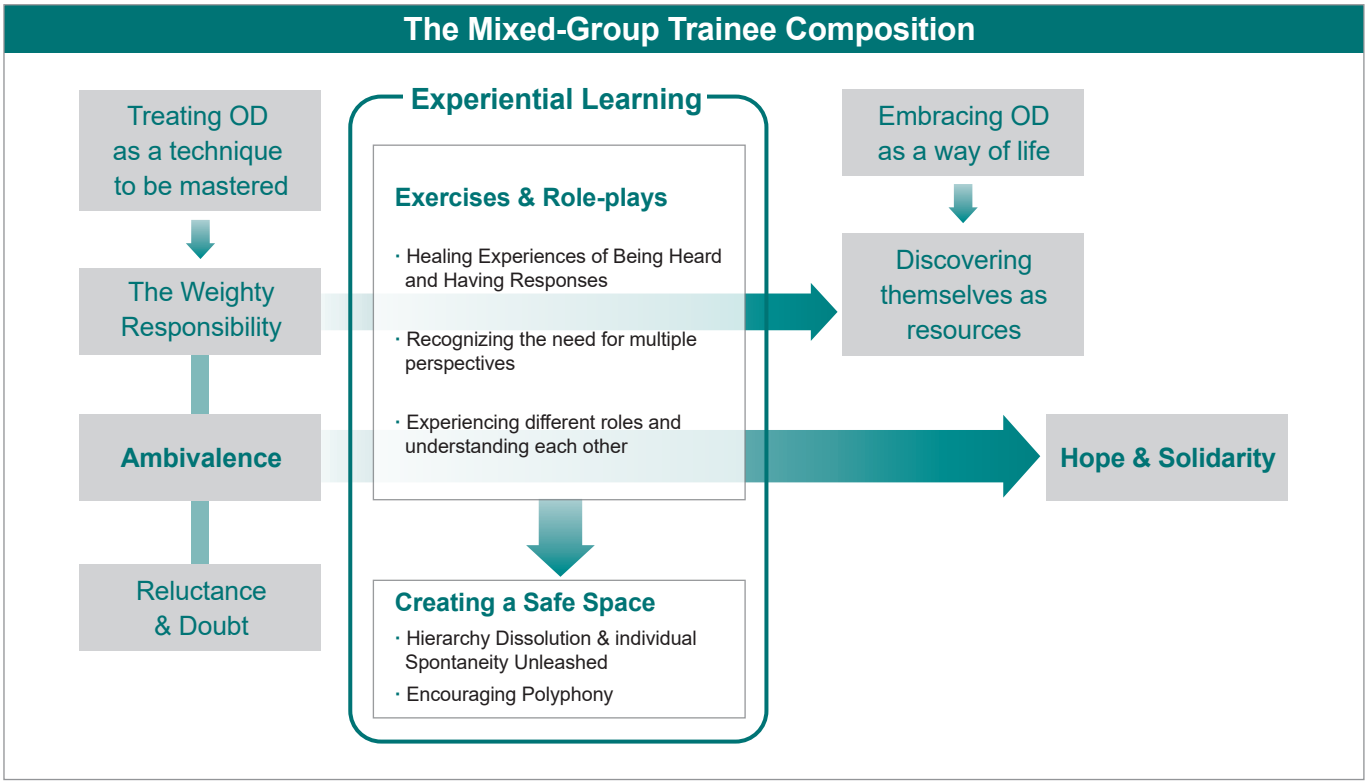


Figure 1. The process of change from ambivalence to hope and solidarity during the OD workshop.

4-2. 인권 친화적 접근으로서의 OD 실행에 대한 논의

제3주제의 의미를 정립하기 위해, 인권적 관점을 채택하여 논의를 전개하고자 한다. 정신건강 분야에서 인권은 전 세계적으로 중요한 이슈로 여겨지지만, OD와 인권 원칙 간의 직접적인 관련성을 탐구한 연구는 제한적이다. Von Peter et al. (2019)는 OD를 인권에 부합하는 접근 방식으로 간주할 것을 제안하였으며, 이는 WHO QualityRights의 기반이 되는 장애인권리협약(CRPD)의 여러 요소가 OD의 기본 원칙과 일치하기 때문이라고 주장하였다. 또한, WHO의 지침은 인권적 관점에서 OD의 가치를 강조하고 있기에(WHO, 2021), 본 연구 결과는 OD 실행이 당사자의 인권을 보장하는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

본 연구의 참여자들은 OD를 실천하며 주의 깊은 경청과 당사자의 속도에 맞추며 당사자와 네트워크 구성원의 목소리를 존중하고 그들의 자기결정권과 자율성을 촉진하고자 노력하였다. 이러한 과정은 CRPD의 제21조(의사 및 표현의 자유)와 제3조(천부적인 존엄성, 선택의 자유를 포함한 개인의 자율성 및 자립에 대한 존중)와 일치한다. 당사자가 OD를 통해 존엄성과 자율성, 자기결정권을 회복한 경험은 여러 선행 연구에서도 확인할 수 있다. Sidis et al. (2020)은 호주의 젊은 당사자들이 네트워크 모임 동안 자신의 욕구를 표현할 수 있는 힘을 얻었다고 보고하였다. 유사하게, 영국에서 OD를 경험한 당사자는 치료 계획에 참여하고 자신의 정신건강에 대한 욕구를 논의할 수 있었던 경험을 가장 중요하게 여겼다고 보고하였다(Suntharajah et al., 2022). WHO 또한 OD를 당사자의 의사를 존중하는 지원 의사결정 모델로 제안한 바 있다(World Health Organization, 2019, p. 28).

Von Peter et al.(2019)은 OD가 강압적 개입에 미치는 영향을 탐구해야 할 필요성을 제기하였다. 본 연구에서 OD가 다양한 형태의 강압적 개입을 예방할 수 있음을 확인하였으며, 이는 CRPD의 제14조(신체의 자유 및 안전), 제15조(고문 또는 잔혹한, 비인도적이거나 굴욕적인 대우나 처벌로부터의 자유), 제16조(착취, 폭력 및 학대로부터의 자유)와도 부합한다. 선행 연구에서도 이를 뒷받침하는 사례가 보고되었다. 예를 들어, 미국 버몬트주의 한 의료기관에서 OD를 변형하여 적용한 전문가는 OD가 당사자의 자유와 자율성을 침해하지 않으며, 덜 소모적이고 인간적인 접근이라고 평가하였다(Florence et al., 2020). 또한, OD는 유럽평의회(Council of Europe)에서 정신건강 분야의 강압적 방식을 제거하기 위한 인권적인 모범 사례로 소개되었다(Gooding, 2021).

참여자들은 OD 실천이 당사자를 네트워크와 지역사회에 통합하도록 촉진한다는 점도 목격하였다. 이는 CRPD의 제4조(입법과 정책 개발 및 이행 과정에서 장애인의 적극적인 참여와 협력 의무)와 일치한다. 예를 들어, 영국의 한 당사자는 OD 네트워크 모임을 통해 어머니와의 관계를 회복하였으며, 이는 지역사회로의 재통합을 지원하는 파급 효과를 만들어냈다고 묘사하였다(Hodgkins and Debra, 2021).

이러한 발견은 OD가 단순히 정신건강 문제를 해결하는 데 그치지 않고, 개인의 존엄성과 권리를 지지하는 관계와 지원 체계를 촉진할 잠재력을 가지고 있음을 보여준다.

4-3. 팀 및 정책에 대한 논의

제4주제에서는 다양한 수준에서 나타난 도전 과제와 이에 대한 보완 방안이 제시되었다. 우선, 참여자들은 OD 실행 과정에서 경험한 혼란을 극복하기 위한 방안으로 개인적 성찰, 슈퍼비전, 팀 내 연결성의 중요성을 강조하였다. 이는 OD의 지속 가능성을 위해 체계적이고 효과적인 슈퍼비전이 필수적이라는 기존 연구와 맥을 같이한다(Jacobsen et al., 2023). 또한, OD가 상호 수용과 조율을 요구하는 만큼, 팀원 간 신뢰가 필수적이라는 주장과도 일치한다(Lagogianni et al., 2023).

다음으로, 참여자들은 개인적 차원을 넘어 조직 문화 변화의 필요성에 대해 논의하였다. 특히, 병원 환경에서 네트워크 미팅을 실행하는 것이 병원의 위계적 구조와 증상 완화를 주요 목표로 삼는 조직적 특성 때문에 어려웠다고 보고하였다. 이는 OD를 기존 치료 환경에 통합하려 할 때 가정과 가치의 차이가 도전 과제가 될 수 있다는 기존 연구(Ong et al., 2019) 및 정신과 임상 환경에서 학문적 이론과 전문가 중심 모델이 개인의 고통에 적용되는 데 한계가 있을 수 있다는 의견(Sch□tze, 2021)과도 부합한다. 그러나 OD를 병원 환경에 변형된 형태로 적용했을 때 긍정적인 효과가 있었다는 연구도 존재한다(Rosen and Stok-losa, 2016; Ritva et al., 2018). 따라서 OD는 조직의 특성과 상황에 맞게 조정된 형태로 도입될 필요가 있으며(Heumann et al., 2023), 일부 요소만 도입하더라도 충분히 가치 있는 시도가 될 수 있음을 시사한다(Sch□tze, 2021). 이를 위해서는 조직과 리더십 차원의 변화가 요구되며, 조직의 불안과 갈등을 수용하고 이를 점진적으로 해결해나가는 과정이 필수적이라는 점이 제안되었다(Lennon et al., 2023). 이러한 조직적 변화를 이루기 위해 OD 도입을 위한 조직적 기준(Olson, 2021)을 참조하는 것도 유용할 것이다.

더 나아가, 참여자들은 OD를 지원하기 위한 정책적 뒷받침과 예산 확보의 필요성을 강력히 제기하였다. 본 연구의 결과는 이러한 요구를 반영한 정책적 제안의 중요성을 강조하며, OD 실행이 초과 근무로 인한 시간적 부담과 법적 책임 문제를 야기할 수 있다는 질적 분석 결과는 기존 연구와도 일치한다(Heumann et al., 2023). 또한, 공식적인 교육 프로그램 마련, 분절된 서비스 체계에서 심리적 연속성을 유지하기 위한 지침, 지속 가능한 실행을 위한 재정 지원 등도 정책 차원에서 다뤄야 할 주요 과제로 나타났다. 영국 ODDESSI 연구에서 대규모 국가 연구 플랫폼을 통해 교육 및 실행이 이루어진 사례(Razzaque, 2021)와 이탈리아에서 상향식 접근 방식으로 OD를 도입한 사례(Macario et al., 2021; Pocobello et al., 2024)는 이러한 정책 설계를 위한 중요한 참고 사례가 될 수 있다.

이와 같은 다층적인 연구 결과는 정책 기획 시 개인, 조직, 시스템의 세 가지 수준을 통합적으로 고려해야 한다는 기존 제안(Aarons et al., 2011)과도 부합한다. 특히, 한국의 맥락에서는 국가인권위원회의 권고 사항(National Human Rights Commission of Korea, 2021)과 새로운 정신건강정책 혁신계획(Kim, 2023)에 WHO QualityRights가 포함된 점을 고려할 때, 본 연구를 포함한 연구개발(R&D) 프로젝트가 OD 실행을 위한 새로운 플랫폼으로 기능할 잠재력이 있다. QualityRights는 전문가, 당사자, 가족 등 다양한 이해관계자가 협력적으로 참여하는 특성을 가지며, 특정 지역에 적용될 경우 서비스 품질과 인권을 동시에 개선할 수 있음이 입증되었다(Pathare et al., 2021).

마지막으로, 본 연구의 제3주제에서 인권과 관련된 하위 주제가 두드러지게 나타난 것은 본 연구가 단순히 OD 교육에 국한되지 않고, 비강압적 치료(Non-Coercive Treatment) 및 지원의사결정(Supported Decision Making)과 같은 QualityRights 교육과 병행되었기 때문일 가능성이 높다. 또한, QualityRights가 권장하는 혼합 그룹 구성 방식이 워크숍에서 참여자들 간의 연대감을 형성하는 데 중요한 역할을 했을 것으로 보인다. 이는 WHO QualityRights와 OD 간의 상호보완 가능성을 보여주며, 이에 대한 추가적인 연구의 필요성을 시사한다.

5. 연구의 강점과 한계점

본 연구는 다음과 같은 강점을 지닌다. 첫째, 종단적 연구 설계를 통해 워크숍 이후 1년 동안 OD 실천에 대한 참여자들의 경험과 의견 변화를 관찰할 수 있었다. 이를 통해 OD 실천의 장기적 영향을 이해하는 데 중요한 통찰을 제공하였다. 둘째, OD의 핵심 원칙과 요소를 충실히 준수하기 위해, 정식 교육과 강사 훈련을 받은 연구자(SK)가 국제 전문가들의 슈퍼비전을 받으며 시범 운영을 주도하였다. 이는 OD 실천의 일관성과 정확성을 보장하는 데 기여하였다. 셋째, OD와 인권 간의 관계를 탐구한 연구가 거의 없는 상황에서, 본 연구는 OD를 인권 친화적 접근으로서의 가능성을 제시하며 정신건강 서비스에서 그 중요성을 강조하였다.

그러나 본 연구에는 몇 가지 한계점도 존재한다. 첫째, 참여자 수(n)가 적어 양적 결과 해석에 한계가 있었다. 향후 연구에서는 더 큰 표본을 포함하여 통계적 신뢰성과 일반화 가능성을 높이는 것이 필요하다. 둘째, 본 연구에 참여한 기관들은 회복 지향적 문화를 강하게 보유하고 있어, 이는 일반적인 한국의 정신건강 기관을 대표하지 못할 가능성이 있다. 참여자들이 인권 원칙에 익숙한 점이 연구 결과에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다.

셋째, 모든 참여자가 OD를 실천한 것은 아니며, OD를 실천하지 않은 참여자들의 의견은 상대적으로 적게 반영되었다. 이는 OD 적용 과정에서 발생하는 장벽을 충분히 이해하는 데 한계를 초래할 수 있다. 향후 연구에서는 OD를 실천하지 않은 참여자들에 초점을 맞추어 이들이 직면한 도전 과제를 심층적으로 파악할 필요가 있다. 마지막으로, 자원 제약으로 인해 심층 인터뷰를 진행하지 못하였다. 비록 참여자들이 개방형 질문에 상세한 응답을 제공하여 풍부한 연구 결과를 도출할 수 있었으나, 향후 연구에서는 보다 심층적인 결과를 얻기 위해 인터뷰를 포함하는 것이 필요하다.

6. 결론

본 연구는 WHO QualityRights 서비스 패키지의 일환으로 한국에 OD를 공식적으로 도입하기 위한 예비 연구로서 다음과 같은 결론을 도출하였다.

첫째, OD가 핀란드 라플란드에서 성공을 거둔 주요 요인 중 하나는 질 높은 교육으로 지적되고 있으며(Putman, 2021a), OD를 성공적으로 도입하려면 정식 시스템 내에서 대규모 교육이 필수적이다. 이를 위해 OD에 대한 사회적 인식 제고와 이해관계자 간의 합의를 증진하는 노력이 선행되어야 한다. 그러나 OD의 특성상 문헌이나 강의를 통해 핵심 원칙을 효과적으로 전달하기 어렵고, 이는 오해로 인한 혼란이나 저항을 초래할 수 있다는 점이 지적된다(Lorenz-Artz et al., 2023).

둘째, 본 연구는 짧지만 체계적으로 설계된 입문 워크숍이 OD에 익숙하지 않은 참여자들에게 큰 동기부여를 제공할 수 있음을 확인하였다. 또한, 입문 워크숍을 통해 참여자들이 OD의 핵심 학습 요소를 체득하게 하는 방식에 대한 단서를 제공하였다.

셋째, OD 워크숍을 통해 참여자들의 역량이 강화되고 동기부여가 이루어졌으며, 이는 OD 실천뿐만 아니라 전통적인 환경에서의 업무 방식과 팀워크에도 다층적이고 긍정적인 영향을 미쳤다. 특히, 인권적 관점에서 이러한 변화는 가치를 실제 서비스로 전환하는 데 실질적인 시사점을 제공하였다. 이를 통해 본 연구는 OD가 인권 기반 서비스로서의 우수성을 뒷받침하는 새로운 증거를 제공한다.

넷째, 본 연구는 OD가 국가의 R&D 프로젝트를 통해 상향식 정책으로 확산된 새로운 사례로 평가될 수 있으며, OD가 WHO QualityRights 서비스 패키지의 일환으로 도입된 첫 사례라는 점에서도 의의를 가진다. 이러한 독특한 맥락은 OD와 국제 인권 기반 정신건강 프로젝트 간의 상호보완적 잠재력을 제시하는 중요한 시사점을 제공한다.

따라서 본 연구는 한국의 정신건강 서비스 체계에서 OD의 공식적인 교육 프로그램과 실행 지침을 개발하기 위한 기초 자료를 제공함과 동시에, OD의 국제적 확산과 인권 기반 정신건강 서비스로서의 가능성을 뒷받침하는 중요한 근거로 활용될 수 있다.

7. 감사의 말씀

이 프로젝트에 참여해 주신 모든 산 경험을 지닌 당사자와 가족 여러분, 그리고 설운영, 김영희, 하경은, 양명화, 박미애, 소혜진, 백종환, 유안나 님의 연구 기여에 깊이 감사드립니다. 그리고 한국의 퀄리티라이츠 프로젝트를 지원해주신 WHO의 미셸 펑크 박사와 나탈리 드루 님 및 Open Dialogue UK 훈련자 수련의 교수진으로서 한국 워크숍과 연구에 기여해주신 닉 푸트먼과 카리 발타넨 님께도 각별한 감사를 전합니다.

참고문헌

Aarons, G. A., Hurlburt, M., and Horwitz, S. M. (2011). Advancing a conceptual model of evidence-based practice implementation in public service sectors. Adm. Policy Ment. Health 38, 4–23. doi: 10.1007/s10488 -010 -0327-7

Aderhold, V., and Hohn, P. (2021). “Thirteen years of running Open Dialogue foundation training programmes,” in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Anestis, E., Weaver, T., Melia, C., Clarke, K., and Pilling, S. (2024). Becoming an Open Dialogue practitioner: a qualitative study of practitioners’ training experiences and transitioning to practice. Front. Psychol. 15:1432327. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1432327

Bergström, T., Seikkula, J., Alakare, B., Mäki, P., Köngäs-Saviaro, P., Taskila, J. J., et al. (2018). The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: nineteen–year outcomes. Psychiatry Res. 270, 168–175. doi: 10.1016/j.psychres.2018.09.039

Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qual. Res. Psychol. 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa

Brown, J. M. (2023). Open Dialogue and Dialogical Practice. Judith Brown Social Work and Family Therapy Training. Available at: https://www.judithbrownfamilytherapy.com/open-dialogue-introductory-course (accessed July 28, 2024).

Buus, N., Bikic, A., Jacobsen, E. K., Müller-Nielsen, K., Aagaard, J., and Rossen, C. B. (2017). Adapting and implementing Open Dialogue in the Scandinavian countries: a scoping review. Issues Ment. Health Nurs. 38, 391–401. doi: 10.1080/01612840.2016.1269377

Buus, N., Leer, M., Mikes-Liu, K., Dawson, L., Folkmann Pedersen, M., Einboden, R., et al. (2022). Open Dialogue trainees’ expectations of ‘shared concern’: an international focus group study. J. Fam. Ther. 44, 250–263. doi: 10.1111/1467-6427.12365

Buus, N., Ong, B., and McCloughen, A. (2023). Open dialogue trainees’ perspectives on learning processes and psychotherapeutic practice: a prospective focus group study. Fam. Process 62, 993–1005. doi: 10.1111/-famp.12832

Cho, Y. H. (2023). Development and Dissemination of Human Rights Based/Recovery Oriented Mental Health Services in Korea. Available at: https://www.nmhc.or.kr/sub. php?id=nmhc&mode=view&menukey=17&ctgrstr=%EC%A0%95%EC%B1%85%ED%8F%AC%EB%9F%BC&idx=8265&page=1&menukey=17 (accessed April 20, 2024).

Cuffari, E., Fourlas, G., and Whatley, M. (2022). “Bringing new life in”: hope as a know-how of not knowing. Front. Psychol. 13:948317. doi: 10.3389/fpsyg.2022.948317

Dawson, L., River, J., McCloughen, A., and Buus, N. (2021). ‘Should it fit? Yes. Does it fit? No’: exploring the organisational processes of introducing a recovery-oriented approach to mental health in Australian private health care. Health 25, 376–394. doi: 10.1177/1363459319889107

Dialogue (R)Evolution (2022). Open(ing) Dialogues: An International Online Workshop. Dialogue (R)Evolution Collaborative International Training in Open Dialogue and other Dialogical Approaches to Health & Social Care. Available at: https:// dialoguerevolution.com/training/opening-dialogues/ (accessed July 28, 2024).

Florence, A. C., Jordan, G., Yasui, S., and Davidson, L. (2020). Implanting rhizomes in vermont: a qualitative study of how the open dialogue approach was adapted and implemented. Psychiatr. Q. 91, 681–693. doi: 10.1007/s11126-020-09732-7

Funk, M., and Bold, N. D. (2020). WHO’s qualityrights initiative: transforming services and promoting rights in mental health. Health Hum. Rights 22, 69–75.

Gooding, P. (2021). Compendium Report: Good Practices in the Council of Europe to Promote Voluntary Measures in Mental Health: Report Commissioned by the Committee on Bioethics (DH-BIO) of the Council of Europe. London: Council of Europe.

Hendry, A., Corredor, A. M., and Roth, M. (2021). “Reflections from participants on an open dialogue foundation training,” in Open Dialogue for Psychosis (Routledge),128–130. Available at: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351199599-21/reflections-participants -open -dialogue-foundation-trainingalan-hendry-ana- mar%C3%ADa-corredor-mike-roth (accessed April 21, 2024).

Heumann, K., Kuhlmann, M., Böning, M., Tülsner, H., Pocobello, R., Ignatyev, Y., et al. (2023). Implementation of open dialogue in Germany: efforts, challenges, and obstacles. Front. Psychol. 13:1072719. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1072719

Hinshelwood, R. D. (2004). Suffering Insanity; Psychoanalytic Essays on Psychosis. Brunner-Routledge.

Hodgkins, A., and Debra, J. (2021). "Open Dialogue as a point of entry to reconnect to the real world of relationships," in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Jackson, V., and Perry, A. (2015). Communication - A culture of open dialogue. Ther. Commun. 36, 29–35. doi: 10.1108/TC-12-2014-0042

Jacobsen, R. K., Karlsson, B., and Grov, E. K. (2023). Clinicians and supervisors' experiences with developing practices of open dialogue in network meetings in public mental health services. J. Fam. Ther. 45, 197–210. doi: 10.1111/1467-6427.12422

Jonas, K., and Ziegler, R. (2007). "Attitudinal ambivalence," in The Scope of Social Psychology: Theory and Applications, eds M. Hewstone, H. A. W. Schut, J. B. F.

De Wit, K. Van Den Bos, and M. S. Stroebe (New York, NY: Psychology Press), 29–42, 340. Available at: https://www.proquest.com/psycinfo/docview/621624917/9D9C41A0132D4EA3PQ/5?sourcetype=Books (accessed July 22, 2024).

Kim, E. (2023). Will These 4 Countermeasures save South Korea From Mental Illness? KBR. Available at: https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html? idxno=22719 (accessed April 13, 2024).

Kiviniemi, M. (2014). Mortality, Disability, Psychiatric Treatment and Medication in First-Onset Schizophrenia in Finland: The Register Linkage Study. jultika.oulu.fi. Available at : https://oulurepo.oulu.fi/handle/10024/35854 (accessed October 9, 2023).

Lagogianni, C., Georgaca, E., and Christoforidou, D. (2023). Co-therapy in Open Dialogue: transforming therapists' self in a shared space. Front. Psychol. 14:1083502. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1083502

Lennon, E., Hopkins, L., Einboden, R., McCloughen, A., Dawson, L., and Buus, N. (2023). Organizational change in complex systems: organizational and leadership factors in the introduction of Open Dialogue to mental health care services. Community Ment. Health J. 59, 95–104. doi: 10.1007/s10597-022-00984-0

Lorenz-Artz, K., Bierbooms, J., and Bongers, I. (2023). Introducing Peersupported Open Dialogue in changing mental health care. Front. Psychol. 13:1056071. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1056071

Macario, M., Gastaldi, A., and Pezzano, L. R. (2021). "Open Dialogue in the Italian national health service: a view from the borderland 1," in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

National Human Rights Commission of Korea (2021). Human Rights Report for People with Mental Disabilities. Available at: https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/www.humanrights.go.kr (accessed April 13, 2024).

National Mental Health Center of Korea (2023). National Mental Health Statistics 2021 (Korean). Available at: https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/boardView.do?no=9290&fno=106&bn=newsView&menu_cd=04_02_02_04&bno=&pageIndex=1&search_item=&search_content= (accessed April 24, 2024).

Newby-Clark, I. R., McGregor, I., and Zanna, M. P. (2002). Thinking and caring about cognitive inconsistency: when and for whom does attitudinal ambivalence feel uncomfortable? J. Pers. Soc. Psychol. 82, 157–166. doi: 10.1037/0022-3514.82.2.157-166

Olson, M. (2021). "Open Dialogue adherence and fidelity tools," in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Ong, B., Barbara-May, R., Brown, J. M., Dawson, L., Gray, C., McCloughen, A., et al. (2019). Open dialogue: frequently asked questions. Aust. N. Zeal. J. Fam. Therapy 40, 416–428. doi: 10.1002/anzf.1387

Park, J.-D. (2019). "The essence of the korean model of development," in ReInventing Africa's Development: Linking Africa to the Korean Development Model, ed. J.-D. Park (Cham: Springer International Publishing), 207–241.

Pathare, S., Funk, M., Bold, N. D., Chauhan, A., Kalha, J., Krishnamoorthy, S., et al. (2021). Systematic evaluation of the QualityRights programme in public mental health facilities in Gujarat, India. Br. J. Psychiatry 218, 196–203. doi: 10.1192/bjp.2019.138

Pocobello, R., Camilli, F., Alvarez-Monjaras, M., Bergström, T., von Peter, S., Hopfenbeck, M., et al. (2023). Open Dialogue services around the world: a scoping survey exploring organizational characteristics in the implementation of the Open Dialogue approach in mental health services. Front. Psychol. 14:1241936.doi: 10.3389/fpsyg.2023.1241936

Pocobello, R., Camilli, F., Ridente, P., Caloro, G., Balice, M. G., Tibaldi, G., et al. (2024). Evaluating Open Dialogue in Italian mental health services: evidence from a multisite prospective cohort study. Front. Psychol. 15:1428689. doi: 10.3389/fpsyg.2024.1428689

Putman, N. (2021a). "Introducing Open Dialogue training," in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Putman, N. (2021b). "What is Open Dialogue?," in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Razzaque, R. (2021). "The UK ODDESSI trial," in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Razzaque, R., and Wood, L. (2015). Open Dialogue and its Relevance to the NHS: opinions of NHS Staff and Service Users. Commun. Ment. Health J. 51, 931–938. doi: 10.1007/s10597-015-9849-5

Ritva, J., S?rg?rd, J., Karlsson, B. E., Seikkula, J., and Kim, H. S. (2018). “Open Dialogue Behind Locked Doors” - Exploring the Experiences of Patients, Family Members, and Professionals With Network Meetings in a Locked Psychiatric Hospital Unit: A Qualitative Study. Norwegian Society for Psychological Science.

Robertson, S. (2019). Korean Nunchi and well-being. Sci. Relig. Cult. 6, 103–109. doi: 10.17582/journal.src/2019.6.1.103.109

Rosen, K., and Stoklosa, J. (2016). Finland in Boston? Applying open dialogue ideals on a psychotic disorders inpatient teaching unit. PS 67, 1283–1285. doi: 10.1176/appi.ps.201600340

Runciman, O. (2021). “Reflections on participating in the three-year Open Dialogue training,” in Open Dialogue for Psychosis (Routledge), 122–124. Available at : https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351199599-19/reflectionsparticipating-three-year-open-dialogue-training-olga-runciman (accessed April 21, 2024).

Schütze, W. (2021). “The challenge of developing Open Dialogue in hospital settings,” in Open Dialogue for Psychosis, eds. N. Putman and B. Martindale (London: Routledge).

Seikkula, J. (2011). Becoming dialogical: psychotherapy or a way of life? Aust. NZ J. Fam. Ther. 32, 179–193. doi: 10.1375/anft.32.3.179

Seikkula, J., Aaltonen, J., Alakare, B., Haarakangas, K., Keränen, J., and Lehtinen, K. (2006). Five-year experience of first-episode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies. Psychother. Res. 16, 214–228. doi: 10.1080/10503300500268490

Seikkula, J., Alakare, B., and Aaltonen, J. (2001). Open dialogue in psychosis I: an introduction and case illustration. J. Constr. Psychol. 14, 247–265. doi: 10.1080/107205301750433397

Seikkula, J., Alakare, B., Aaltonen, J., Holma, J., Rasinkangas, A., and Lehtinen, V. (2003). Open dialogue approach: treatment principles and preliminary results of a two-year follow-up on first episode schizophrenia. Ethical Hum. Sci. Serv. 5, 163–182. doi: 10.1891/1523-150X.5.3.163

Seikkula, J., and Olson, M. E. (2003). The Open Dialogue approach to acute psychosis: its poetics and micropolitics. Fam. Process 42, 403–418. doi: 10.1111/j.1545-5300.2003.00403.x

Shotter, J. (2007). Not to forget Tom Andersen’s Way of Being Tom Andersen: The Importance of What ‘Just Happens’ to Us. London: Leeds Family Therapy & Research Centre and Kensington Consultation Centre, 15–28.

Sidis, A., Ramirez, J., Dawson, L., River, J., Buus, N., Singh, R., et al. (2020). Not ‘just a talking head’: experiences of Australian public mental health clinicians implementing a dialogical family therapy approach for young people with severe mental health concerns. Aust. New Zeal. J. Fam. Ther. 41, 6–28. doi: 10.1002/anzf. 1407

Skourteli, M. C., Issari, P., Dimou, L., Antonopoulou, A. O. A., Bairami, G., Stefanidou, A., et al. (2023). The introduction and implementation of open dialogue in a day center in Athens, Greece: experiences and reflections of mental health professionals. Front. Psychol. 14:1074203. doi: 10.3389/fpsyg.2023.10 74203

Søndergaard, K. D. (2010). Innovating Mental Health Care: A Configurative Case Study in Intangible, Incoherent and Multiple Efforts. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Stockmann, T., Wood, L., Enache, G., Withers, F., Gavaghan, L., and Razzaque, R. (2019). Peer-supported Open Dialogue: a thematic analysis of trainee perspectives on the approach and training. J. Mental Health 28, 312–318. doi: 10.1080/09638237.2017.1340609

Suntharajah, S., Clarke, K., Razzaque, R., Chmielowska, M., Brandrett, B., and Pilling, S. (2022). Exploring patients’ experience of peer-supported open dialogue and standard care following a mental health crisis: qualitative 3-month follow-up study. BJPsych Open 8:e139. doi: 10.1192/bjo.2022.542 Thorley, C., Brown, J. M., Kurtti, M., and Taylor, A. (2023). Training in Open Dialogue and Dialogical Practice: creatively responding as trainers and writers. Front. Psychol. 14:1174680. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1174680

Training Course at Yale University | Institute For Dialogic Practice (2022). Available at: https://www.dialogicpractice.net/courses/intro-intensive-dialogicpractice/ (accessed July 5, 2024).

Tribe, R. H., Freeman, A. M., Livingstone, S., Stott, J. C. H., and Pilling, S. (2019). Open dialogue in the UK: qualitative study. BJPsych Open 5:e49. doi: 10.1192/bjo.2019.38

Von Peter, S., Aderhold, V., Cubellis, L., Bergström, T., Stastny, P., Seikkula, J., et al. (2019). Open dialogue as a human rights-aligned approach. Front. Psychiatry 10:387. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00387

Wates, A., Allen, J., Cooke, A., and Holttum, S. (2022). “I’ve lived that thing that we do with families”: understanding the experiences of practitioners’ undertaking a three-year Open Dialogue UK Training Programme. Community Ment. Health J. 58, 788–798. doi: 10.1007/s10597-021-00885-8

Weber, K., and Johansen, L. (2007). Åben Dialog-nu og i fremtiden?: Erfaringer med at indføre elementer af Åben Dialog-tænkningen i sygehuspsykiatrien 2004-06. Roskilde Universitet. Available at: https://forskning.ruc.dk/en/publications/%C3%A5bendialog-nu-og-i-fremtiden-erfaringer-med-at-indf%C3%B8re-elementer (accessed April 21, 2024).

WHO (2021). Guidance on Community Mental Health Services: Promoting person-CENTRED and Rights-based Approaches. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 (accessed April 27,2024).

World Health Organization (2019). Human Rights: WHO QualityRights Core Training - for All Services and all People: Course Guide. Geneva: World Health

Organization. Available at: https://iris.who.int/handle/10665/329538 (accessed April 21, 2024).

Yoon, J. (2023). Employment Insecurity, Work Overload... “Mental Health Centers” With Holes [In-depth Feature - Shaking up the National Mental Health Care System]. Segyeilbo. Available at: https://www.segye.com/view/20230424514570 (accessed April 13, 2024).

부 록 2.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?



본 발표문은 아주대병원/이음병원의 한국보건산업진흥원 연구개발진과 한국오픈다이얼로그학회의 협조로 만들었습니다.

우리나라 최초로 정신장애 당사자 및 가족을 상대로 시행된 오픈 다이얼로그의 효과와 가족 반응을 측정하기 위해 면접조사 방식으로 제작하였습니다.

본 자료는 학술자료가 아닌, 추후 한국형 오픈 다이얼로그의 정착을 위한 기초 조사 자료임을 밝힙니다.

정신장애인 가족이 오픈 다이얼로그를 체험한 가족을 상대로 면접 조사하고 작성하였습니다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

찾아가는 열린 대화 서비스, 오픈 다이얼로그 경험 가족 인터뷰

오픈 다이얼로그 실행

- 대상자 : 초발 정신증 당사자 / 가족(부, 모, 형제)
- 사례자 : 오픈 다이얼로그 네트워크팀(정신과 의사, 정신건강간호사, 사회복지사 등)
- 방식, 횟수 : 가정방문 또는 병원 내원 / 7회~22회(회당 1시간 30분)

인터뷰 가족

- 조사대상 : 6 가정 11명
- 인터뷰 참여 : 5가정 (부, 모,누나) 10명
- 인터뷰 방식 : 비대면 전화 인터뷰
- 인터뷰 시간 : 1인당 1시간~1시간 30분

가족 인터뷰 9가지 질문 유형

1	오픈 다이얼로그 에 참여하게 된 계기는 무엇입니까?
2	당사자의 증상과 가족의 심경은 어떠했나요?
3	가족으로서 가장 걱정되었던 점은 무엇이었나요?
4	오픈 다이얼로그를 진행하면서 당신을 변화시켰던 점은 무엇이었나요?
5	오픈 다이얼로그 진행하면서 당사자의 반응과 달라진 점은 무엇이었나요?
6	당신을 감동시켰거나 인상 깊은 장면은 어떤 것입니까?
7	오픈 다이얼로그와 일반 대화 방식은 무엇이 다른가요?
8	오픈 다이얼로그를 어떻게 진행했으면 하는 바램이 있습니까?
9	다른 가족들에게 오픈 다이얼로그를 어떻게 말씀하실 건가요?

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

Q1. 오픈 다이얼로그에 참여하게 된 계기는?

- 이음병원 입원, 가족치료를 받던 중 신청
- 주치의 여의사의 소개로 신청
- 인터넷에서 무료 상담할 곳을 찾다가 <정신건강가족학교> 소개 글을 보고 신청
- 국립정신건강센터에서 김성수 원장님 강의를 듣고 원장께 신청
- 수원시성인정신건강복지센터 통해서 신청

Q2. 당사자의 증상과 가족의 심경은?

- 딸이 중학교 때부터 우울증으로 학교에 결근하며 비행청소년으로 탈선(문신,담배,불량 교우) 이상 행동으로 발전, 집에서 고립, 부모 대화 중단 (분노/혼란/수치심)
- 아들이 고등학교 때부터 우울증으로 약물치료 중 대인기피, 환시, 환청으로 부모에게 고함
  욕설을 하며 치료거부, 약도 안 먹는다 (암담함/ 죄책감/ 불안감)
- 아들이 군 제대 후 사이비 종교에 빠져 이상 행동, 잠 못 자고 불안, 초조 직장에서 퇴사 당하고 집에 고립, 고함, 욕설, 물건 집어 던지는 등 이상행동 (불안/당혹/ 좌절감)
- 아들이 우울증으로 직장 퇴사, 스스로 고치겠다며 약 복용 중단, 병원 진료도 거부. 냉장고 소리, 너무 시끄럽다며 고통을 호소, 아들은 입원, 퇴원 후 집에 고립(혼란/절실함)
- 아들이 팔이 아프다며 정형외과 진료, 복합통증증후군으로 판명, 지속적으로 팔이 아프다며 팔을 잘라 달라고 호소 끝에 조현병으로 발전함 (경악/ 혼란/ 불안감)

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

Q3. 가족으로서 무엇이 가장 걱정되었나요?

- 딸이 가출하여 비행 청소년들과 어울리며 회복할 수 없을 정도로 망가지는 현실에 절망했다. 가정에 복귀할 수 없다는 것이 두려웠다.
- 아들이 교회에 빠져서 카드 발급을 해야 한다며 잠을 못 자고 혼자 중얼거릴 때, 혼란스러웠다. 소리지르고 물건 던질 때 극심한 충격을 받았다.
- 아들이 치료를 거부하고 병원에 가지 않아서 강제입원을 시켰으나 퇴원 후 어떻게 할 것인가, 걷잡을 수 없고, 대책 없는 암담한 사태에 두려움을 느꼈다.
- 아들은 누군가가 미행하고 감시한다고 망상을 갖고 있었으며 엄마를 원망하고 불특정 대상을 향해 욕설과 고함을 치는 등 거친 행동을 하고, 어떻게 할 것인지, 홀어머니로서 말할 수 없이 참담하고 괴로웠다.
- 약물과 입원 위주로 환자의 상태가 나아지지 않음. 대화치료를 해보자고 결심하였음. 노력해서 나아질까. 이대로 희망 없는 삶을 살아나가야 하는 절망감 때문에 힘들었다.

Q4. 오픈 다이얼로그를 진행하면서 당신을 변화시켰던 점은 무엇입니까?

- 존경과 동등의 대화를 통해 딸이 그동안 무척 상처를 받았다는 사실을 절감했다. 기다리고 이해하는 가족의 역할이 얼마나 중요한지를 깨닫게 되었다. (딸의 입장에서 대화 가능)
- 아버지로서 반성을 했다. 애당초 저렇게 했으면 좋았을 걸, 아버지 때문에 고통이 컸구나. 아들이 고통을 겪는 한<인간>으로 다시 보여졌다. –(후회, 자책)
- 팀원들의 따뜻한 말에 울음이 왈칵 터져 나왔다. 따뜻하고 자애로운 기운이었다. 그동안의 사태에 대해서 모든 것을 이해할 수 있게 되었다. (수용/ 감동/감사)
- 정신질병과 아들과 세상을 깊이 이해하게 되었다. 정신증은 참된 대화를 통해 나을 수 있다는 강한 신념을 얻을 수 있었다.
- 아직은 잘 모르겠다. 그러나 무언가 변할 것이라는 기대감은 있다.
- 100% 신뢰는 아니지만 환자가 조금 변할 수도 있겠다 싶었다. 자책감이나 무거운 마음에서 조금 벗어날 수 있었다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

Q5.
오픈 다이얼로그가 진행되면서 당사자의 반응과 달라진 점은?

- 딸이 오픈 다이얼로그가 진행되면서 딸이 차츰 말을 많이 했다.
  (대화 참여/ 자기 심경 토로)
  알바를 하고 운동(수영/헬스/요가)도 시작함. 베트남 가족여행 계획 중
- 아들이 자기 병에 대해 스스로 인식하고 고치려고 노력한다.
  환청은 사라짐(가끔 우울,불안) 산책하고 먹고 싶은 것도 요구한다.
  (오픈 다이얼로그가 죽은 내 아들을 살렸다)
- 두 번째 모임부터는 자기 증상에 관해 토로/ 오픈 다이얼로그 시작 전 스스로 질문 사항을 메모하여 준비함/ 엄마와 명상, 산책도 함
  증상이 많이 사라지고 좋아짐
- 처음에는 거부 반응, 아들이 대화할 때는 유순하게 말을 하다가도 팀원들이 가고 나면 욕설, 소리친다.
- 아들이 무기력하게 누워있지만, 방문을 열어놓고 대화에 귀를 기울이며 듣고 있다.

Q6.
당신을 감동시켰거나 인상 깊은 장면은 무엇인가요?

- 팀원들이 조언이나 단정짓지 않고 사려 깊게 경청하는 자세에 감동했다.
- 팀원들이 한 번도 눈을 떼지 않고 그윽하게 바라보는 시선이 더없이 따뜻하고 평온했다.
- 나이 드신 부장 간호사님이 "얼마나 힘들었냐 " 고 물었을 때, 천상에서 구원의 천사를 만난 느낌, 왈칵 울음이 터져 나왔다.
  (캄캄한 절벽에서 환한 빛을 보는 느낌)
- 우리 이야기를 듣고 간간히 팀원들 끼리 느낌, 소감, 등을 말할 때, 우리의 말을 그들이 얼마나 세심하고 주의 깊게 경청하는지 알고 감동했다.
- 대화를 어떻게 하는 것인지, 경청과 존중이 무엇인지, 팀원들의 인내심은 대단했다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

Q7.
오픈 다이얼로그가 일반 대화방식하고 무엇이 달랐나요?

- 질병에 대한 정답을 주거나 설득을 하지 않고 대화를 통하여 스스로 인식하고 깨우치게끔 만든다는 점에서 상담이나 대화하고 달랐다.
- 팀원들은 무엇도 요구하거나 지시하지 않았다. 그럼에도 나는 강한 믿음이 생겼다
- 그 어느 대화보다 따뜻하고 친밀감을 느낄 수 있었다. 평온한 분위기에서 누구에게도 말하지 못했던 이야기들을 나눌 수 있었다.
- 끝까지 기다려주면서 대화를 지속하는 점이 달랐다.
- 너무 느리게 이야기만을 반복하는 것이 지루한 적도 있었다. 처방이나 안내 같은 것이 없어서 답답한 면이 없지 않았다.

Q8.
오픈 다이얼로그를 어떻게 진행했으면 하는 바램이 있습니까?

- 가족에게 오픈 다이얼로그 진행과 절차 등에 대해 사전에 말해주면 어떨까 하는 생각입니다.
- 없습니다, 팀원들이 집까지 방문해서 대화를 해 주셔서 감사할 따름입니다.
- 내 아들이 좋아졌는데 그저 감사한 마음입니다.
- 오픈 다이얼로그가 어느 정도 패턴(반구조화)를 가졌으면 어떨까 합니다. 예를 들어 얼마동안 언제까지 할 것인지 등, 오픈 다이얼로그 종료 단계에서 피드백 시간을 갖는 것은 어떤가요?
- 정말 고맙고 감사하다. 1시간 30분은 너무 짧다 2시간 정도 하면 어떨까?

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

Q9.
다른 가족들에게 오픈 다이얼로그를 어떻게 말씀 하실 건가요?

- 오픈 다이얼로그는 의사.간호사, 임상심리사,가족, 지인이 협력해서 나를 돕는 거예요. 정신질환에는 이런 대화 치료가 꼭 필요해요.
- 따뜻하고 친밀한 대화로 상처를 아물게 해주고, 과거의 충격에서 벗어나 나를 찾게 되는 것 같아요.
- 아이가 환각, 환청이 줄었습니다. 외롭고 고통스러웠던 나 자신에게도 큰 위로가 되었습니다.
- 오픈 다이얼로그는 꼭 필요합니다. 오픈 다이얼로그가 있어야 약물치료도 성공할 수 있습니다.
- 오픈 다이얼로그에 나가서 똑같은 이야기만 한다. 이제 더 할 이야기도 없다고 아들이 토로한다. 그렇지만 이제 엄마하고 많은 이야기를 하고 있어요.
- 대화로서 모든 것이 해결된다고는 생각하지 않아요. 그러나 심리치료는 필요하다고 봅니다.

오픈 다이얼로그 체험 가족 진술 분석(종합)

"대화를 통한 인간 본위의 치료방식은 신선한 감동으로 다가왔다."

- 오픈 다이얼로그로 인한 변화는 당사자보다 가족의 변화가 더 컸다.
- 치료팀과의 진솔하고 평등의 대화에서 서로의 상처와 고통에 대해 이해하게 되었다.
- 회피하고 싶은 현실을 긍정적으로 수용하고 자기 해방의 길을 모색하게 되었다.
- 가족과 당사자의 관계가 복원되었고, 치료팀에 대한 감사, 신뢰, 안정감이 형성되었다.
- 눈에 띄는 당사자의 변화는 없는 경우에도 기대와 희망을 버리지 않았다.
- 오픈 다이얼로그 서비스 결과 실패한 사례는 발견하지 못했다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

오픈 다이얼로그의 과제(한국형 오픈 다이얼로그)

"경험해보지 못한 대화치료, 처음 적응이 힘들었다."

- 대화를 거부하는 당사자를 설득해서 모임에 이끌기가 힘겨웠다.
- 부모에게 반감을 가진 당사자 앞에서 솔직한 심경을 토로하는 것이 부담스러웠다.
- 당사자가 약물 치료를 거부하고 오픈 다이얼로그만 하겠다고 한다면 어떡할까.
- 약물치료와 대화치료의 차이와 효과에 대해서 자세한 설명이 있으면 좋겠다.
- 눈에 띄는 당사자의 변화는 없는 경우에도 기대와 희망을 버리지 않았다.
- 오픈 다이얼로그를 언제까지 지속하는지, 기간, 절차 등에 대해 통일된 방식(패턴)이 있으면 좋겠다.

오픈 다이얼로그 제 1모형 / 회복 상승형 60%

- 당사자는 자아를 인식하고 스스로 치유방식을 모색하게 되었다.
- 가족(아버지/어머니)는 자녀와의 대화를 통해 상대의 고통과 상처를 이해.
- 가족은 오픈 다이얼로그를 통해서 비로소 자녀와 대화가 가능해졌다.
- 당사자는 가족과 해외 여행을 계획하고 명상과 산책도 함께 함.
- 가족은 오픈 다이얼로그를 통해 진정한 대화와 경청의 방식을 배웠다고 함.
- 당사자는 횟수가 거듭할수록 느낌. 자기견해, 겪고 있는 고통에 대해 토로함 .

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

오픈 다이얼로그 제 2모형 / 점진적 상승형 20%

- 오픈 다이얼로그 20회 차가 넘어가면서 아들이 자기 병에 대해 이해했다.
- 아직은 아들과 정상적인 대화는 못하지만 가능하리라는 믿음이 생겼다.
- 아들이 오픈 다이얼로그가 끝나면 다시 욕설과 고함을 쳤다.
  최근에는 스스로 진료받고 약을 먹으며 점차 증상이 나아졌다.
- 오픈 다이얼로그를 거듭하면서 아들과 대화하는 방법을 배우게 되었다.
- 아들이 오픈 다이얼로그에서 이제 더 할 이야기도 없다고 한다.
  그러나 엄마하고 이야기를 많이 하곤 한다.
- 가능하다면 오픈 다이얼로그를 계속하고 싶다.

오픈 다이얼로그 제 3모형 / 정제형 20%

- 오픈 다이얼로그를 10회 이상 받고 있지만 아직 아들은 뚜렷한 변화가 없다.
- 단지 살기 위해서 오픈 다이얼로그를 택했다. 너무 힘들었다.
- 이 고통에서 해방되었으면 좋겠다. 계속하면 좀 나아질까?
- 낮과 밤이 바뀐 아들이 오픈 다이얼로그를 힘들어 한다.
  그래서 문을 열고 오픈 다이얼로그를 하고, 그래도 아들은 자기 방에 누워서 듣고 있다 .
- 오픈 다이얼로그를 하는 날에는 직장에서 조퇴하고 온다. 최선을 다하고 있다.
- 나아진다는 보장이나 희망이 있을까? 심리치료에 대한 막연한 기대감은 있다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

오픈 다이얼로그가 무엇이라고 말하겠습니까?

"오픈 다이얼로그, 이런 대회치료는 꼭 정착되어야 합니다."

- 여러 사람이 함께 하는 따뜻하고 친밀한 대화로 상처를 아물게 해주고, 새로운 삶을 찾아 나가는 것입니다, 이것이 진정한 치유가 아닐까요?
- 서로의 심경을 토로하고 상대를 이해하는 대화가 사람의 정신을 살린다는 것을 느꼈어요.
- 외롭고 고통스러웠던 나 자신에게도 큰 위로가 되었습니다. 정말 좋았어요.
- 오픈 다이얼로그는 꼭 필요합니다, 그래야 약물치료도 성공할 수 있습니다.
- 아직은 잘 모르겠지만, 지속적으로 한다면 나아질 것이라고 본다.

가족이 체감한 오픈 다이얼로그

"오픈 다이얼로그 치료팀의 존중과 경청의 대화 방식에 감동했다."

- 상담과 처방보다 평등한 관계에서 이루어지는 대화가 얼마나 중요한지 알게 되었다.
- 이해하고 기다리는 가족의 역할이 어떤 것인지 깨달았다.
- 오픈 다이얼로그가 무엇인지 아직은 잘 모르겠다. 심리치료라고 본다.
- 아버지로서 반성했다. 애당초 저렇게 대해주었으면 좋았을 걸, 나 때문에 고생이 많았다.
- 약물 외에 다른 방법은 없는지 고민했는데 어느 정도 답을 찾은 것 같다. 고맙다.
- 한 시간 반은 너무 짧다. 두 시간하면 안 될까. 동료지원가, 가족이 참여해서 그들의 이야기를 들려주었으면 한다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

오픈 다이얼로그에 대한 주관적 해석과 견해

"오픈 다이얼로그 '완성'이 아니라 '현재 진행형'이다."

- 오픈 다이얼로그는 <목적>이 아니라 <과정>과 <흐름>이라고 볼 수 있다.
  (오픈 다이얼로그는 성취의 결과가 아니라 변화의 첫 걸음이다)
- 정신증 치료에 있어 오픈 다이얼로그가 유일하고 획기적인 치료 방식은 아니다.
- 변화는 개인의 개성과 성향, 증상과 환경적 요소에 따라 효과는 다를 수 있다.
- 오픈 다이얼로그로 인해 변화는 감지할 수 있는 것도 있고 아닌 것도 있었다.
- 오픈 다이얼로그는 내 안의 그림자를 대면하고 자아를 찾아가는 여정이라 볼 수 있다.
- 오픈 다이얼로그는 억눌린 내면의 목소리를 청취하고 상호 교감하는 작용이다.

오픈 다이얼로그 가족 인터뷰를 마치면서

오픈 다이얼로그는 억압받는 어떤 힘에 의해 목소리를 내기 어렵거나 외면당한,
묻혀버린 사람들의 이야기를 듣는 것이다.
가족은 음화 속의 주인공처럼 희미하게 살아남은 사람들처럼 보여졌다.

그들과 인터뷰 중 까맣게 잊었다고 생각했던 지난 날 나의 고통의 흔적들이 되살아나 울컥거렸다.
그 당시 오픈 다이얼로그를 접할 수 없었던 나의 불운을 생각했다.

인간의 불완전과 불가능 속에서, 그 숨막히는 육체에서 벗어나려는 영혼들의 목소리를
누가 들어줄 수 있을까?를 생각했다.

우리는 그들의 사적인 사랑, 슬픔, 열망과 괴로움과 상처들을 응시하고 응답하는 것이다.
오픈 다이얼로그가 인간의 정신적인 모든 문제를 해결해줄 수는 없다.
그러나 우리는 무언가 대단히 중요한 것을 경험하고 있다는 것은 알 수 있었다.

15 가족은 오픈 다이얼로그를 무엇이라고 말하는가?

맺 음 말

오픈 다이얼로그 치유는 인문적 시선의 회복입니다.

인문적 시선은 내면세계에 대한 깊은 통찰입니다.
존엄과 경청에 달하지 않고는 인간의 정서적이고 정신적인 장애
(고통)를 이해할 수 없다고 봅니다.

우리는 '고통'에 대해서 상호간이 문제에 대한 이야기를
하는 것이 막강한 힘을 갖는다는 것을 발견할 수 있었습니다.

우리에게 가장 큰 힘, 의미를 갖는 것은 내면의 변화로부터 올라옵니다.

오픈 다이얼로그, 지속할 수 있다면, 아니 지속되어야 합니다.

대표저자

김성수 정신과전문의
오픈 다이얼로그 국제 훈련자 · 지도자
다원정신건강의학과

공동저자

조순이 정신건강간호사 / 이음병원

조용혁 정신과전문의 / 아주의대 정신건강의학과 교수

노재성 정신과전문의 / 아주의대 정신건강의학과 교수

정성권 정신과전문의 / 이음병원 병원장

김신권 아주의대 인문사회의학 교수

설운영 작가 / 가족활동가 / 수원시정신건강가족학교장

발 행 일 : 2025.03.28.
발 행 인 : 노재성, 정성권
디 자 인 : 신민하
발 행 처 : 한국보건산업진흥원
아주대학교병원
이음병원
홈페이지 : https://blog.naver.com/opendialoguekorea
대표메일 : mindtrek@hanmail.net

본 연구는 보건복지부의 재원으로 한국보건산업진흥원의 보건의료기술 연구개발사업 지원에 의하여 이루어진 것임 (과제고유번호 : RS-2022-KH126432)

This research was supported by a grant of the Korea Health Technology R&D Project through the Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), funded by the Ministry of Health & Welfare, Republic of Korea (grant number : RS-2022-KH126432).

KHIDI
한국보건산업진흥원

세계보건기구 퀄리티라이츠에 기반한 치료친화적 환경조성을 위한 인권중심 중재기술개발